



ASUHAN KEBIDANAN PADA KESEHATAN REPRODUKSI

Dr. Festy Mahanani M, SST.,MPH
Rosyati Pastuty, S.SIT, M.Kes
Yunida Turisna Octavia, S.KM. MKM
Rizka Ayu Setyani, SST, MPH.
Nina Hidayatunnikmah, S.Keb., BD.Mkes
Astin Nur Hanifah, SST, M.Kes
Jusni, SST., M.Kes
Bd. Fauziah Winda Gurnita, M.Tr.Keb
Erna Kusumawati, S.ST. M.Kes
Siti Istiana, S.SiT.M.Kes
Maratusholikhah Nurtyas, SST, M.Kes

ASUHAN KEBIDANAN PADA KESEHATAN REPRODUKSI

Dr. Festy Mahanani M, SST.,MPH

Rosyati Pastuty, S.SIT, M.Kes

Yunida Turisna Octavia, S.KM. MKM

Rizka Ayu Setyani, SST, MPH.

Nina Hidayatunnikmah, S.Keb., BD.Mkes

Astin Nur Hanifah, SST, M.Kes

Jusni, SST., M.Kes

Bd. Fauziah Winda Gurnita, M.Tr.Keb

Erna Kusumawati, S.ST. M.Kes

Siti Istiana, S.SiT.M.Kes

Maratusholikhah Nurtyas, SST, M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

ASUHAN KEBIDANAN PADA KESEHATAN REPRODUKSI

Penulis:

Dr. Festy Mahanani M, SST.,MPH
Rosyati Pastuty, S.SIT, M.Kes
Yunida Turisna Octavia, S.KM. MKM
Rizka Ayu Setyani, SST, MPH.
Nina Hidayatunnikmah, S.Keb., BD.Mkes
Astin Nur Hanifah, SST, M.Kes
Jusni, SST., M.Kes
Bd. Fauziah Winda Gurnita, M.Tr.Keb
Erna Kusumawati, S.ST. M.Kes
Siti Istiana, S.SiT.M.Kes
Maratusholikhah Nurtyas, SST, M.Kes

Desain Cover:

Aldian Shobari

Tata Letak:

Siti Hartina Fatimah

Achmad Faisal

Editor:

ISBN:

978-623-88659-5-6

Cetakan Pertama:

April, 2023

Hak Cipta 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website: www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena buku ini telah selesai disusun. Buku ini disusun agar dapat memberikan kontribusi Asuhan Kebidanan Pada Kesehatan Reproduksi.

Penulis pun menyadari jika didalam penyusunan buku ini mempunyai kekurangan, namun penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi pembaca.

Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk penulis ke depannya.

Semarang, November 2022

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga buku “Asuhan Kebidanan Pada Kesehatan Reproduksi” telah tersusun.

Buku ini menyajikan hasil dari serangkaian kegiatan penelitian yang original, mendalam dan menyeluruh pada satu cabang ilmu, yang substansi pembahasannya dalam satu cabang ilmu dan bisa menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan. Dalam penulisan kali ini terkait dengan Kesehatan reproduksi.

Selama proses penyusunan buku ini, banyak pihak yang telah berkontribusi. Semoga segala bentuk kontribusi yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan yang Maha Pemurah.

Oleh karenanya, dengan diadakannya penulisan buku ini, diharapkan semakin bermunculan karya-karya dosen dalam bentuk buku, yang telah memenuhi standar-standar nasional, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin sivitas akademika baik di dunia kebidanan sampai ke Masyarakat luas.

Saran dan masukan dari semua pihak agar buku ini menjadi jauh lebih sempurna sangat kami harapkan.

November, 2022

Penulis

BAB 1

MODEL PROMOSI KESEHATAN

PENGENDALIAN IMS PEREMPUAN PEKERJA

SEKSUAL TIDAK LANGSUNG

Dr. Festy Mahanani M, SST.MPH



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**MODEL PROMOSI KESEHATAN PENGENDALIAN
IMS PEREMPUAN PEKERJA SEKSUAL TIDAK LANGSUNG***Dr. Festy Mahanani M, SST.MPH*

A. Latar Belakang

HIV dan AIDS pertama kali ditemukan di Asia sekitar tahun 1980-an. Sejak saat itu, lebih dari 6 juta orang di kawasan Asia terinfeksi HIV. Hubungan heteroseksual (*heteroseksual intercourse*), khususnya pada pria yang berhubungan seksual dengan pekerja seks perempuan, telah ditemukan menjadi bentuk transmisi utama penyakit tersebut. Saat ini prevalensi HIV & AIDS meningkat dengan cepat. Pada tahun 2000 diperkirakan di Asia lebih dari 500.000 orang meninggal karena AIDS, yaitu sekitar 1500 orang meninggal per hari (Scheibe, Drame and Shannon, 2019).

Estimasi jumlah orang terkena IMS yang dapat diobati (*Curable Sexually Transmitted Infections*) sekitar lebih dari 30 juta kasus setiap tahunnya. Tahun 2006 diperkirakan terdapat 8,6 juta orang yang positif HIV (ODHA) di Asia Tenggara, termasuk 960.000 orang yang baru terinfeksi (kasus baru) pada tahun sebelumnya. Diperkirakan sekitar 630.000 orang telah meninggal karena penyakit yang berhubungan dengan AIDS. Sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun (2016-2020) terdapat peningkatan kasus sebesar 130.000 orang yang meninggal karena AIDS (Deuba *et al.*, 2016).

HIV/ AIDS merupakan salah satu kondisi keparahan terus menjadi masalah kesehatan global. Meskipun telah ada kemajuan dalam pemahaman ilmiah tentang HIV dan pencegahannya, kebanyakan orang masih hidup dalam HIV ataupun menjadi penderita baru. Menurut laporan WHO (2016), secara global pada tahun 2015 terdapat sekitar 36,7 (34.0 – 39.8) juta orang yang hidup dengan HIV dimana 2.1 (1.8-2.4) juta jiwa merupakan penderita yang baru terinfeksi HIV. Pada tahun yang sama 1,1 juta orang meninggal akibat penyakit HIV/AIDS. Sebagian besar jumlah ini hidup di Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dilaporkan bahwa wilayah sub sahara Afrika merupakan wilayah yang paling besar terkena dampak penularan tsb dengan 25.6 (23.1 – 28.5) juta orang hidup dengan HIV pada tahun 2015.

Di Indonesia HIV/AIDS Pertama kali ditemukan di Propinsi Bali pada tahun 1987. Hingga Saat ini HIV/AIDS telah menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah bekerjasama dengan berbagai lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS namun laporan jumlah penderita maupun kematian HIV/AIDS masih relatif tinggi (Januraga *et al.*, 2020).

Tabel 1.1

Jumlah kumulatif Kasus AIDS Menurut Faktor Resiko s/d Juni 2020 di Indonesia

Faktor Resiko	Jumlah AIDS (Orang)
a. Heteroseksual	34.187
b. Homo-biseksual	1.298
c. IDU	8.451
d. Transfusi Darah	129
e. Transfusi Perinatal	1.499
f. Tidak Diketahui	9.532

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2020; <http://spiritia.or.id>

Merebaknya epidemic HIV dan AIDS telah menjadi permasalahan dunia yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dunia, mulai dari Negara, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Masyarakat internasional dan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Epidemik HIV/AIDS ini terkonsentrasi di negara berkembang seperti benua Afrika dan Asia. Keseriusan dunia dalam menanggulangi HIV/AIDS tercetus dalam tujuan SDG'S (Sultana, 2015).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah karakteristik perempuan pekerja seksual tidak langsung dalam pengendalian IMS, HIV dan AIDS di Kabupaten Semarang?
2. Mengapa perempuan di Pub, Karaoke, dan Cafe berperilaku sebagai perempuan pekerja seksual tidak langsung di Kabupaten Semarang?
3. Bagaimanakah persepsi perempuan pekerja seksual tidak langsung dalam Pengendalian IMS, HIV dan AIDS di Kabupaten Semarang?
4. Bagaimanakah peran *stakeholder* pemerintah dan *stakeholder* masyarakat pada *bounding*, *bridging*, serta *linking* perempuan pekerja seksual tidak langsung dalam upaya pengendalian IMS, HIV dan AIDS di Kabupaten Semarang?
5. Bagaimanakah dimensi peran *stakeholders* Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Dinas Kesehatan, PKBI, dan KPA) dalam pengendalian IMS HIV AIDS?
6. Bagaimanakah model pemberdayaan perempuan pekerja seksual tidak langsung dalam upaya promosi kesehatan pengendalian IMS HIV AIDS berbasis integrasi untuk perubahan perilaku sehat?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku perempuan pekerja seksual tidak langsung terhadap pencegahan IMS HIV dan AIDS, beberapa dimensi yang berperan baik internal, eksternal, maupun peran integratif eksternal pada perempuan pekerja seksual tidak langsung, termasuk

lembaga terkait sebagai wadah peduli kesehatan reproduksi, serta menyusun model promosi kesehatan strategi promosi kesehatan untuk pengendalian IMS HIV dan AIDS perempuan pekerja seksual tidak langsung berbasis integrasi.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis karakteristik perempuan pekerja seksual tidak langsung Terhadap Pencegahan IMS, HIV dan AIDS di Kabupaten Semarang
- b. Untuk menganalisis perempuan di Pub, Karaoke, dan Cafe berperilaku sebagai perempuan pekerja seksual tidak langsung di Kabupaten Semarang
- c. Untuk menganalisis persepsi perempuan pekerja seksual tidak langsung dalam pencegahan IMS, HIV dan AIDS di Kabupaten Semarang
- d. Menganalisis Bagaimana peran stakeholder pemerintah dan stakeholder masyarakat pada *bounding, bridging, linking* perempuan pekerja seksual tidak langsung dalam pengendalian IMS, HIV dan AIDS di Kabupaten Semarang
- e. Menganalisis dimensi peran *Stakeholders* Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Dinas Kesehatan, PKBI, dan KPA) dalam pencegahan IMS HIV AIDS
- f. Merumuskan model promosi kesehatan pada upaya pencegahan IMS dan HIV AIDS pada perempuan pekerja seksual tidak langsung berbasis sinergitas peran stakeholder Kabupaten Semarang yang dapat dilakukan masa yang akan datang.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berkisar pada berbagai permasalahan fenomena sosial, berupa perilaku pekerja seksual tidak langsung dalam pengendalian IMS, HIV dan AIDS dan beberapa dimensi yang berperan, serta susunan model pemberdayaan dalam pengendalian IMS HIV dan AIDS. Hal ini sesuai dengan uraian Bungin (2007), bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian dengan seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan di lapangan kemudian dianalisis dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan yang diamati.

E. Tinjauan Promosi Kesehatan

1. Pengertian Promosi Kesehatan

WHO (2016) merumuskan promosi kesehatan sebagai *“health promotion enables people to increase control over their own health. It covers a wide range of social and environmental interventions that are designed to benefit and protect individual people’s health and quality of life by addressing and preventing the root causes of ill health, not just focusing on treatment and cure”*.

Dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan agar tercegah dari penyakit, sehingga dapat diartikan esensi promosi kesehatan adalah pendidikan dan pemberdayaan.

Berdasarkan Konferensi International Promosi Kesehatan I di Ottawa pada tahun 1986, promosi kesehatan adalah proses memberdayakan, memandirikan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta pengembangan lingkungan sehat.

Promosi Kesehatan tidak dapat dipisahkan dari program-program kesehatan, yang keberadaanya harus di dukung dan dioptimalkan untuk mencapai perubahan perilaku dalam upaya derajat kesehatan masyarakat yang optimal (Pusat Promkes Depkes RI bekerjasama FKM-UI, 2009). Masalah perubahan perilaku sangat terkait dengan promosi kesehatan, dilihat dari peran promosi kesehatan dalam meningkatkan perilaku masyarakat agar terbebas dari masalah-masalah kesehatan, karena sehat dan tidak sakitnya seseorang sangat ditentukan oleh perilaku hidup manusia sendiri (Kemenkes, 2010)

Promosi kesehatan memegang peranan penting untuk menjamin keberhasilan peningkatan status kesehatan, dengan mengupayakan kebijakan, strategi dan intervensi dengan penekanan pada pendidikan, kesehatan, organisasi, ekonomi dan lingkungan yang mendukung perilaku sehat (Emilia, 2002)

2. Sasaran promosi kesehatan

Sasaran promosi kesehatan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu (1) Sasaran primer yaitu pasien, individu sehat dan keluarga (rumah tangga) sebagai komponen masyarakat (2) Sasaran sekunder adalah para pemuka masyarakat, baik pemuka informal, misalnya pemuka adat, agama dan lain-lain maupun pemuka formal misalnya petugas kesehatan, pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan media massa. Mereka diharapkan dapat berturut serta dalam upaya meningkatkan kemampuan individu dalam memelihara dan melindungi kesehatannya dengan cara menyebarluaskan informasi sebagai panutan dan sebagai kelompok penekan (*pressure group*) mempercepat terbentuknya kemandirian dalam bidang kesehatan, dan (3) sasaran tersier para pembuat kebijakan public yang berupa perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain yang berkaitan erat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya dan memberlakukan kebijakan yang mendukung dalam upaya pemberdayaan sasaran tersier dan sekunder.

3. Strategi promosi kesehatan

Promosi kesehatan merupakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dalam kegiatan tunggal namun harus dilakukan dengan berbagai

strategi Ottawa Charter (WHO, 1986) menyebutkan terdapat tiga strategi promosi kesehatan yang mana ketiga strategi dasar tersebut adalah

a. Advokasi

Advokasi merupakan upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait Kemenkes RI (2011). Advokasi sebagai kegiatan meyakinkan pembuat kebijakan bahwa program kesehatan yang akan dijalankan penting. Kesehatan yang baik adalah sumber utama untuk perkembangan sosial, ekonomi dan pribadi, dan dimensi penting dari kualitas hidup. Faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, perilaku dan biologis semua dapat menguntungkan atau membahayakan kesehatan. Promosi kesehatan bertujuan untuk membuat kondisi ini menguntungkan, melalui advokasi untuk kesehatan.

b. *Mediate* (Menjembatani)

Mediasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjembatani para pihak yang terkait dengan kegiatan promosi kesehatan. Prasyarat dan prospek kesehatan tidak dapat dipastikan oleh sektor kesehatan saja. Promosi kesehatan menuntut tindakan terkoordinasi oleh semua pihak, termasuk pemerintah, sektor kesehatan dan sosial dan ekonomi lainnya, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sukarela, otoritas lokal, industri dan media. Promosi kesehatan menjembatani sektor kesehatan dengan non kesehatan sehingga terbentuk kemitraan. WHO (1998). Mediasi membuka jalan promosi kesehatan didukung oleh berbagai pihak yang terkait sehingga dapat berhasil sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

c. *Enable* (Memampukan)

Promosi kesehatan berfokus pada pencapaian kesetaraan dalam kesehatan. Tindakan promosi kesehatan bertujuan untuk mengurangi perbedaan dalam status kesehatan saat ini dan untuk memastikan ketersediaan peluang dan sumber daya yang sama untuk memungkinkan semua orang mencapai potensi kesehatan mereka sepenuhnya. Ini termasuk landasan yang aman dalam lingkungan yang mendukung, akses ke informasi, keterampilan hidup dan peluang untuk membuat pilihan yang sehat. Orang tidak dapat mencapai potensi kesehatan mereka sepenuhnya kecuali mereka mampu mengendalikan hal-hal yang menentukan kesehatan mereka. Ini harus berlaku sama untuk perempuan dan pria. Memberikan keterampilan kepada masyarakat agar mandiri di bidang kesehatan.

Pencapaian tujuan promosi kesehatan memerlukan peran serta dari berbagai pihak sehingga dalam promosi kesehatan memungkinkan untuk mengambil tindakan dalam kemitraan dengan individu atau kelompok untuk

memberdayakan mereka, melalui mobilisasi sumber daya manusia dan material, untuk mempromosikan dan melindungi kesehatan mereka. Dalam perkembangan kegiatan promosi kesehatan makna ini mengacu kepada pemberdayaan melalui kemitraan, dan pada mobilisasi sumber daya menarik perhatian pada peran penting pekerja kesehatan dan aktivis kesehatan lainnya yang bertindak sebagai katalis untuk tindakan promosi kesehatan, misalnya dengan menyediakan akses ke informasi kesehatan, dengan memfasilitasi pengembangan keterampilan, dan mendukung akses ke proses politik yang membentuk kebijakan publik yang mempengaruhi kesehatan. (WHO, 1998).

Pemberdayaan merupakan pemberian informasi dan pendampingan dalam mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Pemberian informasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien, agar klien berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (*aspek knowledge*), dari tahu menjadi mau (*aspek attitude*) dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (*aspek practice*). Oleh sebab itu, sesuai dengan sasaran (klien) dapat dibedakan menjadi: (a) pemberdayaan individu, (b) pemberdayaan keluarga, dan (c) pemberdayaan kelompok/masyarakat

Bina suasana merupakan upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Seseorang akan terdorong untuk mau melakukan sesuatu apabila lingkungan sosial disetiap tempat ia berada mendukung perilaku tersebut. Terdapat tiga kategori proses bina suasana, yaitu: (a) bina suasana individu yang dilakukan oleh individu-individu tokoh masyarakat sebagai panutan dalam hal perilaku yang sedang diperkenalkan, (b) bina suasana kelompok yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti pengurus RT,RW, majelis pengajian, perkumpulan seni, organisasi profesi, organisasi pemuda sebagai kelompok peduli terhadap perilaku yang sedang diperkenalkan, dan (c) bina suasana public yang dilakukan oleh masyarakat umum melalui pengembangan kemitraan dan pemanfaatan media komunikasi sebagai mitra dalam menyebarkan informasi tentang perilaku yang sedang diperkenalkan.

Advokasi adalah upaya strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*). Pihak-pihak yang terkait ini berupa tokoh-tokoh masyarakat (formal dan informal) yang umumnya berperan sebagai narasumber, penentu kebijakan dan penyandang dana. Sasaran advokasi diperoleh dalam beberapa tahapan, yaitu: (a) mengetahui atau menyadari adanya masalah, (b) tertarik untuk ikut mengatasi masalah, (c) peduli terhadap pemecahan masalah dengan

mempertimbangkan berbagai alternatif pemecahan masalah, (d) sepakat untuk memecahkan masalah dengan memilih salah satu alternative pemecahan masalah, dan (e) memutuskan tindak lanjut kesepakatan.

Kemitraan sendiri dalam promosi kesehatan harus digalang, baik dalam rangka pemberdayaan, bina suasana dan advokasi, guna membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan. Kemitraan harus berlandaskan pada tiga prinsip, yaitu : (a) kesetaraan, yaitu terciptanya hubungan yang hierarkis, keadaan ini dapat dicapai apabila semua pihak bersedia mengembangkan hubungan kekeluargaan, (b) keterbukaan, yaitu kejujuran dari masing-masing pihak dalam setiap usul, saran dan komentar harus disertai dengan alasan yang jujur dan sesuai fakta tanpa harus menutupi-menutupi sesuatu, dan (c) saling menguntungkan, yang perilaku yang ditawarkan bersifat adil dikaitkan dengan adanya keuntungan yang didapat oleh semua pihak yang terlibat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011)

Terdapat dua strategi utama yang digunakan oleh praktisi promosi kesehatan, yaitu: strategi yang menekan pada masyarakat lingkungan dibandingkan dengan individu dan strategiyang menekankan pada individu yang beresiko tinggi dibandingkan dengan seluruh populasi Strategi pertama yang menenangkan pada masyarakat lingkungan, lebih menekankan dalam hal pada sistemnya tidak sekedar menyalahkan korban, bahwa penyakit terjadi pada kelompok tertentu karena kurang beruntung dalam hal sosial ekonomi.

Strategi untuk mengatasinya dengan menghilangkan kekurangan tersebut, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, pengangguran dan faktor sosial. Strategi individu memberi penekanan tentang tanggung jawab individu terhadap status kesehatannya. Dalam strategi kedua ini, perilaku kesehatan individu merupakan faktor utama timbulnya sakit atau sehat. Strategi yang digunakan disini ditujukan untuk mengubah perilaku individu, tanpa adanya penekanan pada factor structural yang dapat menjadi penyebab terjadinya perilaku.

F. Infeksi Menular Seksual

1. Pengertian Infeksi Menular Seksual

Infeksi menular seksual (IMS) adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks, penyakit menular seksual akan lebih beresiko bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan baik melalui vagina, oral maupun anal. (Verra, 2012)

Menurut Manuaba (2009) Penyakit Menular Seksual adalah penyakit yang cara penularannya melalui hubungan kelamin, tempat terjangkitnya penyakit

tersebut tidak semata-mata pada alat kelaminsaja, tetapi dapat terjadi di berbagai tempat di luar alat kelamin.

2. Penyebab Infeksi Menular Seksual

Menurut Intan (2012) ada beberapa penyebab terjadinya Penyakit Menular Seksual :

- a. Sisa kotoran yang tertinggal karena pembasuhan buang air besar yang kurang sempurna
- b. Kesehatan umum rendah
- c. Kurangnya kebersihan alat kelamin, terutama saat menstruasi
- d. Perkawinan pada usia terlalu muda dan berganti-ganti pasangan
- e. Hubungan seksual dengan penderita infeksi
- f. Perlukaan pada saat keguguran, melahirkan, atau perkosaan.
- g. Kegagalan pelayanan kesehatan dalam strelisisasi alat dan bahan dalam melakukan pemeriksaan/tindakan di sekitar saluran reproduksi.

3. Tanda dan Gejala Penyakit Menular Seksual

Menurut Intan (2012) ada beberapa gejala PMS yaitu :

- a. Gejala-gejala umum PMS pada laki-laki :
 - 1) Bintik-bintik berisi cairan, borok, atau lecet pada daerah sekitar kelamin.
 - 2) Luka tidak sakit, keras dan berwarna merah pada sekitar daerah kelamin.
 - 3) Adanya kutil yang tumbuh seperti jengger ayam.
 - 4) Rasa gatal yang sangat hebat di sekitar kelamin.
 - 5) Sakit luar biasa saat kencing.
 - 6) Kencing nanah/adrah dengan bau busuk.
 - 7) Bengkak, panas, nyeri pada pangkal paha yang akhirnya menjadi borok.
 - 8) Kehilangan berat badan secara drastis, diare berkepanjangan, dan berkeringan saat malam.
- b. Gejala-gejala umum PMS pada perempuan :
 - 1) Rasa sakit atau nyeri saat kencing atau saat berhubungan seksual.
 - 2) Rasa nyeri pada perut bagian bawah.
 - 3) Keluarnya lendir pada vagina.
 - 4) Keputihan berwarna putih susu, bergumpal, dan disertai rasa gatal pada kelamin.
 - 5) Keputihan berbusa dan berbau busuk.
 - 6) Bercak-bercak darah setelah berhubungan seks.

4. Cara Penularan Penyakit Menular Seksual

Menurut Intan (2012) orang-orang yang beresiko tinggi terhadap penularan PMS , termasuk HIV/AIDS yaitu :

- a. Sering berganti-ganti pasangan atau mempunyai satu atau lebih pasangan seksual baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal (misalnya dengan pekerja seks komersial)
- b. Memiliki pasangan seksual yang mempunyai pasangan seksual lainnya.
- c. Terus melakukan hubungan seksual, walaupun mempunyai keluhan PMS dan tidak memberitahu kepada pasangannya tentang hal tersebut.
- d. Tidak memakai kondom saat melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang beresiko.
- e. Pemakaian jarum suntik secara bersama-sama secara bergantian, misalnya pada penderita ketergantungan narkotika atau kelalaian petugas dalam menjaga kesterilan alat suntik.
- f. Pekerja seks komersial
- g. Homoseksual

5. Jenis Penyakit Menular Seksual

Menurut verra dan taufan (2011) jenis penyakit menular seksual dibagi menjadi :

a. Gonore atau Kencing Nanah

Gonore atau kencing nanah adalah penyakit tersering ditemui dalam dunia kedokteran. Ia mempunyai banyak nama yang digunakan oleh orang awam, seperti kencing nanah, raja singa, dan banyak lagi. Penyakit ini disebabkan oleh kuman *Neisseria gonorrhoe* yang berbentuk seperti buah kopi berpasangan.

Gejala awal dapat timbul dalam waktu 7-21 hari setelah infeksi. Pada perempuan biasanya tidak menunjukkan gejala selama beberapa minggu atau bulan, dan diketahui menderita penyakit ini ketika pasangan seksualnya tertular. Jika timbul gejala, biasanya bersifat lebih ringan, namun demikian beberapa penderita menunjukkan gejala yang berat, seperti desakan untuk berkemih, nyeri ketika buang air kecil, keluarnya cairan putih dari vagina dan penjaran ini bisa mencapai leher rahim, rahim, saluran telur, indung telur, *uretra* (saluran kencing bawah) dan rektum yang menyebabkan nyeri pinggul dalam atau nyeri ketika melakukan hubungan seksual.

Pada perempuan dan pria homoseksual yang melakukan hubungan seksual melalui dubur bisa menderita *gonore* pada usus bagian bawah. Melakukan oral sex dengan seorang penderita *gonore* juga dapat menyebabkan tertularnya *gonore* pada tenggorokan (*faringitis gonocokal*), yang terkadang tidak menunjukkan gejala dan kadang gejalanya mirip seperti radang tenggorokan .

Gonore juga dapat menular ke mata jika cairan yang terinfeksi mengenai mata yang biasanya disebut dengan konjungtivitis gonore. Bayi yang baru lahir dapat tertular gonore dari ibunya yang terjadi selama proses persalinan, yang dapat menyebabkan pembengkakan kelopak matanya dan dari matanya mengeluarkan nanah.

b. Sifilis (raja singa)

Kuman penyebabnya disebut *Treponema pallidum*. Masa tanpa gejala berlangsung 3-4 minggu, kadang-kadang sampai 13 minggu kemudian timbul benjolan di sekitar alat kelamin. Kadang-kadang disertai pusing-pusing dan nyeri tulang seperti flu yang akan hilang sendiri tanpa diobati. Ada bercak kemerahan pada tubuh sekitar 6-12 minggu setelah hubungan seks. Gejala ini akan hilang sendirinya dan seringkali penderita tidak memperhatikan hal ini.

Selama 2-3 tahun pertama penyakit ini tidak menunjukkan gejala apa-apa atau disebut masa laten. Setelah 5-10 tahun penyakit sifilis akan menyerang susunan syaraf otak, pembuluh darah dan jantung. Pada perempuan hamil sifilis dapat ditularkan kepada bayi yang dikandungnya dan bisa lahir dengan kerusakan kulit, hati, limpa dan keterbelakangan mental.

c. Herpes *genital*

Penyakit yang disebabkan oleh virus *Herpes Simplex* dengan masa tenggang 4-7 hari sesudah virus masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks. Gejala dan tanda-tandanya adalah Bintil-bintil berair (berkelompok seperti anggur) yang sangat nyeri pada sekitar alat kelamin, kemudian pecah dan meninggalkan luka yang kering mengerak, lalu hilang sendiri, dan gejala kambuh lagi seperti diatas namun tidak senyeri tahap awal bila ada faktor pencetus (stres, haid, minuman dan makanan beralkohol) dan biasanya menetap hilang timbul seumur hidup. Pada perempuan, seringkali menjadi faktor kanker mulut rahim beberapa tahun kemudian. Penyakit ini belum ada obat yang benar-benar mujarap, tetapi pengobatan antivirus bisa menurangi rasa sakit dan lamanya episode penyakit.

d. Klamidia

Penyakit ini disebabkan oleh *Chlamydia trachomatis*. Masa tanpa gejala berlangsung 7-21 hari. Gejalanya adalah timbul peradangan pada alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada perempuan, gejalanya bisa berupa, Keluarnya cairan dari alat kelamin atau keputihan encer berwarna putih kekuningan, rasa nyeri di rongga panggul dan perdarahan setelah hubungan seksual.

e. Trikomoniasis *vaginalis*.

Trikomoniasis vaginalis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit *Trikomonas vaginalis*. Gejala dan tandanya adalah, Cairan vagina

encer, berwarna kuning kehijauan, berbusa dan berbau busuk, vulva agak bengkak, kemerahan, gatal dan terasa tidak nyaman dan nyeri saat berhubungan seksual atau saat kencing.

f. Moluskum Kontagiosum

Tipenya termasuk dalam viral. Penyebabnya virus-virus golongan *pox virus*. Cara penularannya melalui kontak langsung atau seksual. Masa inkubasi berkisar $\pm$ 6 minggu. Terdapat benjolan kecil sebesar kepala jarum pentul sampai sebesar jagung, yang didalamnya terdapat bahan seperti lemak, dan ditengahnya terdapat cekungan.

Ditularkan secara inokulasi yaitu melalui lesi dan dengan garukan akan timbul luka baru. Pengobatan dengan forseps, ekskloleksi, atau jika tidak diobati akan sembuh sendiri dalam waktu sekitar 6 minggu.

g. Kutil kelamin.

Kutil kelamin penyebabnya adalah *human papiloma virus* dengan gejala yang khas yaitu terdapat satu atau beberapa kutilan sekitar kemaluan. Pada perempuan dapat mengenai kulit daerah kelamin sampai dubur, selaput lendir bagian dalam liang kemaluan sampai leher rahim. Bila perempuan hamil, kutil dapat tumbuh besar sekali. Kutil kelamin kadang-kadang bisa mengakibatkan kanker leher rahim atau kanker kulit di sekitar kelamin. Pada laki-laki mengenai kelamin dan saluran kencing bagian dalam. Kadang-kadang kutil tidak terdapat terlihat sehingga tidak disadari. Biasanya laki-laki baru menyadari setelah ia menulari pasangannya.

h. AIDS

AIDS adalah *Acquired Immune Deficiency Syndrom* (sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunya kekebalan tubuh, yang didapat). AIDS disebabkan oleh adanya virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) di dalam tubuh

Cara penularan lewat transfusi darah/ produk darah yang sudah tercemar HIV, lewat cairan sperma dan cairan vagina melalui hubungan seks penetratif tanpa menggunakan kondom, lewat air susu ibu yang HIV positif dan melahirkan lewat vagina.

6. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyakit Menular Seksual

Menurut Intan (2012) Faktor dominan yang ikut menentukan besarnya frekuensi dan distribusi penyakit menular seksual dalam suatu masyarakat, antara lain:

a. Penyebab penyakit (*agent*)

Penyakit menular seksual sangat bervariasi dapat berupa virus, parasit, bakteri, protozoa.

b. Tuan (*host*)

Beberapa faktor yang terdapat pada host yang berperan pada perbedaan insiden penyakit menular adalah:

1) Umur

Umur berapa yang sangat penting yang ikut mempengaruhi insiden penyakit menular seksual, sesuai dengan cara penularan penyakit menular seksual yaitu melalui kontak seksual maka golongan umur dengan insiden meningkat adalah golongan umur dengan kegiatan seksual aktif.

2) Sex / jenis kelamin

Angka kesakitan kelompok umur tertentu pada penderita penyakit menular seksual pria adalah lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, namun tingkat kegawatan pada perempuan penderita penyakit menular seksual adalah lebih serius dibandingkan dengan laki-laki, factor yang mempengaruhi antara lain:

1) Perbedaan sex dengan perbedaan susunan anatomi organ tubuh tertentu. Manifestasi gejala klinis penyakit menular seksual pada laki-laki adalah lebih jelas sehingga memberikan kesempatan lebih banyak menggunakan fasilitas kesehatan.

2) Diagnosa penderita penyakit menular seksual pada laki-laki lebih mudah sehingga lebih banyak penderita laki-laki yang dilaporkan.

3) Pilihan dalam hubungan seksual.

Data yang ada dinegara maju angka penyakit menular seksual pada pria homoseksual adalah lebih tinggi bila dibandingkan dengan heteroseksual.

4) Lama bekerja sebagai pekerja seksual komersial

Pekerjaan seseorang sering merupakan ikatan erat dengan kemungkinan terjadinya penyakit menular seksual. Pada beberapa orang yang bekerja dengan kondisi tertentu dengan lingkungan yang memberikan peluang terjadinya kontak seksual akan meningkatkan akibat meningkatkan penderita penyakit menular seksual. Orang tersebut termasuk dalam kelompok resiko tinggi terkena penyakit menular seksual.

5) Status perkawinan

Insiden penyakit menular seksual lebih tinggi pada orang yang belum kawin, bercerai atau orang yang terpisah dari keluarganya bila dibandingkan dengan orang yang sudah kawin karena pemenuhan kebutuhan seksualnya terpenuhi.

c. Faktor lingkungan

Beberapa faktor yang ikut berperan terhadap penyebaran penyakit menular seksual adalah faktor dengan sosial ekonomi, kebudayaan, biologik dan medik yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain:

- 1) Faktor demografi
 - a) Bertambahnya jumlah penduduk dan pemukiman yang padat
 - b) Perpindahan populasi yang menambah migrasi dan mobilisasi penduduk misalnya, perdagangan, hiburan, dll.
 - c) Meningkatnya prostitusi dan homo seksual
 - d) Remaja lebih cepat matang dibidang seksual yang ingin lebih cepat mendapatkan kepuasan seksual
- 2) Faktor sosial ekonomi
 - a) Kemiskinan terutama didaerah hutan yang menyebabkan urbanisasi ke kota besar.
 - b) Perkembangan ekonomi mendorong terjadinya meningkatkan *promiskuitas* (hubungan seksual antara sejumlah laki-laki dengan sejumlah perempuan), misalnya: orang lebih mudah bepergian berlibur atau berdarmawisata, berkunjung ke tempat hiburan (Klub malam, panti pijat, bar, dll)
- 3) Faktor kebudayaan
 - a) Pelanggaran nilai moral dan agama yang menyebabkan orang lebih bebas berbuat sesuatu termasuk hubungan seksual diluar nikah.
 - b) Melanggar ikatan keluarga termasuk pengawasan ortu menyebabkan hubungan seksual diluar nikah.
 - c) Anggapan bahwa pria lebih *promiskuitas* (hubungan seksual antara sejumlah laki-laki dengan sejumlah perempuan) menyebabkan adanya prostitusi.
 - d) Meningkatkan rangsangan seksual melalui majalah atau film biru, dan lain-lain.
- 4) Faktor medik
 - a) Adanya kekebalan kuman penyakit menular seksual. Kekebalan karena penderita membeli obat dan minum obat sendiri dengan dosis obat yang tidak tetap atau tidak adekuat.
 - b) Diagnosis penyakit kadang susah. Terjadinya kontak seksual akan meningkatkan akibat meningkatkan penderita penyakit menular seksual. Orang tersebut termasuk dalam kelompok resiko tinggi terkena penyakit menular seksual.

G. Perempuan Pekerja Seksual

Menurut hasil Survey Surveilans Perilaku (SSP) BPS Propinsi Jawa Tengah (2020) Berdasarkan cara bekerjanya Perempuan Pekerja Seksual dapat dibedakan menjadi 2

(dua) macam, yaitu :

1. PPS langsung (*direct sex worker*)

Yaitu perempuan yang secara terbuka menjajakan seks baik di jalanan maupun di lokasi atau eks lokasi

2. PPS Tidak langsung (*hidden sex worker*)/ perempuan pekerja seksual tidak langsung

Yaitu perempuan yang biasa beroperasi secara terselubung sebagai penaja seks komersial, yang biasanya bekerja pada bidang-bidang pekerjaan tertentu atau mempunyai pekerjaan utama lain dan secara tidak langsung menjajakan seks di tempat-tempat hiburan seperti pramupijat, pramuria bar/ karaoke. Dapat juga diartikan sebagai perempuan yang melayani seks pelanggannya untuk memperoleh tambahan pendapatan di tempat ia bekerja, seperti perempuan yang bekerja dipanti pijat/salon/spa, bar/karaoke/diskotek/kafe/restoran dan hotel/motel/cottage (perempuan penaja seks tidak langsung)

H. Perilaku Pencegahan Perempuan pekerja seksual tidak langsung terhadap IMS dan HIV/AIDS

Perilaku manusia mempunyai pengaruh terhadap status kesehatan individu kelompok maupun masyarakat. Henrik L. Blum (1974) berdasarkan analisisnya menyimpulkan bahwa faktor perilaku mempunyai peranan yang besar terhadap tingkat kesehatan, setelah pengaruh lingkungan (Koentjoro, 2012).

Semua Perempuan pekerja seksual tidak langsung berusaha untuk menggunakan kondom selama melakukan intercourse. Mereka menyadari bahwa dengan menggunakan kondom maka akan mencegah penularan IMS dan HIV/AIDS.

Seluruh Perempuan pekerja seksual tidak langsung mengakui mendapatkan alat pelindung dengan membeli. Terkadang juga mendapatkan alat pelindung (kondom) dari manajemen atau pacar. Merk alat pelindung yang biasa mereka pakai yaitu Fiesta dan Sutra. Aktivitas seks yang aktif menjadikan subyek termasuk salah satu kelompok beresiko untuk terjadi KTD maupun IMS dan HIV/AIDS sehingga komitmen untuk berperilaku seks aman dengan menggunakan alat pelindung juga dirasakan subyek.

Sebagian besar masih terperangkap di dalam mitos yang berkembang selama ini di masyarakat. Masih ada yang memakai odol dan sprite untuk mencuci alat kelamin karena dipercaya dengan rasa perih yang ditimbulkan akan menghilangkan kuman.

Ada juga yang menggunakan sabun cair, betadine cair, dan sabun siri sambil dibasuh air panas atau air dingin untuk mencuci alat kelamin. Mereka mencuci alat kelamin sambil mengorek vagina supaya menurut mereka kuman-kuman keluar semua. Ada lagi yang percaya bahwa dengan teratur berolahraga, minum jamu, dan minum antibiotik maka mereka akan terhindar dari IMS dan HIV/AIDS.

Ada yang lebih unik lagi yaitu ia menyuruh semua tamunya mandi dulu sebelum berhubungan badan supaya bersih. Sedangkan ia sendiri tidak perlu mandi karena merasa sudah bersih.

Hanya sebagian kecil dari Perempuan pekerja seksual tidak langsung yang tidak memakai apapun untuk pencegahan penyakit seksual selain dengan kondom. Ada satu subjek yang sudah bekerja cukup lama memiliki pengetahuan baik yaitu ia berpendapat jika terlalu sering minum antibiotik maka suatu saat jika sakit, maka tubuh akan kebal terhadap obat.

Saparinah Sadli (1982) yang mengutip pendapat J. Kosa dan L.S. Robertson mengatakan bahwa perilaku kesehatan individu cenderung dipengaruhi oleh kepercayaan orang yang bersangkutan terhadap kondisi kesehatan yang diinginkan, dan kurang didasarkan pada pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu biologi. Kenyataannya memang mendukung pernyataan ini. Terhadap kondisi kesehatan yang terganggu masing-masing individu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengambil tindakan pencegahan atau penyembuhannya. Pada umumnya tindakan yang diambil berdasarkan penilaian individu atau mungkin dibantu oleh orang lain, terhadap gangguan tersebut. Penilaian semacam ini menunjukkan bahwa gangguan yang dirasakan individu menstimulir dimulainya suatu proses sosial psikologis. Proses sosial semacam ini menggambarkan berbagai tindakan yang dilakukan si penderita mengenai gangguan yang dialami, dan merupakan bagian integral dari interaksi pada umumnya.

Infeksi Menular Seksual (IMS) diketahui mempermudah penularan HIV. Selain itu, IMS juga merupakan petunjuk adanya perilaku seksual yang berisiko. Prevalensi IMS yang tinggi pada suatu populasi di suatu tempat merupakan pertanda awal akan risiko penyebaran HIV, walaupun prevalensi HIV masih rendah. Di samping menunjukkan risiko penyebaran HIV, prevalensi IMS dapat memvalidasi data perilaku penggunaan kondom yang didapat dari surveilans perilaku. Kurangnya perilaku penggunaan kondom akan tergambar dengan tetap tingginya prevalensi IMS. Di lain pihak, peningkatan penggunaan kondom akan lebih cepat tergambar melalui penurunan prevalensi IMS daripada penurunan prevalensi HIV (Gavin, 2020).

Sebagian besar dari Perempuan pekerja seksual tidak langsung mengaku belum pernah mengalami IMS. Mereka lebih sering mengalami keputihan dan ada satu subjek yang mengalami infeksi mulut rahim. Sebagian kecil mengakui pernah mendapatkan IMS yaitu jengger ayam. Mereka merasa mendapatkan penyakit jika melihat atau merasakan gejala yang terlihat, seperti gatal, bernanah, bergelambir (*jengger*), dan keputihan. Tetapi jika mereka tidak merasakan atau melihat gejala apapun maka mereka menganggap sehat-sehat saja.

Dari jawaban yang diperoleh bukan berarti disimpulkan bahwa kelompok Perempuan pekerja seksual tidak langsung memiliki kasus IMS negatif. Peluang cukup besar bagi mereka berpenyakit tetapi tidak terlihat karena seringnya antibiotik yang

mereka minum. Hanya satu orang yang akan tetap bekerja walaupun ia sakit IMS . Tetapi ia bekerja memakai kondom. Ada juga sebagian kecil yang akan berhenti bekerja dahulu karena merasa sakit jika alat kelaminnya dipakai untuk berhubungan seksual. Tetapi ada juga yang karena merasa belum pernah menderita IMS ia terus bekerja.

Kalau melihat dari tingkat pengetahuan mereka yang rendah terhadap jenis dan gejala IMS, maka bukan tidak mustahil kalau mereka sebenarnya tidak tahu kalau sedang terkena IMS. Mengingat mereka pada umumnya mencari pengobatan jika sudah mengalami keluhan. Yang perlu diperhatikan bahwa perempuan lebih mudah terkena IMS dibandingkan laki-laki, karena perempuan menampung air mani jika berhubungan seks. Disamping itu lapisan liang senggama juga sangat halus dan mudah terluka. Akibatnya bibit penyakit mudah masuk dan jika terkena IMS sering tidak menunjukkan tanda atau gejala (Hanifa, 2013)

Selain itu IMS lebih sukar dideteksi pada perempuan dibandingkan laki-laki sehingga diagnosa juga semakin sulit. Perempuan lebih jarang melakukan pengobatan dibandingkan dengan laki-laki karena sering tidak menunjukkan gejala pada awal, malu atau tidak mau pergi ke klinik. Akibatnya infeksi yang ditularkan secara seksual dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius sebelum perempuan-perempuan tersebut mendapatkan pengobatan. Mereka akan menderita IMS lebih lama dan mengakibatkan kondisi yang lebih parah, seperti kehamilan ektopik, radang pelvis dan kemandulan (Hanifa,2013).

Terkena IMS adalah sesuatu yang buruk bagi mereka karena selain sulit mendapatkan tamu sehingga berpengaruh pada penghasilan, faktor persaingan juga mempengaruhi. Ada satu subjek yang bercerita bahwa karena ia sakit, maka teman saingannya mengatakan tentang sakitnya kepada tamu langganannya, sehingga ia tidak mendapat langganan lagi. Fenomena persaingan ini tidak begitu mencuat, karena pada umumnya mereka cukup individualistis, walaupun tidak menutup kemungkinan mereka membicarakan satu dengan yang lain di belakang orangnya (*bergosip*)

Becker (1974) dengan skema Model Kepercayaan menyimpulkan bahwa untuk meramalkan perilaku sakit maupun sehat (variabel tergantung) dipengaruhi oleh faktor sosiopsikologis (persepsi sakit, persepsi kegawatan penyakit, dan sebagainya), faktor-faktor demografis, faktor struktural seperti keadaan sosial ekonomis, kemampuan memperoleh kesehatan, dan sebagainya, pengaruh media massa, pengaruh dokter, perhitungan cost benefit dari tindakan dan sebagainya. Begitu juga dengan subjek yang akan mencari pengobatan jika secara subjektif sudah melihat kegawatan terhadap diri atau penyakitnya. Hal ini dipengaruhi juga dengan kondisi ekonomi dari subjek yang merasa kalau tidak terlalu penting atau mengalami kegawatan maka tidak perlu mencari pengobatan.

Sebagian besar dari Perempuan pekerja seksual tidak langsung mengaku pernah melayani tamu yang sedang sakit IMS tetapi tetap memakai kondom ketika berhubungan. Ada yang merasa tamunya tidak terkena IMS walaupun tanda-tanda yang diungkapkan adalah IMS. Ada satu Perempuan pekerja seksual tidak langsung yang memilih mengembalikan uang dan pulang daripada harus melayani tamu yang sedang sakit IMS. Sebagian kecil merasa belum pernah melayani tamu yang sedang sakit IMS. Bisa jadi karena ketidaktahuan mereka atau minimnya pengetahuan mereka terhadap gejala IMS, atau memang mereka memang benar-benar belum pernah melayani tamu yang sedang sakit IMS.

I. Persepsi Perempuan Pekerja Seksual Tidak Langsung Faktor Penyebab Perempuan Pekerja Seksual Tidak Langsung Berperilaku

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan, bahwa usia informan berkisar 17-25 tahun. Kelompok usia tersebut termasuk dalam fase remaja (BKKBN). Remaja merupakan periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio emosional (Santrock, 2007).

Perubahan fisik terjadi secara cepat dan perubahan tersebut tidak seimbang dengan perubahan mental dan emosional. Beberapa contoh perubahan emosional adalah sensitive, sering bersikap irasional, mudah tersinggung, ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua, lebih senang pergi dengan temannya, cenderung ingin mengetahui hal-hal yang baru sehingga muncul perilaku *encoba-coba*. Perilaku ingin mencoba hal yang baru jika didorong oleh rangsangan seksual dapat membawa remaja masuk dalam hubungan seks pra nikah (Widyastuti et al., 2009). Hal ini perlu diperhatikan semua pihak, sehingga Pendidikan reproduksi dan seksualitas, khususnya Kesehatan seksual bagi remaja harus telah diberikan kepada remaja sesuai dengan umurnya.

Ditinjau dari segi pendidikan sebagian besar subjek mengenyam pendidikan yang cukup yaitu lulus SMA/SMK dan masih duduk di Perguruan Tinggi. Dengan demikian subjek yang mengenyam pendidikan formal yang tinggi akan lebih mudah menerima dan mengerti informasi yang telah didapatkan. Sesuai dengan harapan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi perilakunya. Dalam penelitian ini memang dapat dilihat hubungan antara pendidikan dengan pengetahuan. Sebagian besar Perempuan pekerja seksual tidak langsung yang mengenyam pendidikan lebih tinggi dapat menerima dan mengerti akan informasi yang didapatkan. Tetapi ada satu orang tidak lulus mengenyam pendidikan lanjutan atas juga memiliki pengetahuan yang cukup baik. Pada umumnya didapatkan bahwa seseorang dengan pendidikan tinggi akan lebih cepat dan mudah dalam menyerap informasi yang diterimanya.

Stanhope *et al.*, (2004) Berdasarkan teori *Health Belief Model* oleh Rosentock menyebutkan bahwa variabel manfaat dan rintangan mendorong individu serius

dalam melakukan suatu tindakan tertentu. Tindakan ini akan tergantung pada manfaat yang dirasakan dan rintangan yang ditemukan dalam mengambil tindakan tersebut. Sehingga untuk meningkatkan pengetahuan tentang IMS, dan HIV&AIDS tidak selalu memperhatikan pendidikan tetapi lebih ditekankan pada upaya memberikan kesadaran akan manfaat yang dirasakan.

Teori *Health Belief Model* ini terbukti di dalam penelitian ini, bahwa walaupun subjek mengenyam pendidikan yang lebih rendah, akan tetapi ia memiliki banyak pengalaman dan rintangan yang mendorong seseorang mengambil tindakan setelah melalui beberapa tahapan utama dalam proses perubahan perilaku.

J. Penutup

Peran *Stakeholder* Pemerintah Daerah Kab. Semarang (PKBI, KPA, dan Dinas Kesehatan Bagian Pengendalian Penyakit Menular) Dalam Pengendalian IMS HIV dan AIDS melalui Edukasi, Advokasi, dan diterbitkannya kebijakan-kebijakan serta memastikan 3 komponen komunikasi berperan dengan yaitu Advokasi, mobilisasi sosial, dan komunikasi perubahan perilaku (*Behaviour Change Communication (BCC)*), Peran *Stakeholder* pemerintah daerah dan *Stakeholder* di Masyarakat bonding, bridging, serta linking remaja, *Bonding* : Peran Orang tua dalam keluarga dalam pola asuh dan cara berkomunikasi untuk membangun kedekatan remaja ikut membentuk perilaku remaja dan cara berkomunikasi untuk membangun kedekatan dengan remaja ikut membentuk perilaku remaja. *Bridging* : beberapa organisasi yang ada di masyarakat dan di perguruan tinggi merupakan jembatan bagi remaja sebagai tempat yang tepat untuk forum diskusi, dan untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi serta sebagai tempat mengasah ketrampilan untuk berwirausaha. *Linking* : kerjasama masyarakat dengan pemerintah untuk mencegah pernikahan dini dapat membuka akses dalam mengoptimalkan edukasi, advokasi dan menerbitkannya kebijakan-kebijakan yang terkait untuk mewujudkan generasi terencana, Kemitraan antara Dinas Kesehatan, KPAD Kab. Semarang dan PKBI dalam upaya pengendalian IMS HIV dan AIDS sebagai suatu gerbang utama untuk kolaborasi dengan berbagai kantor pemerintahan, Lembaga sipil dan masyarakat, serta Lembaga internasional untuk perencanaan program, penyelarasan program, rapat koordinasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan program, Model Promosi Kesehatan dalam upaya untuk pengendalian IMS HIV dan AIDS Aspek teoritis, teori HBM dan modal sosial sebagai *grand theory* pada penelitian ini mendukung Theory of Reasoned Action (TRA). HBM merupakan input yang utama dalam upaya pengendalian IMS HIV dan AIDS. Pengetahuan yang dimulai dari *perceived*, *seriousness*, dan *benefit* dan kepercayaan yang di masyarakat berasal dari bonding, bridging dan linking akan menumbuhkan kesadaran dan kemudian memunculkan niat untuk berperilaku seksual yang sehat, khususnya bagi remaja. Dengan berperilaku seksual yang sehat, maka para remaja terselubung akan terhindar dari IMS HIV dan AIDS.

Aspek hasil temuan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemberdayaan remaja wanita terselubung tidak hanya di rumah tetapi juga di kampus mereka belajar yaitu dengan adanya gagasan *Public Campaign* dari PKBI dan KPAD Kab.Semarang. Kemampuan membangun jaringan (*networks*), dengan dilandasi rasa percaya (*trust*) maka saling kerjasama dan saling peduli terhadap kepatuhan nilai (*Value*) untuk bersama-sama menjalankan norma (*norms*) yang berlaku di dapat mewujudkan saling menghargai sehingga merasa saling memberi dan menguntungkan (*reciprocal relationship*). Seluruh sektor dan dengan dukungan pemerintah bersama-sama berupaya menurunkan kejadian IMS HIV dan AIDS melalui keputusan Bupati Semarang Nomor 449.4.08/34-B/1/2014 Tentang pembentukan komisi, kelompok kerja (Pokja) dan Sekretariat Penanggulangan Penyakit menular Kab. Semarang Serta Kawasan wajib menggunakan kondom di pub café dan karaoke sesuai dengan UU No 24 tahun 2014

DAFTAR PUSTAKA

- Achora S., Thupayagale Tshweneagae G., Akpor O. A., Mashalla Y. J. S. 2018. Perceptions of Adolescents and Teachers on School Based Sexuality Education in Rural Primary Schools in Uganda. *Sexual and Reproductive Healthcare*, 17, 12-18.
- Ahmadi, Abu. 2008. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ajayi AI, Mudefi E, Adeniyi O V., Goon DT. Achieving the first of the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) 90-90-90 targets: *Understanding the influence of HIV risk perceptions, knowing one's partner's status and discussion of HIV/sexually transmitted infections with a sexual partner on uptake of HIV testing*. *Int Health*. 2019;11(6):425–31.
- Alvarez Roldan A., Parra I., Gamella J. F. 2018. Reasons for the Underachievement and School Drop Out of Spanish Romani adolescents. A Mixed Methods Participatory Study. *International Journal of Intercultural Relations*, 63(January), 113-127.
- Ali, Asrori. 2018. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Zaidin. 2009. *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: EGC.
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amoah. 2018. Social Participation, Health Eiteracy, and Health and Wellbeing: A Cross-sectional Study in Ghana. *SSM- Population Health*, 4, 263-270.
- Andari I.D., Woro K., Yuniastuti A. 2019. The Effect of Knowledge, Attitude and Parents Behavior Towards Sex Education Parents With Sexual Violence Incident. *Public Health Perspectives Journal* 4 (2) 141 - 148.
- Andriani, Eny dan Kurniawati Tend. 2011. Hubungan Peran Pengawasan Orang Tua dengan Sikap Remaja Terhadap Perilaku Seks Pra Nikah di Pedukuhan Blimbing Tambakrejo Tempel Sleman Yogyakarta. *Naskah Publikasi*. UNISA. Yogyakarta.
- Anita Raj, Salazar, Jackson, Wyss, McClendon, Khanna, Belayneh and McDougal. 2019. Students and Brides: A Qualitative Analysis of the Relationship Between Girls' Education and Early Marriage in Ethopia and India. *BMC Public Health*. 19:19.
- Anwar, Saifuddin. 2012. *Sikap Manusia Teori dan pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bandura, A. and Adam, N.E. 1977. Analysis of Self-Efficacy Theory of Behavioral Change *Cognitive Therapy and Research*. 1 (4). Pp 287-310
- Bandura, A. 1971. *Social Learning Theory*. New York: General Learning Press
- Blaszczyk. 2018. Strategic Synergies and perspectives of their Evaluation in the Process of Strategic Analysis. *Management Sciences*. Vol 23, No. 4.

- Capra, F., & Jakobsen, O. D. (2017). A conceptual framework for ecological economics based on systemic principles of life. *International Journal of Social Economics*, 44(6), 831–844. <https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2016-0136>
- Chirisa, I., Mutambisi, T., Chivenge, M., Mabaso, E., Matamanda, A. R., & Ncube, R. (2020). The urban penalty of COVID-19 lockdowns across the globe: manifestations and lessons for Anglophone sub-Saharan Africa. *GeoJournal*, 6. <https://doi.org/10.1007/s10708-020-10281-6>
- Cowan, F. M; Ramona WA; Karin H. (2018) 'Targeted combination prevention to support female sex workers in Zimbabwe accessing and adhering to antiretrovirals for treatment and prevention of HIV (SAPPH-IRE): a cluster-randomised trial', *The Lancet HIV*, 5(8), pp. e417–e426. doi: 10.1016/S2352-3018(18)30111-5.
- Creswell, J.W., & Creswell, J.D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches*. Thousand Oaks, United States : Sage Publications.
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dandona R, Dandona L, Gutierrez JP, Kumar AG, McPherson S, Samuels F, Bertozzi SM; ASCI FPP Study Team. 2005. *High risk of HIV in non-brothel based female sex workers in India*. *BMC Public Health* 2005; 5:87.
- Dandona, R. et al. (2005) 'High risk of HIV in non-brothel based female sex workers in India', 10, pp. 1–10. doi: 10.1186/1471-2458-5-87.
- David R., Hotchkiss, Deepali Godha, Anastasia J. Gage, Claudia Cappa. 2016. Risk factors Associated With the Practice of Sexual Transmittes Among Roma Girls in Serbia. *BMC International Health and Human Right*, 16:6.
- Delprato M., Akyeampong K., Dunne. 2017. Intergenerational Education Effects of Early Marriage in Sub-Sahara Africa. *World Development*, 91, 173-192.
- Delprato M., Akyeampong K. 2017. The Effect of Early Marriage Timing on Women's and Children's Health in Sub-Sahara Africa and Southwest Asia. *Annals of Global Health*, 83(3-4), pp.557-567 .
- Delprato M., Ricardo Sabates, Jimena Hernandez Fernandez. 2015. On the Impact of Adolescent sexual and reproductive health in Sub-Sahara Africa and South West Asia. *International Journal of Educational Development*, 44. 42-55
- Depkes RI. 2019. *Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia*. Ditjen PPM & PLP Depkes
- . 2019. *Pedoman Pengelolaan HIV/ AIDS*. Jakarta
- Depkes RI. Sekretaris Jenderal. (2014). *Kemitraan Menuju Indonesia Sehat*. Jakarta
- Deuba, K; Sarah Anderson; Anna M. (2016) 'Micro-level social and structural factors act synergistically to increase HIV risk among Nepalese female sex workers', *International Journal of Infectious Diseases*, 49, pp. 100–106. doi:

10.1016/j.ijid.2016.06.007.

- Emilia, O.2011. *Promosi Kesehatan dalam Lingkup Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Cendekia
- Eriksson, M.2010.Social Capital and Health Implication for Health Promotion. *International Conference on Public Health*. ISBN978-602-71484-1-3.Hal 33-51
- Febres-Cordero, B.Casauneva K;Teresita J.. (2018) 'Influence of peer support on HIV/STI prevention and safety amongst international migrant sex workers: A qualitative study at the Mexico-Guatemala border', *PLoS ONE*, 13(1), pp. 1–20. doi: 10.1371/journal.pone.0190787.
- Field.2018.Modal Sosial. Diterjemahkan oleh Nurhadi dari buku asli Social Capital 2003. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Fisher, B.A. (1978). *Perspectives on Human Communication*. New York : MacMillan Publishing co.
- Freeman, R.E. (2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge, England: Cambridge University Press
- Fitriani, S. 2011. *Promosi Kesehatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Freeman, R.E. (2010). *Strategic management: A stakeholders approach*. Cambridge, England: Cambridge university press.
- Gbagbo, F. Y. (2020) 'Experiences of commercial sex workers during COVID-19 restrictions in selected metropolises in Ghana', *Health Care for Women International*, 0(0), pp. 1–12. doi: 10.1080/07399332.2020.1822362.
- Ghufron M.Nur dan Risnawati, S.Rini.2010. Teori-Teori Psikologi. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gibbs, SE.,Le LC., Dao.,HB., and Blum, RW. 2014. Peer and Community Influences on The Acceptance of Premarital Sex Among Vietnamese Adolescentens; *J Paediatr Child Health*.2014 Jun;50 (6): 438-43. Doi:10.1111/jpc.12512. Epub 2014 Feb 25
- Gichuna, S;Hassan R;Mwangi P. (2020) 'Access to Healthcare in a time of COVID-19: Sex Workers in Crisis in Nairobi, Kenya', *Global Public Health*, 15(10), pp. 1430–1442. doi: 10.1080/17441692.2020.1810298.
- Gie, T.L. 2000. *Manajemen dan Motivasi*.Jakarta : Balai Pustaka Aksara
- Grath-Lone, L. M;. Marsh Kimberly;Hughes G.(2014) 'The sexual health of female sex workers compared with other women in England: Analysis of cross-sectional data from genitourinary medicine clinics', *Sexually Transmitted Infections*, 90(4), pp. 344–350. doi: 10.1136/sextrans-2013-051381

- Green, L. W., Kreuter, M., Deeds, S., Partridge, K., & Bartlett, E. (1980). *Health Education Planning: A Diagnostic Approach* (1st ed.). Pao Alto, California: Mayfield Pub Co.
- Guba, E.G., Lincoln, Y.S., & Denzin, N.K (1994). *Handbook of Qualitative research*. California : Sage, 105-117
- Halpern, David. 2005. *Social Capital*. Maiden: Polity Press.
- Harahap. 2012. *Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin*. Jakarta: FKUI.
- Harcourt C, Donovan B. 2005. *The many faces of sex work. Sexually Transmitted Infections Another decade of social scientific work on sex work: a review of research 1990–2000. Annual Review of Sex Research*, 2001, 12:242–289
- Hatu, RA. 2013. *Sosiologi Pembangunan*. Yogyakarta : Interpena
- Hewageegana Rajapaksa Neelamani, Hilary Piercy, Sarah Salway, Sarath Samarage. 2015. *Sexual and Reproductive Knowledge. Attitudes and Behaviours in a School Going Population of Sri Lankan Adolescents. Sexual & Reproductive Healthcare* 6. 3-8
- Hikmat H. 2014. *Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centred Development)*. Kemensos: Jakarta
- Hindin and Fatusi. 2009. *Adolescent Sexual and Reproductive Health in Developing Countries: An Overview of Trends and Interventions Gultmacher Institute*.
- Hoelman, Parhusip, Eko, Bhagijo dan Santono., 2015. *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah*. Jakarta: International NGO Forum On Indonesian Development
- Hubert, C; Platt L; Sherman G. (2019) 'Cristina Herrera,* Lourdes Campero,** Lourdes Barrera,*** Guillermo González,** Erika E. Atienzo,**** Fátima Estrada**', *Salud Pública de México*, 61(6, nov-dic), pp. 1–12. doi: 10.17605/OSF.IO/DEV2Y.
- Ife, J dan Tesoriero, F. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*. Diterjemahkan oleh: Sastrawan Manullang, Nurul yakin, dan M. Nursyahid. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Imron S. 2010. *Perkembangan Seksualitas Remaja*. Jakarta: PKBI
- Indonesia Ministry of National Development Planning and the United Nations children's Fund. 2017. *SDGs Baseline Report on Children in Indonesia*. Jakarta
- International Institute for Population Sciences (IIPS), ICF. 2017. *National Family Health Survey (NFHS-4)*, 2015-2016: India. Mumbai: IIPS

- Isfandari,Siti ; Sedyaningsih R.Endang dan Mahamit. 2005.*Kajian Penelitian Sosial dan Perilaku yang berkaitan dengan Infeksi menular Seksual, HIV/AIDS di Di Indonesia*, Dep Kes RI bekerjasama dengan KPAN, Jakarta.
- Januraga, P. P. (2020) 'The logic of condom use in female sex workers in Bali, Indonesia', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(5). doi: 10.3390/ijerph17051627.
- Joseph A.A Oluyemi, Yinusa Mohammed A.A., Abdullateef Raii A., Kehinde Kadirib and Adejoke Josephc. 2017. Parental Influence on Adolescent Sexual Behaviour Among Secondary School Students in Ogbomoso, Nigeria. *African Journal of Social Work*, 7(1), June.
- Joseph Nice. 2017. Effectiveness of Structured Teaching Program on Knowledge Regarding Health Consequences of Early Marriage and Late Marriage. *International Journal of Science and Healthcare Research*. Vol.2; Issue: 2; April-June.
- Kartono.2013. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kiderlen, T. R;Larissa Mayo;Wilson P. (2015) 'Cross-sectional study assessing HIV-related knowledge, attitudes and behavior in the Namibian truck transport sector: Readjusting HIV prevention programs in the workplace', *Journal of Infection and Public Health*, 8(4), pp. 346–354. doi: 10.1016/j.jiph.2015.02.001.
- Kibretb D. G., Workineh S., Degu G. 2015. Determinants of Early Marriage Among Female Children in Sinan District, Northwest Ethiopia. *Health Science Journal*. Vol.9 No.6:1
- Kiuru N. 2008. The Role of Adolescents Peer Groups in the School Context. *Academic Dissertation*. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla.
- Kodavalla, V., Rajkumar, H., Rachakulla, H., Prasad Saride, P. V., Kallam, S., & Veera Ginnela, B. N. (2015). Identification of Socio-Demographic, Behavioral Patterns and Their Relationship with HIV Status among Female Sex Workers. *World Journal of AIDS*, 05(01), 41–49. <https://doi.org/10.4236/wja.2015.51005>
- Komalasari G., Eka W. 2011. *Teori dan Praktik Konseling*. Jakarta: Indeks
- Kowalski R. 2014. *BukuAjar Kepemwalan Dasar* (10th.ed.). Jakarta: ECG
- Kusmiran. 2013. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Yogyakarta: Salemba Medika
- Lamichhane Prabhat, Mahesh Puri, Jyotsna Tamang and Bishnu Dulal. 2011. Women's Status and Attitudes female sex. *BMC Public Health*, 11:19.
- Laure, R. H. (2003). *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahy, M., Marsh, K., Sabin, K., Wanyeki, I., Daher, J., & Ghys, P. D. (2019). HIV estimates through 2018: Data for decision-making. *Aids*, 33(March 2019), S203–S211. <https://doi.org/10.1097/QAD.0000000000002321>

- Maldonado RW and Merrill SB.2002. *Building Partnership with the Community: Lessons from the Camden Health Improvement Learning Collaborative. Journal of Health Care Management* 45: 3 May/June 2002.
- Mansjoer, A. 2014. *Kapita Selekt Kedokteran*. Jakarta. FKUI.
- Manuaba, Ida Bagus Gde, 2010. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita., Edisi 2*. Jakarta : EGC.
- Mardikanto, T. 2010a. *Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: UNS Press.
- . 2010b. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Maryunani, A dan Aeman U. 2009. *Pencegahan dan penularan HIV dari Ibu ke Bayi*. Jakarta: Trans Info Media.
- McMillan, K. E. and Worth, H. (2016) 'Problematics of empowerment: Sex worker HIV prevention in the Pacific', *Health Promotion International*, 31(4), pp. 946–953. doi: 10.1093/heapro/dav069.
- Mgone CS;Passey Megan;Peter W;Russel M.2012. *Human immunodeficiency virus and other sexually transmitted infections among female sex workers in two major cities in Papua New Guinea. Sexually Transmitted Diseases*.9(5):265-270
- Milles, M .1999. *Analisa data kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Murayama H., Fujiwara Y., Kawachi I. 2012. Social Capital and Health: A Review of Prospective Multilevel Studies. *Journal of Epidemiology*, 22(3), 179-187.
- Muthmainnah, Jati, Suryoputro. 2016. Stakeholder Pemerintah Sebagai Prime Mover Keberhasilan Jejaring Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. *The Indonesian Journal of Health Promotion (Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia)*, 9(1), 45-55.
- Mmari K., Sabherwal S. 2013. A Review of Risk and Protective Factors for Adolescent Sexual and Reproductive Health in Developing Countries: An Update. *Journal of Adolescent Health*, 53(5), 562-572.
- Mpilambo J. E., Appunni S. S, Kanayo O., Stiegler N. 2017. Determinants of early Marriage among Young Women in Democratic Republic of Congo. *Journal of Social Sciences*, 52(1-3), 82-91.
- Oladipupo, O.B.O and Viatonu, O.2014. Influence of Family Characteristics and Cultural Norms on Pre-Marital Sex Among Secondary Scholl Students in Ojo Local Government Area of Lagos State Nigeria. *European Scientific Journal*.10 (5) hal 231-242.

- Olarinmoye A.O.E., Dairo D.M. and Adeomi A.A. 2011. Parental Attitudes and Practice of Sex Education of Childern in Nigeria. *Int J Child Health Hum Dev* 20 II;4(3):pp.301-307.
- Ortblad, K. F. and Oldenburg, C. E. (2018) 'Tailoring combination HIV prevention for female sex workers', *The Lancet HIV*, 5(8), pp. e406–e407. doi: 10.1016/S2352-3018(18)30136-X.
- Osborn, D.,Cutter, A.,A., & Ullah, F.(2015) Universal Sustainable Development Goals:Understanding the transformational challenge for developed countries. In *Report of a study by stakeholder forum* (pp.5-20).
- Pinem, Saroha, SKM, M.Kes, 2009. *Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*. Jakarta : Trans Info Medika.
- Platt, L;Meiskin R;Sherman G. (2018) *Associations between sex work laws and sex workers' health: A systematic review and meta-analysis of quantitative and qualitative studies*, *PLoS Medicine*. doi: 10.1371/journal.pmed.1002680.
- Ratnawati, riska (2002) *Perilaku Waria pekerja seks komersial (psk) dalam upaya penanggulangan penyakit menular seksual (psm) dan aids di kota madiun tahun 2002*. Semarang : Thesis S2 UNDIP.
- Rajapaksa Hewageegana N., Piercy H., Salway S., Samarage S. 2015. Sexual and Reproductive Knowledge, Attitudes and Behaviours in a School Going Population of Sri Lankan Adolescents. *Sexual and Reproductive Healthcare*, 6(1), 3-8.
- Reza-Paul, S;Richard S;Dallabeta G. (2019) 'Sex Worker Community-led Interventions Interrupt Sexually Transmitted Infection/Human Immunodeficiency Virus Transmission and Improve Human Immunodeficiency Virus Cascade Outcomes: A Program Review from South India', *Sexually Transmitted Diseases*, 46(8), pp. 556–562. doi: 10.1097/OLQ.0000000000001020.
- Rohan H. H., Siyoto S. 2013. *Buku Ajar Kesehafan Reproduksi*. Yogyakarta : Nuhamedika.
- Santrock, J.W. 2007. Remaja. Diterjemahkan oleh : *Benedictine Widysinta*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sartika, A. (2015) Strategi Komunikasi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam melakukan sosialisasi HIV/AIDS Di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 3 (1) :17-30
- Scheibe, A., Drame, F. M. and Shannon, K. (2012) 'HIV prevention among female sex workers in Africa', *Sahara J*. doi: 10.1080/17290376.2012.743809.
- Scorviani, Verra & Nugroho, T, (2011). *Mengupas Runtas 9 Jenis PMS (Penyakit Menular Seksual)*. Yogyakarta : Nuha Medika.

- Shohib, Firmanto, Kusuma, Martasari. 2016. Pendampingan Kelompok Konselor Sebaya di Kota Batu. *Jurnal Dedikasi*, (online), 13 (1) : 34-38. Available <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3135>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2021.
- Slabbert, M;Fenter F;Gay C;Edward S. (2017) 'Sexual and reproductive health outcomes among female sex workers in Johannesburg and Pretoria, South Africa: Recommendations for public health programmes', *BMC Public Health*, 17(Suppl 3), pp. 17–27. doi: 10.1186/s12889-017-4346-0.
- Sulaeman, E.S. 2016.*Pembelajaran Model dan Teori Perilaku Kesehatan Konsep dan Aplikasi*. Surakarta : UNS Press
- Sulaeman, E.S. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Ssekalembe, G., Atoillah, M., Isfandiari, & Suprianto, H. (2020). Current status towards 90-90-90 UNAIDS target and factors associated with HIV viral load suppression in Kediri City, Indonesia. *HIV/AIDS - Research and Palliative Care*, 12, 47–57. <https://doi.org/10.2147/HIV.S231173>
- Ssewamala, F. M;Bahar, O.S;Wilson,M.J.. (2019) 'A combination intervention addressing sexual risk-taking behaviors among vulnerable women in Uganda: Study protocol for a cluster randomized clinical trial', *BMC Women's Health*, 19(1), pp. 1–21. doi: 10.1186/s12905-019-0807-1.
- Strathdee, S. A. *et al.* (2013) 'HIV prevention among women in low- and middle-income countries: Intervening upon contexts of heightened HIV risk', *Annual Review of Public Health*, 34, pp. 301–316. doi: 10.1146/annurev-publhealth-031912-114411.
- Sultana, H. (2015) 'Sex worker activism, feminist discourse and HIV in Bangladesh', *Culture, Health and Sexuality*, 17(6). doi: 10.1080/13691058.2014.990516.
- Sztompka, P. (1999). *The Sociology Of Social Change*. Oxford: Blackwell
- Tamene, M. M., Tessema, G. A. and Beyera, G. K. (2015) 'Condom utilization and sexual behavior of female sex workers in Northwest Ethiopia: A cross-sectional study', *Pan African Medical Journal*, 21, pp. 1–10. doi: 10.11604/pamj.2015.21.50.6009.
- United Nations Joint Programme on HIV\$/AIDS and World Health Organization. Report of the global AIDS epidemic. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS/ UNHCR/ UNIOCEF/ WFP/ UNDP/ UNFPA/ UNESCO/ WHO/ WORLD BANK. Geneva. 2012
- United Nations Joint Programme on HIV/AIDS and World Health Organization. AIDS Epidemic Update 2006. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS / World Health Organization. Geneva. 2006

Wong ML, Roy Chan RKW, Chua WL, Wee S. *Sexually transmitted diseases and condom use among free-lance sex and brothel-based sex workers in Singapore. Sexually Transmitted Diseases* 1999;26;10:593-600.

World Health Organization, Regional Office for Western Pacific. 2010. *Controlling STI and HIV in Cambodia The Success of Condom Promotio*. Manila:WHO

WHO.(1998).Health Promotion Glossary.Geneva:Health Education and health Promotion Unit

GLOSARIUM

A

AIDS: kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh bukan disebabkan oleh penyakit bawaan namun disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus

G

Grounded theory: desain penelitian dimana peneliti ingin meneliti beberapa individu yang semuanya telah mengalami aktivitas, interaksi, atau proses dalam satu fenomena sehingga penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi.

H

HIV: virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh (limfosit) yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia.

K

Kualitatif: penelitian yang berfokus pada pengalaman, interpretasi serta makna hidup seseorang yang mengalaminya

INDEKS

MODEL PROMOSI KESEHATAN

AIDS

HIV

PEKERJA SEKSUAL TIDAK LANGSUNG

BAB 2

PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH

Rosyati Pastuty, S.SiT, M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 2

PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH

Rosyati Pastuty, S.SiT, M.Kes

A. Pendahuluan

Masa remaja atau yang disebut juga dengan masa transisi adalah masa penting kehidupan dimana terjadi perubahan dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa remaja terjadi banyak perubahan baik perubahan fisik, psikologis, sosial maupun biologis. Perubahan yang terjadi diakibatkan karena mulai aktif dan berkembangnya fungsi organ reproduksi, dengan ditandai datangnya menarche (menstruasi) pada remaja putri dan mimpi basah pada remaja putra. Perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa remaja, dipengaruhi oleh berfungsinya hormone testosterone pada laki-laki, progesterone dan estrogen pada perempuan. Hormone inilah yang berpengaruh terhadap dorongan seksual manusia.

Ketidak seimbangan perkembangan biologis dan psikososial pada masa remaja menimbulkan rasa ingin tahu yang sangat kuat, keinginan bereksplorasi dan memenuhi dorongan seksual mengalahkan pemahaman tentang norma, kontrol diri, pemikiran rasional sehingga tampil dalam bentuk perilaku; coba-coba berhubungan seksual yang akhirnya ketagihan dan melakukan perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab seperti perilaku pacaran yang mengarah untuk melakukan hubungan seksual pranikah atau seks bebas.

Pergaulan seksual di luar pernikahan atau *free sex* mulai bangkit di Amerika Serikat dan United Kingdom sejak tahun 1960-an mulai dari anak SMP (*Junior High School*), SMA (*Senior High School*), universitas dan di antara remaja yang sebaya di luar sekolah.

Data SDKI 2017 tercatat 80% wanita dan 84% pria mengaku pernah berpacaran. Terdapat 45% wanita dan 44% pria mulai pacaran pertama kali pada umur 15-17 tahun. Aktivitas yang dilakukan saat berpacaran seperti berpegangan tangan 64% wanita dan 75% pria, berpelukan 17% wanita dan 33% pria, cium bibir 30% wanita dan 50% pria, dan meraba/diraba 5% wanita dan 22% pria. Sebanyak 2% wanita dan 8% pria telah melakukan hubungan seksual, dengan alasan 47% saling mencintai, 30% penasaran/ingin tahu, 16% terjadi begitu saja, alasan karena dipaksa dan terpengaruh teman masing-masing 3%. Sebanyak 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-17 tahun. 12% wanita melaporkan kehamilan tidak diinginkan dan 7% dilaporkan oleh pria yang mempunyai pasangan dengan kehamilan tidak diinginkan. 23% wanita dan 19% pria mengetahui bahwa teman mereka melakukan aborsi, 1% diantaranya menemani/mempengaruhi teman/seseorang untuk menggugurkan kandungannya.

Berdasarkan data PKBI Jawa Tengah tahun 2004 aktivitas yang dilakukan dalam pacaran 100% ngobrol, 93,3% pegang tangan, 84,6% cium pipi/kening, 60,9% cium bibir, 36,1% cium leher, 25% meraba/petting, dan 7,6% *intercourse*.

B. Perilaku Seks Pranikah

Perilaku seksual didefinisikan sebagai perilaku yang berhubungan dengan fungsi reproduksi atau yang merangsang sensasi dalam reseptor yang terletak pada atau disekitar organ reproduksi dan daerah erogen. Sedangkan pranikah berasal dari kata “pra” berarti “sebelum” dan “nikah” berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri secara resmi. Secara umum “pranikah” didefinisikan sebagai hal yang terjadi sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri secara resmi.

Dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual pranikah merupakan segala bentuk perilaku yang didasari oleh dorongan seksual dan berhubungan dengan fungsi reproduksi atau yang merangsang sensasi pada reseptor yang terletak pada atau disekitar organ reproduksi dan daerah erogen untuk mendapatkan kenikmatan atau kesenangan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebelum adanya komitmen menjadi suami isteri. Hubungan seksual pranikah atau “*pre-marital sex*” merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Umumnya aktivitas demikian dilakukan oleh pasangan remaja yang ingin menyalurkan hasrat seksual dengan orang lain.

Seringkali terjadi perbedaan pengertian antara perilaku seksual dengan hubungan seksual. Perilaku seksual ditanggapi sebagai sesuatu hal yang selalu negative. Berikut adalah pengertian tentang batasan tentang perilaku seksual, aktivitas seksual dan hubungan seksual.

- Perilaku seksual merupakan perilaku yang bertujuan untuk menarik perhatian lawan jenis. Perilaku seksual sangat luas sifatnya, contohnya mulai dari berdandan, mejeng, merayu, menggoda, bersiul sekaligus juga yang terkait dengan aktivitas dan hubungan seksual.
- Aktivitas seksual adalah; kegiatan yang dilakukan dalam upaya memenuhi dorongan seksual atau kegiatan mendapatkan kesenangan organ kelamin atau seksual melalui berbagai perilaku. Contoh; berfantasi, masturbasi, nonton atau baca pornografi, cium pipi, cium bibir, petting, berhubungan intim (*intercourse*).
- Hubungan seksual adalah kontak seksual yang dilakukan berpasangan dengan lawan jenis atau sesama jenis. Contohnya; pegangan tangan, cium kering, cium basah, petting dan *intercourse*.

C. Dampak Aktivitas Dan Perilaku Seksual Pranikah

Beberapa dampak dan perilaku seksual pranikah, antara lain;

1. Berfantasi

Berfantasi merupakan perilaku membayangkan atau mengimajinasikan aktivitas seksual yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan erotisme. Dampak berfantasi;

- Dapat berlanjut ke kegiatan lainnya seperti; masturbasi, berciuman dan aktivitas seksual lainnya.
- Jika dibiarkan terlalu lama maka kegiatan produktifitas menjadi teralih kepada kegiatan berfantasi.
- Tidak berisiko penyakit menular seksual.

2. Berpegangan tangan

Aktifitas ini memang tidak terlalu menimbulkan rangsangan seksual yang kuat, namun biasanya muncul keinginan untuk mencoba aktivitas seksual lainnya (hingga kepuasan seksual dapat tercapai). Umumnya jika kita berpegangan tangan maka muncul getaran-getaran atau perasaan-perasaan aman dan nyaman. Berpegangan tangan juga mencerminkan rasa sayang.

3. Cium kering

Cium kering merupakan aktivitas seksual berupa sentuhan pipi dengan pipi dan pipi dengan bibir. Dampak perilaku cium kering:

- Imajinasi atau fantasi seksual menjadi berkembang.
- Menimbulkan perasaan sayang jika diberikan pada moment tertentu dan bersifat sekilas.
- Menimbulkan keinginan untuk melanjutkan ke bentuk aktifitas seksual yang lebih dapat dinikmati.

4. Cium basah

Cium basah merupakan aktivitas seksual berupa sentuhan bibir dengan bibir. Dampak dari cium basah;

- Dapat menimbulkan sensasi seksual yang kuat dan menimbulkan dorongan seksual yang kadang tidak terkendali. Orang akan mudah melakukan aktivitas selanjutnya tanpa disadari seperti cumbuan, petting bahkan sampai hubungan intim.
- Apabila perilaku ini dilakukan terus menerus akan menimbulkan perasaan ingin mengulanginya lagi.

5. Meraba

Meraba merupakan suatu kegiatan meraba atau memegang bagian tubuh yang sensitive seperti; payudara, vagina dan penis. Dampak dari tersentuhnya bagian yang paling sensitive tersebut adalah:

- Akan menimbulkan rangsangan seksual sehingga melemahkan kontrol diri dan akal sehat, akibatnya bisa melakukan aktifitas seksual selanjutnya (cumbuan berat dan *intercourse*).
- Ketagihan (keinginan untuk mengulang tindakan yang menyenangkan).
- Muncul perasaan dilecehkan pada pasangan.

6. Berpelukan

Dampak perilaku seksual berpelukan:

- Dapat membuat jantung berdegup lebih cepat
- Menimbulkan perasaan aman, nyaman dan tenang.
- Menimbulkan rangsangan seksual (terutama jika mengenai daerah erogenous).

7. Masturbasi

Masturbasi merupakan perilaku merangsang organ kelamin untuk mendapatkan kepuasan seksual. Dampak melakukan masturbasi:

- Infeksi terutama jika menggunakan alat-alat yang membahayakan seperti; benda tajam, benda lain yang tidak steril.
- Energi fisik dan psikis terkuras, biasanya orang menjadi lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi, malas melakukan aktivitas lain.
- Dapat merobek selaput dara (letak selaput dara hanya sekitar 1–1,5 cm dari permukaan vagina).
- Pikiran terus menerus kearah fantasi seksual.
- Perasaan bersalah dan berdosa.
- Bisa lecet jika dilakukan dengan frekuensi tinggi.
- Kemungkinan mengalami ejakulasi dini pada saat nantinya berhubungan intim.
- Kurang bisa memuaskan pasangan jika sudah menikah (karena terbiasa memuaskan diri sendiri atau merangsang diri sendiri).
- Menimbulkan kepuasan diri/eksplorasi diri.
- Menimbulkan ketagihan.

8. Oral seks

Perilaku oral seks adalah memasukan alat kelamin ke dalam mulut lawan jenis.

Dampak oral seks;

- Bisa terkena penyakit (radang tenggorokan ataupun pencernaan) jika pasangan mengidap Penyakit Menular Seksual (PMS).
- Menimbulkan ketagihan.
- Sanksi moral/agama
- Bisa berlanjut ke *intercourse*.
- Memuaskan kebutuhan seksual.
- Penyimpangan seksual (dalam kondisi dimana oral seks lebih memenuhi kebutuhan seksualnya dibandingkan *intercourse*).

9. Petting

Petting merupakan keseluruhan aktifitas seksual tanpa melakukan *intercourse* (hingga menempelkan alat kelamin). Dampak perilaku petting yaitu;

- Menimbulkan ketagihan.
- Hamil, karena cairan pertama yang keluar pada saat terangsang pada laki-laki juga sudah mengandung sperma (meski dalam kadar terbatas). Selain itu meskipun ejakulasi di luar, cairan vagina dapat menjadi medium yang membantu masuknya sperma ke dalam vagina.
- Terkena PMS/HIV.
- Bisa berlanjut ke *intercourse*.
- Sanksi moral/agama hingga menimbulkan perasaan cemas dan perasaan bersalah.
- Memuaskan kebutuhan seksual.
- Bisa menyebabkan robeknya selaput dara.

10. *Intercourse* atau bersenggama

Intercourse atau bersenggama merupakan aktivitas seksual dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Dampak melakukan *intercourse*;

- Perasaan bersalah dan berdosa terutama pada saat melakukan pertama kali.
- Ketagihan.
- Hamil.
- Terkena PMS/HIV.
- Infeksi saluran reproduksi.
- Gangguan fungsi seksual; impotensi, ejakulasi dini, frigiditas, vaginismus, dyspareunia.
- Sanksi sosial, moral dan agama.
- Keperawanan dan keperjakaan hilang.
- Menguras energi (karena sangat melelahkan ditambah lagi perasaan ketakutan dan perasaan berdosa memperkuat perasaan tidak nyaman yang muncul setelah melakukan *intercourse*).
- Terpaksa menikah.
- Aborsi, kematian dan kemandulan/infertile
- Merusak masa depan (terpaksa *drop out* sekolah, merusak nama baik pribadi dan keluarga).
- Mengalami konflik saat menjelang pernikahan.

Perilaku seksual remaja di Indonesia melalui beberapa tahapan; mulai dari menunjukkan perhatian pada lawan jenis, pacaran, berkencan, *lips kissing*, *deep kissing*, *genital stimulation*, *petting* dan *sexual intercourse*. Perilaku pacaran yang pernah dilakukan remaja berdasarkan Data SDKI 2017, meliputi; berpegangan

tangan, berpelukan, cium bibir dan meraba atau diraba. Berpegangan tangan merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh remaja (64% wanita dan 75% pria). Pria lebih cenderung melakukan cium bibir (50%) dan berpelukan (33%) dibandingkan dengan wanita (30% dan 17%).

D. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Pranikah

Beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku seksual pranikah :

1. Perspektif biologis;
Perubahan biologis yang terjadi pada masa pubertas dan pengaktifan hormonal dapat menimbulkan perilaku seksual.
2. Pengaruh orang tua;
Kurangnya komunikasi secara terbuka antar orang tua dengan remaja dalam masalah seputar seksual dapat memperkuat munculnya penyimpangan perilaku seksual.
3. Pengaruh teman sebaya;
Pada masa remaja, pengaruh teman sebaya sangat kuat sehingga munculnya penyimpangan perilaku seksual dikaitkan dengan norma kelompok sebaya.
4. Perspektif akademik
Remaja dengan prestasi rendah dan tahap aspirasi yang rendah cenderung lebih sering memunculkan aktivitas seksual dibandingkan remaja dengan prestasi yang baik di sekolah.
5. Perspektif sosial kognitif.
Kemampuan sosial kognitif diasosiasikan dengan pengambilan keputusan yang menyediakan pemahaman perilaku seksual di kalangan remaja. Remaja yang mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya dapat lebih menampilkan perilaku seksual yang lebih sehat.

E. Faktor Yang Mempengaruhi Dorongan Perilaku Seksual Pranikah

Faktor-faktor yang mempengaruhi dorongan perilaku seksual pranikah:

1. Pengalaman seksual
Makin banyak pengalaman mendengar, melihat, mengalami hubungan seksual makin kuat stimulasi yang dapat mendorong munculnya perilaku seksual. Misalnya; media massa (film, internet, gambar atau majalah), obrolan dari teman sebaya/pacar tentang pengalaman seks, melihat orang-orang yang tengah berpacaran atau melakukan hubungan seksual.
2. Faktor kepribadian.
Faktor kepribadian seperti; harga diri, control diri, tanggung jawab, *tolerance for stress, coping stress*, kemampuan membuat keputusan, nilai-nilai yang dimilikinya.

Remaja yang memiliki harga diri positif, mampu mengelola dorongan dan kebutuhannya secara adekuat, memiliki penghargaan yang kuat terhadap diri dan orang lain, mampu mempertimbangkan risiko perilaku sebelum mengambil keputusan, mampu mengikatkan diri pada teman sebaya secara sehat proporsional, cenderung dapat mencari penyaluran dorongan seksualnya secara sehat dan bertanggung jawab.

3. Pemahaman dan penghayatan nilai-nilai keagamaan

Remaja yang memiliki penghayatan yang kuat tentang nilai-nilai keagamaan, integrasi yang baik (konsistensi antara nilai, sikap dan perilaku) juga cenderung mampu menampilkan perilaku seksual yang selaras dengan nilai yang diyakininya serta mencari kepuasan dari perilaku yang produktif.

4. Berfungsinya keluarga dalam menjalankan fungsi kontrol afeksi/kehangatan, penanaman nilai moral dan keterbukaan komunikasi.

Keluarga yang mampu berfungsi secara optimal membantu remaja untuk menyalurkan dorongan seksualnya dengan cara yang selaras dengan norma dan nilai yang berlaku serta menyalurkan energi psikis secara produktif.

5. Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Remaja yang memiliki pemahaman secara benar dan proporsional tentang kesehatan reproduksi cenderung memahami risiko perilaku serta alternatif cara yang dapat digunakan untuk menyalurkan dorongan seksual secara sehat dan bertanggung jawab.

Faktor lain yang kadang diduga sebagai pendorong perilaku seksual adalah citra diri yang menyangkut keadaan tubuh (*body images*) dan kontrol diri. Ada beberapa pendapat bahwa orang yang kurang mengenal keadaan tubuhnya sendiri, atau yang menilai keadaan tubuhnya kurang sempurna, cenderung mengkompensasinya dengan perilaku seksual. Sehingga ia cenderung sangat membutuhkan pengakuan dari lawan jenis atau pasangannya tentang tubuhnya (ingin dikagumi), membuat kontrol diri terhadap perilakunya berkurang.

Orang yang percaya bahwa ia mampu mengatur keadaan dirinya sendiri (*locus of control internal*) akan kurang perilaku seksualnya dibandingkan orang yang merasa dirinya mudah dipengaruhi atau merasa bahwa keadaan dirinya lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor luar (*locus of control external*).

Beberapa hal yang menjadi motif remaja melakukan hubungan seksual jika dikaitkan dengan aspek motif individu, adalah;

1. Dorongan seksual yang menggebu-gebu dan sulit dikendalikan.
2. Dorongan afeksi (menyatakan/menerima ungkapan kasih sayang melalui aktivitas seksual).
3. Dorongan agresif (keinginan untuk menyakiti diri/orang lain).
4. Terpaksa (diperkosa, dipaksa pacar karena tidak bisa menolak ajakan melakukan hubungan seksual, takut kehilangan pacar dan lain sebagainya).

5. Dorongan untuk mendapatkan fasilitas /material melalui aktivitas seksual.
6. Dorongan atau keinginan untuk diakui oleh kelompok.
7. Dorongan atau keinginan untuk mencoba atau membuktikan fungsi atau kemampuan dari organ seksualnya.

Sehubungan dengan faktor penyebab perilaku seksual remaja, sangat penting bagi remaja untuk mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksualnya, sumber dari perilakunya serta motif perilakunya, agar remaja dapat lebih berupaya mengendalikan dorongan seksualnya secara lebih terarah.

Tanpa mengenali perilaku seksualnya maka akan muncul gejala ekstrim baik itu berupa perasaan bersalah atau berdosa yang sangat berlebihan (hingga mengganggu integritas kepribadiannya) atau sebaliknya terus melakukan hubungan seksual secara impulsif dengan menghilangkan akal sehat dan norma.

F. Cara Mengatasi Masalah Psikoseksual

Beberapa hal yang dapat dilakukan remaja dalam mencapai perilaku seksual yang sehat dan bertanggung jawab, yaitu:

1. Mendekatkan diri pada Tuhan dan berusaha keras menghayati norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku.
2. Penerimaan diri secara positif.
3. Mengendalikan diri (lebih banyak menggunakan akal pikiran atau rasional ketimbang menuruti perasaan atau emosi negatif).
4. Menjauhkan diri dari hal-hal yang menimbulkan hasrat seksual.
5. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat.
6. Membina relasi heteroseksual yang sehat, bertanggung jawab, alami dan bertujuan positif melalui komunikasi membentuk komitmen bersama.
7. Berusaha keras menghayati nilai-nilai remaja “remaja nggak oke berhubungan seksual sebelum menikah” dan “hubungan seksual merupakan hal sakral yang hanya dapat dilakukan dalam ikatan resmi/pernikahan”, karena pernikahan merupakan ikatan resmi yang bermuatan tanggung jawab diantara kedua belah pihak dengan berbagai alasan atau penalaran yang logis.
8. Menemukan kepuasan pada hal-hal lain selain dari kepuasan seksual (misalnya; kepuasan bergaul, beraktivitas, membantu orang lain, membaca ataupun melakukan berbagai kegiatan hobby). Idealnya, seseorang dapat menikmati seks pada saatnya, namun tidak menganggap seks sebagai tema kehidupan yang paling penting.
9. Memahami perilaku seksual diri kita masing-masing (motif, sumber-sumber rangsangan, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan lain-lain), sehingga kita dapat menghindari situasi atau stimulus yang membuat dorongan seksual makin kuat.

Bagi remaja yang sudah berpasangan (mempunyai pacar), biasanya dorongan atau godaan untuk melakukan hubungan seksual makin kuat. Remaja seringkali kabur dengan persepsi bahwa seks merupakan “cara mengungkapkan cinta”.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi remaja yang sudah mempunyai pasangan untuk mencegah agar dapat menghindari hubungan seksual pranikah, yaitu;

1. Membuat komitmen/kesepakatan bersama tentang batasan-batasan aktivitas seksual, serta berupaya keras untuk mematuhi komitmen tersebut. Dalam mengambil suatu keputusan perlu dipertimbangkan berbagai hal seperti; norma, nilai, risiko, manfaat, dan lain-lain.
2. Menghindari situasi atau tempat yang kondusif menimbulkan fantasi atau rangsangan seksual, seperti; pantai di malam hari, berdua di rumah, tempat yang sepi dan gelap, dan lain-lain.
3. Menghindari frekuensi pertemuan. Jika sering bertemu tanpa ada aktivitas yang pasti atau tetap, maka keinginan untuk mencoba aktivitas seksual biasanya makin kuat.
4. Banyak melibatkan teman atau saudara dalam berinteraksi. Sehingga kesempatan untuk selalu berdua makin berkurang.
5. Menemukan kegiatan alternatif yang baru sehingga dapat menemukan kepuasan yang mendalam dari interaksi yang terjalin (bukan kepuasan seksual), misalnya; berkebun, menulis buku, mengajar anak terlantar bersama, menjadi pembaca buku dikelompok tuna netra, dan lain sebagainya).

DAFTAR PUSTAKA

Asti, BM. (2005). *Jangan Pacarin Gue: Surakarta. Smart Media.*

BKKBN, BPS, Kemenkes RI. (2018). *Laporan SDKI 2017 Kesehatan Reproduksi Remaja: BKKBN, BPS dan Kemenkes RI : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive.*
<https://archive.org/details/LaporanSDKI2017Remaja/page/n5/mode/2up>

Kartono, Kartini. Gulo, Dali. (1987). *Kamus Psikologi: Bandung. Pionir Jaya.*

PKBI. IPPF. BKKBN. UNFPA. *Kesehatan Reproduksi Remaja: PKBI. IPPF.BKKBN. UNFPA; Jakarta.*

Sadily, Hasan. (1984). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: PTRineka Cipta.*

BAB 3
DETEKSI DINI CA CERVIX
DENGAN METODE SEDERHANA (IVA TEST)

Yunida Turisna Octavia, S.KM.MKM



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

BAB 3

DETEKSI DINI CA CERVIX
DENGAN METODE SEDERHANA (IVA TEST)

Yunida Turisna Octavia, S.KM. MKM

A. Latar Belakang

Pengertian Kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak normal/terus menerus dan tak terkendali, dapat merusak jaringan sekitarnya serta dapat menjalar ke tempat yang jauh dari asalnya yang disebut metastasis. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menyebabkan kematian, dapat berasal/tumbuh dari setiap jenis sel di tubuh manusia. (DepKes RI, 2009)

Leher rahim merupakan bagian dari uterus yang menjorok kedalam vagina yang terdiri dari pars vaginalis atau portio dan pars supra vaginalis uteri atau bagian kanalis yang berada diatas vagina saluran yang berada pada leher rahim disebut kanalis servikalis, panjangnya 2,5 cm yang dilapisi kelenjar-kelenjar bersilia yang berfungsi sebagai reseptakulum seminis dengan pintu saluran leher rahim sebelah dalam atau OUI (Ostium Uteri Internum) dan pintu saluran leher rahim di vagina atau OUE (Ostium Uteri Eksternum) (Prawirohardjo, 2010).

Kanker leher rahim adalah keganasan yang terjadi berasal dari sel leher Rahim yang disebabkan oleh neoplasma. Neoplasma adalah penyakit pertumbuhan sel yang terjadi karena didalam tubuh timbul dan terjadi perkembangbiakan sel-sel yang baru, yang bentuk dan sifat kinetiknya berbeda dari sel-sel normal asalnya sehingga merusak bentuk atau fungsi organ yang terkena. Neoplasma ini terjadi karena mutasi atau transformasi sel akibat ada kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel

Di Indonesia menunjukkan bahwa angka kejadian penyakit kanker pada perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100.000 penduduk yang diikuti kanker leher rahim (serviks) sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk, hal ini menggambarkan bahwa setiap tahun terdapat 50 perempuan di Indonesia meninggal dunia akibat kanker leherrahim. Kasus Kanker serviks di Indonesia pada tahun 2020 terdapat 36.633 kasus baru dan 21.003 kematian akibat kanker serviks. Berdasarkan analisis terdapat 50 kejadian kanker serviks setiap harinya dengan kurang lebih dua kematian setiap jam, perkiraan kanker serviks 17 per 100.000 perempuan dan kanker ini merupakan kanker kedua terbanyak pada perempuan di Indonesia (Globocan, 2020).

Berdasarkan data WHO tercatat, setiap tahun ribuan wanita meninggal karena penyakit kanker serviks ini dan merupakan jenis kanker yang menempati peringkat teratas sebagai penyebab kematian wanita dunia. Kanker serviks

menyerang pada bagian organ reproduksi kaum wanita, tepatnya di daerah leher rahim atau pintu masuk ke daerah Rahim yaitu bagian yang sempit di bagian bawah antara kemaluan wanita dan Rahim.

Penyebab Kanker Leher Rahim Penyebab utama kanker leher rahim adalah infeksi Human Papilloma Virus (HPV). Saat ini terdapat 138 jenis HPV yang sudah dapat teridentifikasi yang 40 di antaranya dapat ditularkan lewat hubungan seksual. Beberapa tipe HPV virus risiko rendah jarang menimbulkan kanker, sedangkan tipe yang lain bersifat virus risiko tinggi. Baik tipe risiko tinggi maupun tipe risiko rendah dapat menyebabkan pertumbuhan abnormal pada sel tetapi pada umumnya hanya HPV tipe risiko tinggi yang dapat memicu kanker

Deteksi dini kanker pada leher rahim tersebut sangat penting dilakukan, karena potensi kesembuhan akan sangat tinggi jika masih ditemukan pada tahap prakanker. Pencegahan kanker serviks dapat dilakukan dengan program deteksi dini (skrinning) dan pemberian vaksinasi. Adanya program deteksi dini di negara maju, angka kejadian kanker serviks dapat menurun. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan dengan Pap Smear (mengambil lendir serviks untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium), kolposkopi (pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan teropong), biopsy (pemeriksaan dengan mengambil sedikit jaringan serviks yang dicurigai), dan IVA Test (Inspeksi Visual Asam Asetat).

Tes IVA adalah sebuah pemeriksaan skrinning pada kanker serviks dengan menggunakan asam asetat 3-5% pada inspekulo dan dapat dilihat dengan pengamatan secara langsung. Berdasarkan hasil uji diagnostik, pemeriksaan IVA memiliki sensitifitas 84%, spesifisitas 89%, nilai duga positif 87%, dan nilai duga negatif 88%, 4 sedangkan pemeriksaan pap smear memiliki sensitifitas 55%, spesifisitas 90%, nilai duga positif 84%, dan nilai duga negatif 69%, sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan IVA lebih cepat memberikan hasil sensitivitas yang tinggi. Metode IVA ini merupakan sebuah metode skrinning yang praktis dan murah, sehingga diharapkan temuan kanker serviks dapat diketahui secara dini. Penyebab yang menjadi kendala pada wanita dalam melakukan deteksi dini kanker serviks adalah keraguan akan pentingnya pemeriksaan, kurang pengetahuan, dan takut akan rasa sakit serta keengganan karena malu saat dilakukannya pemeriksaan. Kesadaran yang rendah pada masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian kanker leher rahim di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Kanker serviks merupakan kanker yang menduduki urutan kedua dari kejadian kanker di Indonesia. Kanker serviks yang terjadi karena virus HPV ini untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan deteksi dini melalui pemeriksaan seperti pemeriksaan IVA. Masih tingginya insiden kanker serviks di Indonesia disebabkan

oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan perempuan yang sudah menikah untuk melakukan deteksi dini. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Rendahnya pengetahuan perempuan tentang pemeriksaan IVA mengakibatkan mereka kurang mengetahui tentang manfaat dari deteksi dini kanker serviks, hal ini berdampak pada rendahnya pengambilan keputusan untuk melakukan pemeriksaan IVA. Dari permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui tingkat pengetahuan wanita tentang kanker serviks terhadap perilaku dalam pemeriksaan IVA.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui hubungan tingkat kesadaran dengan pengambilan keputusan wanita usia subur melakukan pemeriksaan dini kanker serviks.

2. Tujuan Khusus

- Mengidentifikasi pengetahuan wanita usia subur tentang kanker serviks.
- Mengidentifikasi perilaku wanita subur dalam melakukan pemeriksaan IVA.
- Mengidentifikasi hubungan tingkat pengetahuan kanker serviks terhadap perilaku pemeriksaan IVA.

D. Kanker Serviks

1. Pengertian

Pengertian Kanker adalah pertumbuhan sel yang tidak normal/terus menerus dan tak terkendali, dapat merusak jaringan sekitarnya serta dapat menjalar ke tempat yang jauh dari asalnya yang disebut metastasis. Sel kanker bersifat ganas dan dapat menyebabkan kematian, dapat berasal/tumbuh dari setiap jenis sel di tubuh manusia.

Leher rahim merupakan bagian dari uterus yang menjorok kedalam vagina yang terdiri dari pars vaginalis atau portio dan pars supra vaginalis uteri atau bagian kanalis yang berada diatas vagina saluran yang berada pada leher rahim disebut kanalis servikkalis, panjangnya 2,5 cm yang dilapisi kelenjar-kelenjar bersilia yang berfungsi sebagai reseptakulum seminis dengan pintu saluran leher rahim sebelah dalam atau OUI (Ostium Uteri Internum) dan pintu saluran leher rahim di vagina atau OUE (Ostium Uteri Eksternum).

Leher rahim dikatakan abnormal apabila pasca pengolesan mengalami perubahan warna menjadi putih (aceto white ephitelum) dengan batas tegas. Jika hal tersebut terjadi, bisa saja pasien memiliki lesi prakanker. Jika tidak ada perubahan warna pasca pengolesan, maka leher rahim dianggap normal dan tidak ada infeksi pada serviks. Beberapa kelompok wanita yang direkomendasikan untuk tidak memilih deeksi dini IVA, seperti, wanita yang telah mengalami

menopause karena daerah zona transisional sesering terletak di kanalis servikalis dan tidak tampak dengan pemeriksaan inspekulo.

2. Penyebab

Faktor penyebab kanker leher rahim ialah :

- a. Penggunaan wc umum yang sudah terkena virus HPV, jika tidak membersihkannya dengan baik dapat menjangkit seseorang yang menggunakannya
- b. Kebiasaan merokok
- c. Kurangnya asupan vitamin terutama vitamin c dan vitamin e
- d. Kurangnya asupan asam folat
- e. Seringnya melakukan hubungan intim dengan berganti pasangan
- f. Melakukan hubungan intim dengan pria yang sering berganti pasangan dan melakukan hubungan intim pada usia < 16 tahun
- g. Penggunaan pil kb dalam jangka waktu yang sangat lama
- h. Terlalu sering melahirkan dan adanya keturunan kanker

3. Faktor Resiko

a. Berhubungan Seksual Dengan Pria Yang Mempunyai Pasangan Lebih Dari Satu

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara lesi pra kanker dan kanker serviks dengan aktivitas seksual pada usia dini, khususnya sebelum umur 17 tahun. Hal ini diduga ada hubungan dengan belum matangnya daerah transformasi pada usia tersebut bila sering terekspos. Frekuensi hubungan seksual berpengaruh terhadap lebih tingginya risiko pada usia, tetapi tidak pada kelompok usia lebih tua. Jumlah pasangan seksual menimbulkan konsep pria berisiko tinggi sebagai vektor yang dapat menimbulkan infeksi yang berkaitan dengan penyakit hubungan seksual (Suwiyoga, 2007). Sedangkan Nugraha B.D (2003) menganalisis bahwa akan terjadinya perubahan pada sel leher rahim pada wanita yang sering berganti-ganti pasangan, penyebabnya adalah sering terendamnya sperma dengan kadar PH yang berbeda- beda sehingga dapat mengakibatkan perubahan dari displasia menjadi kanker

b. Paritas

Kanker serviks sering terjadi pada wanita yang sering melahirkan. Semakin sering melahirkan, semakin besar risiko mendapatkan kanker serviks. Paritas dapat meningkatkan insiden kanker serviks, lebih banyak merupakan refleksi dari aktivitas seksual dan saat mulai kontak seksual pertama kali daripada akibat trauma persalinan. Pada wanita dengan paritas 5 atau lebih mempunyai risiko terjadinya kanker serviks 2,5 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita dengan paritas 3 atau kurang.

c. Merokok

Menurut Suwiyoga (2007) dilihat dari segi epidemiologinya, perokok aktif dan pasif berkontribusi pada perkembangan kanker serviks yaitu 2 sampai 5 kali lebih besar dibandingkan dengan yang tidak perokok. Pada wanita yang merokok terdapat nikotin yang bersifat ko karsinogen di cairan serviksnya sehingga dapat mendorong terjadinya pertumbuhan kanker

d. Kontrasepsi Oral

Kondom dan diafragma dapat memberikan perlindungan. Kontrasepsi oral yang dipakai dalam jangka panjang yaitu lebih dari 5 tahun dapat meningkatkan risiko relatif 1,53 kali. *World Health Organization* (WHO) melaporkan risiko relatif pada pemakaian kontrasepsi oral sebesar 1,19 kali dan meningkat sesuai dengan lamanya pemakaian

e. Defisiensi Gizi

Banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang mengandung bahan-bahan antioksidan seperti alpukat, brokoli, kol, wortel, jeruk, anggur, bawang, bayam dan tomat berkhasiat untuk mencegah terjadinya kanker. Dari beberapa penelitian melaporkan defisiensi terhadap asam folat, vitamin C, vitamin E, beta karotin, atau retinol dihubungkan dengan peningkatan risiko kanker serviks

f. Sosial Ekonomi

Tingkat sosial ekonomi seseorang dapat mempengaruhi terjadinya kanker serviks. Menurut Suwiyoga (2007) pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang menunjukkan bahwa infeksi HPV lebih prevalen pada wanita dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah. Adanya kaitan yang erat antara status sosial ekonomi rendah dengan status gizi karena status gizi berhubungan dengan daya tahan tubuh baik terhadap infeksi maupun kemampuan untuk melawan keganasan.

4. Gejala

Pada tahapan pra kanker sering tidak ditemukannya gejala (asimtomatis). Bila ada gejala yang timbul biasanya keluar keputihan yang tidak khas. Namun, beberapa gejala mengarah kepada infeksi HPV menjadi kanker serviks antara lain:

- a. Terdapat keputihan berlebihan, berbau busuk dan tidak sembuh-sembuh.
- b. Adanya pendarahan tidak normal. Hanya terjadi bila setelah sel-sel leher rahim menjadi bersifat kanker dan menyerang jaringan-jaringan di sekitarnya.
- c. Pemberhentian darah lewat vagina.
- d. Meningkatnya perdarahan selama menstruasi
- e. Terjadinya siklus diluar menstruasi dan setelah hubungan seks.
- f. Nyeri selama berhubungan seks.

- g. Kesulitan atau nyeri dalam perkemihan.
- h. Terasa nyeri didaerah sekitar panggul.
- i. Perdarahan pada masa pra atau pasca menopause.
- j. Bila kanker sudah mencapai stadium tiga ke atas, maka akan terjadi pembengkakan diberbagai anggota tubuh seperti betis, paha, tangandan sebagainya

5. Pencegahan

Pencegahan kanker didefinisikan sebagai mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kanker pada manusia dan membuat penyebabnya tidak efektif dengan cara-cara apapun (Sjamsuddin, 2001). Pencegahan terhadap terjadinya kanker serviks melalui tiga bagian, yaitu pencegahan primer, sekunder dan tersier.

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer kanker serviks merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari diri dari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kanker. Masyarakat yang melakukan pencegahan pada tingkat ini akan bebas dari penderitaan, produktivitas berjalan terus, tidak memerlukan biaya untuk pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi serta perawatan lebih lanjut. Salah satu bagian dari pencegahan primer adalah memberikan vaksin *Human Papilloma Virus* (HPV), pemberian vaksin HPV akan mengeliminasi infeksi HPV

b. Pencegahan Sekunder

Deteksi dini dan skrining merupakan pencegahan sekunder kanker serviks. Tujuan dari pencegahan sekunder adalah untuk menemukan kasus-kasus dini sehingga kemungkinan penyembuhan dapat ditingkatkan. Selain itu, bertujuan untuk memperlambat atau menghentikan penyakit pada stadium awal. Pencegahan sekunder melalui diagnosis dini displasia dengan berbagai cara baik klinis maupun laboratorium (Suwiyoga, 2007). Menurut Andrijono (2007) pencegahan sekunder mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:

- Pencegahan sekunder tidak mencegah terjadinya NIS (CIN).
- Terapi lesi prakanker yang baru terdeteksi pada pencegahan sekunder sering kali menimbulkan morbiditas terhadap fungsi fertilitas pasien.
- Pencegahan sekunder akan mengalami hambatan pada sumber daya manusia dan alat yang kurang

c. Pencegahan Tersier

Tujuan dari pencegahan tersier adalah untuk mencegah komplikasi penyakit dan pengobatan, sesudah gejala klinis berkembang dan diagnosis sudah ditegakkan. Terdapat dua pengobatan pada pencegahan tersier yaitu :

- i. Pengobatan pada pra kanker.
 - Kauterisasi yaitu membakar serviks secara elektrik.
 - Kriosurgeri yaitu serviks dibuat beku sampai minus 80-180 derajat celcius dengan menggunakan gas CO₂ atau N₂O.
 - Konisasi yaitu memotong sebagian dari serviks yang cukup representatif dengan pisau biasa atau pisau elektrik.
 - Operasi (histerektomi) bila penderita tidak ingin punya anak lagi.
 - Sinar laser yang digunakan dibawah pengawasan kolposkop, radiasi dengan pemanasan jarum radium yang dapat digunakan bila penderita yang sudah tua takut dioperasi.
- ii. Pengobatan pada kanker invasif
Tindakan pengobatan pada kanker invasif berupa radiasi, operasi atau gabungan antara operasi dan radiasi

6. Skrining

Mencegah kanker serviks dapat dilakukan dengan mendeteksi secara dini, tujuannya adalah untuk menemukan lesi pra kanker dan kanker stadium awal (Sjamsuddin, 2001). Saat ini terdapat beberapa cara alternatif untuk skrining kanker serviks yaitu: (Nuranna, 2001)

- Kolposkopi digunakan sebagai alat pemeriksaan awal dan lebih sering digunakan untuk pemeriksaan lanjutan dari hasil test pap smear yang abnormal. Namun, kolposkopi jarang digunakan karena biayanya yang mahal, kurang praktis dan memerlukan biopsi.
- Servikografi merupakan pemeriksaan untuk melihat kelainan porsio. Untuk membuat foto pembesaran porsio dipulas dengan menggunakan asam asetat 3-5%.
- Pap net (dengan komputerisasi) merupakan slide pemeriksaan pap smear untuk mengidentifikasi sel yang abnormal dibantu dengan menggunakan komputerisasi.
- Tes molekular HPV-DNA membuktikan bahwa 90% kandiloma serviks, NIS dan kanker serviks mengandung HPV-DNA.
- Inspeksi visual dengan asam asetat (IVA) menjadi metode skrining alternatif yang mudah untuk diaplikasikan diberbagai negara. Pada umumnya metode IVA mudah, praktis, alat yang digunakan sederhana, dapat dilakukan oleh petugas kesehatan bukan dokter dan metode ini sesuai dengan pusat pelayanan kesehatan yang sederhana. Untuk pemeriksaan serviks dengan IVA, awalnya dengan menggunakan spekulum yang sudah diolesi oleh asam asetat 3-5%. Pada lesi pra kanker akan terlihat bercak berwarna putih yang disebut *aceto white epithelium*, maka dapat disimpulkan bahwa dari bercak putih hasil test adalah IVA positif sehingga dapat ditindak lanjuti dengan melakukan biopsi

E. IVA TEST

1. Pengertian

IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) merupakan salah satu metode deteksi dini adanya kanker leher rahim. Skrining dengan IVA ini dinyatakan lebih mudah, lebih sederhana, dan lebih murah dibandingkan dengan tes pap smear, karena itu pemeriksaan IVA ini memberikan harapan besar untuk terlindung dari ganasnya efek kanker leher rahim, jenis kanker yang paling banyak ditemukan pada perempuan berusia 25 tahun keatas. Masalah yang menghadang dalam penanggulangan kanker leher rahim adalah masih rendahnya angka cakupan deteksi dini atau skrining kanker ini.

Pemeriksaan IVA merupakan pemeriksaan skrining alternatif dari pap smear karena biasanya murah, praktis, sangat mudah untuk dilaksanakan dan peralatan sederhana serta dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter ginekologi. Pada pemeriksaan ini, pemeriksaan dilakukan dengan cara melihat serviks yang telah diberi asam asetat 3-5% secara inspekulo. Setelah serviks diulas dengan asam asetat, akan terjadi perubahan warna pada serviks yang dapat diamati secara langsung dan dapat dibaca sebagai normal atau abnormal. Dibutuhkan waktu satu sampai dua menit untuk dapat melihat perubahan-perubahan pada jaringan epitel.

2. Manfaat Pemeriksaan IVA

- a. Mendeteksi adanya warna putih (acetowhite) pada serviks yang merupakan tanda pra kanker sejak dini.
- b. Jika pra kanker atau kanker dapat diketahui maka dapat dilakukan upaya pengobatan sejak dini.
- c. Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada wanita akibat kanker serviks.

3. Syarat Mengikuti Pemeriksaan IVA

- a. Sudah pernah melakukan hubungan seksual
- b. Tidak sedang datang bulan/haid
- c. Tidak sedang hamil
- d. 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual

4. Jadwal IVA

Menurut Marmi (2013) dan Kementerian Kesehatan RI (2013) mengatakan ada beberapa jadwal untuk melakukan deteksi dini kanker serviks yaitu:

- a. Skrining pada setiap wanita minimal 1x pada usia 30-50 tahun.
- b. Seorang perempuan yang mendapat hasil tes IVA negatif, harus menjalani penapisan minimal 5 tahun sekali. Mereka yang mempunyai hasil tes IVA positif dan mendapatkan pengobatan, harus menjalani tes IVA berikutnya enam bulan kemudian.

- c. Ideal dan optimal pemeriksaan dilakukan setiap 3 tahun pada wanita usia 25-60 tahun.

5. Kategori Pemeriksaan IVA

- a. IVA negative
Tidak ada tanda atau gejala kanker serviks atau serviks normal berbentuk licin, merah muda, bentuk porsio normal.
- b. IVA radang
Serviks dengan radang (servisititis), atau kelainan jinak lainnya seperti polip serviks.
- c. IVA positif
Ditemukan bercak putih (aceto white epithelium).
- d. IVA kanker serviks
Pertumbuhan seperti bunga kol, dan pertumbuhan mudah berdarah. Ini masih memberikan harapan hidup bagi penderitanya jika masih pada stadium invasive dini (Stadium IB-IIA). (Sukaca, 2009)

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemeriksaan IVA

- a. Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mendorong seseorang lebih peduli untuk meningkatkan derajat kesehatan dirinya maupun keluarganya. Teori Lawrence Green dalam Masturoh (2016) pendidikan merupakan salah satu faktor sosiodemografi yang berpengaruh besar terhadap perilaku kesehatan. Pendidikan menjadikan seseorang memiliki pengetahuan yang luas dan pola pikirnya akan terbangun dengan baik sehingga kesadaran untuk berperilaku positif dalam bidang kesehatan juga akan meningkat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah menerima informasi sehingga semakin banyak pula menerima pengetahuan yang dimilikinya, dan jika tingkat pendidikan rendah, maka menghambat perkembangan perilaku seseorang terhadap penerimaan informasi, dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan. WUS dengan pendidikan yang tinggi memiliki keikutsertaan dalam pemeriksaan IVA lebih tinggi dibandingkan dengan WUS yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah (Masturoh, 2016).
- b. Pengetahuan
Pengetahuan adalah hasil tahu seseorang yang diperoleh melalui penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indra manusia yaitu mata, telinga, hidung, mulut dan juga indra peraba (Notoatmodjo, 2016). Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh informasi yang dapat diakses oleh WUS tentang pemeriksaan IVA, salah satunya melalui penyuluhan yang memungkinkan pengetahuan WUS akan semakin baik. Tindakan seseorang yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dibandingkan dengan tanpa didasari oleh pengetahuan. Pengaruh pengetahuan

terhadap praktek dapat bersifat langsung maupun melalui perantara sikap. Pengetahuan merupakan bagian terpenting dalam membentuk tindakan seseorang. Masturoh (2016) menyebutkan bahwa WUS yang memiliki pengetahuan baik terbukti melakukan pemeriksaan IVA, sebaliknya WUS yang memiliki pengetahuan buruk keikutsertaannya dalam pemeriksaan IVA kurang

c. Dukungan

Dukungan yang merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang didalamnya terdapat hubungan yang saling memberi dan menerima bantuan yang bersifat nyata, bantuan tersebut akan menempatkan individu-individu yang terlibat dalam sistem sosial (Widayanti, dkk., 2020). Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan adalah bentuk interaksi sosial yang terdapat hubungan saling memberi dan menerima bantuan dari orang-orang di sekitar individu tersebut. Dukungan suami menjadi faktor penentu karena memberikan penguatan terhadap WUS untuk melakukan pemeriksaan IVA.

d. Akses pelayanan

Pelayanan kesehatan yang tersedia di masyarakat harus bersifat berkesinambungan. Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat ada pada setiap saat yang dibutuhkan untuk berperilaku sehat disertai dengan sarana dan prasarana pendukung. Keterjangkauan untuk mencapai tempat layanan kesehatan tersebut, sangat mendukung seseorang untuk melakukan tindakan. Jarak menuju tempat pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap perilaku pemeriksaan kanker serviks dengan metode IVA dimana jarak fasilitas kesehatan yang terjangkau bagi WUS akan meningkatkan perilaku pemeriksaan IVA. Hal ini disebabkan karena jarak membatasi kemampuan dan kemauan wanita untuk mencari pelayanan.

e. Keterjangkauan biaya

Biaya pengobatan adalah banyaknya uang yang dikeluarkan seseorang untuk melakukan pengobatan penyakit yang dideritanya. Kemampuan masing-masing orang untuk mengeluarkan biaya pengobatan berbeda, dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga. Keluarga dengan kemampuan ekonomi cukup, ada kemungkinan akan mampu mengeluarkan biaya untuk pengobatan penyakitnya. Keluarga dengan kemampuan ekonomi kurang atau kecil kemungkinan kurang mampu menyisihkan uang untuk biaya pemeriksaan. Mahalnya biaya pemeriksaan IVA juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan pemeriksaan. Biaya pemeriksaan yang terjangkau oleh semua kalangan ekonomi masyarakat memungkinkan seseorang untuk melakukan pemeriksaan. Persepsi seseorang terhadap biaya pengobatan mempengaruhi keikutsertaan dalam melaksanakan pemeriksaan

IVA secara rutin ini khususnya bagi WUS yang melakukan pemeriksaan IVA secara mandiri.

f. Motivasi

Keikutsertaan IVA merupakan salah satu perilaku kesehatan yaitu perilaku pencegahan penyakit, perilaku dalam hal ini merupakan refleksi atau respon dari berbagai macam gejala kejiwaan seperti pengetahuan, motivasi, persepsi, sikap dan sebagainya (Wawan dan Dewi, 2019). George Terry dalam Notoatmodjo (2016) merumuskan bahwa motivasi adalah keinginan yang ada pada diri individu yang mendorong individu tersebut untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku..

7. Persiapan dalam melakukan pemeriksaan IVA, sebagai berikut:

- a. Sabun dan air untuk cuci tangan
- b. Lampu yang terang untuk melihat serviks
- c. Spekulum dengan desinfeksi tingkat tinggi
- d. Sarung tangan sekali pakai atau desinfeksi tingkat tinggi
- e. Meja ginekologi HPV
- f. Lidi kapas
- g. Asam asetat 3-5% atau anggur putih (white vinegar)
- h. Larutan iodium lugol
- i. Larutan klorin 0,5 % untuk dekontaminasi instrument dan sarung tangan
- j. Format pencacatan.

F. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi dengan pendekatan cross sectional dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian adalah wanita usia subur di wilayah puskesmas Sukoharjo. Pengambilan sampel diambil secara purposive sampling terdiri dari wanita usia subur sejumlah 41 responden dengan kriteria inklusi WUS usia 30 – 50 tahun, belum pernah melakukan pemeriksaan dini kanker serviks.

Sebelum mengambil data dan responden menyatakan setuju, peneliti memberikan penjelasan kepada responden tentang maksud dan tujuan penelitian ini, kemudian mengisi lembar persetujuan menjadi responden dan bersedia menjadi responden dalam penelitian ini tanpa ada unsur keterpaksaan. Instrumen dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner 20 pernyataan untuk tingkat kesadaran dan 5 pernyataan untuk keputusan, kemudian data ditabulasi dan dilakukan analisis dengan menggunakan uji korelasi Pearson menggunakan SPSS 17. Sebelumnya telah dilakukan uji normalitas data menggunakan uji kolmogorof smirnov yang hasil data berdistribusi normal.

G. Hasil

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis univariat

Tabel 3.1. Karakteristik Responden berdasarkan Umur, Pendidikan, Pekerjaan, Tingkat Kesadaran dan Keputusan

Kategori	Frekuensi (n)	%
Umur		
30-40	25	61
41-50	16	39
Pendidikan		
Sekolah Dasar	11	26
Sekolah Menengah	20	49
Pendidikan Tinggi	10	24
Pekerjaan		
Bekerja	27	66
Tidak Bekerja	14	34
Tingkat Kesadaran		
Rendah	12	29,3
Sedang	26	63,4
Tinggi	3	7,3
Keputusan		
Positif	13	31,7
Negatif	28	68,3

Usia responden berdasarkan Tabel 1 diketahui usia responden adalah 30-40 sebanyak 61%, usia 41-50 tahun sebanyak 39% Usia minimum responden 30 tahun dan maksimal 50 tahun. Rata-rata usia responden 30-40 tahun. Deteksi dini kanker leher rahim dilakukan pada kelompok sasaran perempuan 20 tahun ke atas, namun prioritas program deteksi dini di Indonesia pada perempuan usia 30-50 tahun. Rentang umur tersebut mempunyai risiko tinggi terkena kanker serviks yaitu terjadi pada kelompok wanita usia subur yang aktif seksual. Kelompok umur dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan responden. menurut teori menyebutkan bahwa semakin umur seseorang semakin meningkat pengetahuan dan pengalamannya. Pendidikan berdasarkan tabel 1 diketahui jumlah yang mempunyai pendidikan dasar 26%, pendidikan menengah 49%, pendidikan tinggi 24%. Rata –rata responden memiliki pendidikan menengah Pekerjaan berdasarkan Tabel 1. diketahui jumlah yang bekerja 67%, tidak bekerja 33%. Ratarata responden adalah wanita pekerja. Tingkat kesadaran berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari tingkat kesadaran WUS dengan kategori kesadaran rendah sebanyak 29,3 %, kategori kesadaran sedang 63,4%, dan kategori kesadaran tinggi 7,3 %.. Keputusan responden berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari pengambilan keputusan responden positif sebanyak 68,3 %, sedangkan WUS yang mempunyai keputusan negatif sebanyak 31,7%

Tabel 3.2

		Kesadaran	Keputusan
Kesadaran	Pearson correlation	1	.293
	sig. (2-tailed)		.063
			1
Keputusan	Pearson correlation	.293	41
	sig. (2-tailed)	.063	
		41	

Berdasarkan tabel 2 Hasil analisis menunjukkan tidak ada hubungan antara tingkat kesadaran dengan pengambilan keputusan WUS melakukan pemeriksaan dinikanker serviks (r: 0,293 p=0,063)

H. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa responden belum melakukan pemeriksaan dini karena dipengaruhi oleh perasaan takut. Ketakutan responden karena faktor prosedur sebesar 14% dan 86 % takut ketahuan hasilnya yang bisa menyebabkan timbulnya masalah dikemudian hari. Faktor psikologis merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengenali perasaan seseorang, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat serta mengambil tindakan (Lamb, 2001). Faktor psikologis terdiri atas motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan dan sikap. Upaya untuk mempertahankan kesehatan memerlukan adanya pengambilan keputusan yang tepat dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Pengambilan keputusan merupakan hasil dari sebuah pemikiran kritis yang ditujukan untuk menyelesaikan atau memecahkan sesuatu. Proses pengambilan keputusan umumnya dilakukan dalam memilih suatu keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif sehingga terbentuk dalam suatu tindakan dalam mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah pengambilan keputusan dalam melakukan pemeriksaan IVA (Rivai, 2003)(4). IVA salah satu metode deteksi dini terhadap kanker serviks. IVA merupakan pemeriksaan leher rahim (serviks) dengan cara melihat langsung (dengan mata telanjang) leher rahim setelah memulas leher rahim dengan larutan asamasetat 3-5%. IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Aseat) merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. Alat ini begitu sederhana sebab saat pemeriksaan tidak perlu ke laboratorium (Goel et al, 2005). Selain IVA deteksi dini kanker serviks perempuan dapat melakukan pemeriksaan pap smear.

Pengambilan keputusan (decision) WUS (Wanita Usia Subur) untuk ikut serta dalam kunjungan deteksi dini kanker serviks yang dapat mencegah atau meminimalisir meningkatnya kejadian kanker serviks dan komplikasi yang menyertainya. Niat (intention) untuk melakukan deteksi dini kanker serviks di

dukung oleh adanya self efficacy, hambatan yang dirasakan dan benefits(manfaat) deteksi dini kanker serviks tersebut (Wei-Chen Tung,dkk, 2015)

Hasil penelitian didapatkan 60,9% wanita usia subur belum pernah melakukan pemeriksaan dini kanker serviks dengan metode IVA, 45,6% pengetahuan rendah, 50% sikap negatif, 77,9% tidak mendapat dukungan suami, 38,8% tidak mendapat promosi kesehatan. Masih banyaknya WUS yang memiliki sikap negatif terhadap pemeriksaan dini kanker serviks disebabkan karena anggapan bahwa apabila dirinya sehat saja sehingga selama belum ada keluhan tidak akan memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. (Rikandi M. dan Rita N, 2018). Keputusan menurut Hasan (2004) adalah ketegasan terhadap solusi dan keputusan akan jawaban pertanyaan dari masalah yang dihadapinya atau pilihan pada suatu alternatif sebagai suatu pengakhiran yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dan merupakan proses jawaban pertanyaan terhadap masalah yang dihadapi.

Ada beberapa faktor yang mendukung WUS (Wanita Usia Subur) melakukan pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan pulasan Asam asetat) yaitu: faktor pendidikan, faktor pengetahuan, dan dukungan keluarga. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi sikap, namun salah satu faktor yang paling besar adalah pengetahuan. Pengetahuan dan sikap WUS tentang kanker serviks dan pemeriksaan IVA sangat erat kaitannya untuk merubah perilaku dalam keikutsertaan WUS dalam pemeriksaan dini kanker serviks.

Perilaku tidak sehat perlu mendapatkan perhatian yang tinggi karena mempengaruhi kecenderungan berkembangnya penyakit kronis dan fatal, seperti hepatitis, kanker, dan AIDS (WHO dalam Sarafino, 2006). Seperti ketakutan melakukan pemeriksaan dini terhadap kanker Serviks pada wanita usia subur akan menyebabkan penemuan kasus kanker serviks seringkali datang ke pelayanan kesehatan sudah pada stadium lanjut. Terdapat masalah lain dalam mengambil keputusan melakukan deteksi dini kanker serviks adalah keengganan wanita diperiksa karena malu. Penyebab lainnya yaitu kerepotan, keraguan akan pentingnya pemeriksaan, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pemeriksaan, takut terhadap kenyataan hasil pemeriksaan yang akan dihadapi, ketakutan merasa sakit pada pemeriksaan.

Dilihat dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa responden belum bersedia melakukan pemeriksaan dini dipengaruhi oleh perasaan takut. Ketakutan responden karena faktor prosedur sebesar 14% dan 86 % takut ketahuan hasilnya yang bisa menyebabkan timbulnya masalah dikemudian hari.

Sikap yang kurang baik seperti tidak ingin melakukan pemeriksaan karena merasa sehat-sehat saja membuat WUS menolak untuk melakukan pemeriksaan. Beberapa WUS yang belum pernah melakukan pemeriksaan IVA mengaku tidak ingin melakukan pemeriksaan karena malu jika harus diperiksa organ intimnya oleh

petugas kesehatan, menurut sebagian hal itu masih dianggap tabu untuk dilakukan. Usaha merubah sikap WUS dari negatif menjadi positif bukanlah hal yang mudah. Perlunya upaya promosi kesehatan terus menerus diberikan untuk meningkatkan pengetahuan WUS tentang kanker serviks, harapan yang ingin dicapai adalah WUS dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk perilaku hidup sehat diantaranya adalah meningkatkan kemauan WUS dalam hal pemeriksaan kesehatan. (Rikandi M. dan Rita N, 2018).

Hasil yang diperoleh dari faktor-faktor psikologis yaitu motivasi WUS karena adanya rasa ketertarikan dan keingintahuan, persepsi WUS dari pemilihan metode pemeriksaan dini kanker serviks dan perolehan informasi yang membuat WUS ingin melakukan atau tidak pemeriksaan dini kanker serviks, proses belajar WUS terhadap kasus yang diamati saat ini, dan WUS dapat menilai perkembangan kasus dimasyarakat, kepercayaan dan sikap mengatakan bahwa WUS akan melakukan pemeriksaan dini kanker serviks. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan WUS malah menjadi takut untuk melakukan pemeriksaan dini kanker serviks.

Kesadaran perempuan Indonesia untuk melakukan deteksi dini kanker serviks secara teratur masih rendah. Faktor takut, malu dan dukungan keluarga yang rendah sebagai penyebabnya. Sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa Dukungan keluarga kurang semakin rendah juga minatnya, jika dukungan keluarga cukup minatnya sedang, dan sebaliknya semakin baik dukungan keluarga seseorang semakin tinggi juga minat melakukan pemeriksaan IVA (Rahmadkk, 2012). Cakupan deteksi dini di Indonesia kurang dari lima persen sehingga banyak kasus kanker serviks ditemukan pada stadium lanjut yang seringkali menyebabkan kematian, sehingga berbagai upaya pemerintah terus dilakukan untuk meningkatkan cakupan deteksi dini terhadap kanker serviks dengan meningkatkan kesadaran diri ibu untuk dapat mengambil keputusan yang positif.

I. Kesimpulan

Pencegahan kanker serviks dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan serviks secara dini (skrining) karena gejala kanker serviks tidak terlihat sampai stadium yang lebih parah. Pemeriksaan dengan menggunakan metode IVA merupakan pemeriksaan untuk mencegah kanker serviks yang cukup efisien dan efektif karena dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti perawat, bidan dan dokter umum serta biaya lebih murah.

Berdasarkan hasil kegiatan yang sudah dilakukan Tingkat kesadaran WUS dengan kategori kesadaran rendah sebanyak 29,3 %, kategori kesadaran sedang 63,4%, dan kategori kesadaran tinggi 7,3 %. Pengambilan keputusan responden positif sebanyak 68,3 %, sedangkan WUS yang mempunyai keputusan negatif sebanyak 31,7%. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan $r: 0,293$ $p=0,063$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat kesadaran

dengan pengambilan keputusan WUS melakukan pemeriksaan dini kanker serviks. Perlunya penelitian lebih lanjut terkait keputusan wanita usia subur dalam melakukan pemeriksaan dini kanker serviks

DAFTAR PUSTAKA

- Chrystianty, N., Tri, M. P., Keperawatan, I., & DIII Keperawatan, P. (n.d.). Hubungan persepsi wanita pasangan usia subur tentang inspeksi visual asam asetat dengan motivasi pemeriksaan IVA. *Jurnal Keperawatan*, 18(1).
- Fauza, M., & Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, F. (2019). Faktor yang Berhubungan dengan Deteksi Dini Kanker Serviks Metode IVA di Puskesmas Kota Padang. In *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia* (Vol. 14, Issue 1).
- Febriyanti Marantika, O., Daiyah, I., Rizani, A., Program, M., Terapan, S., Poltekkes, K., Banjarmasin, K., & Jurusan, D. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEIKUTSERTAAN WUS (WANITA USIA SUBUR) DALAM PEMERIKSAAN IVA (INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT) TAHUN 2021* (Vol. 3, Issue 1).
- Julika Putri, V., Utami, S., Lestari, W., Fakultas Keperawatan Universitas Riau, M., & Fakultas Keperawatan Universitas Riau, D. (2022). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU IBU MELAKUKAN DETEKSI DINI KANKER SERVIKS DENGAN METODE IVA DI PUSKESMAS GARUDA PEKANBARU. In *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia Indonesian scientific health journal* (Vol. 74, Issue 1).
- Kebidanan, J., & Bengkulu, U. (2022). INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA) PADA WANITA USIA SUBUR (WUS) DI PUSKESMAS KEMUMU TAHUN 2022 FACTORS ASSOCIATED WITH ACETIC ACID VISUAL INSPECTION BEHAVIOR IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE AT THE KEMUMU HEALTH CENTER IN 2022 SRI NENGSI DESTRIANI, DENI MARYANI, DARA HIMALAYA. In *JM* (Vol. 10, Issue 2).
- Kedokteran, J., & Kesehatan, D. (2015). *Pemeriksaan Metode IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) untuk Pencegahan Kanker Serviks* (Vol. 2, Issue 2).
- Longulo, O. J., Pont, A. V., Mangun, M., & Batmomolin, A. (2022). Early Detection of Cervical Cancer by Visual Inspection with Acetic Acid (VIA). *Napande: Jurnal Bidan*, 1(1), 58–64. <https://doi.org/10.33860/njb.v1i1.1044>
- Mamuroh, L., & Nurhakim Fakultas Keperawatan, F. (n.d.). *Pendidikan Kesehatan dan Pelaksanaan Iva Test pada Wanita Usia Subur*.
- Purnamawati, D., Hasanah, T., & Handari, S. R. T. (2020). Determinan Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Metode Inspeksi Visual Asetat di Kota Sukabumi. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1(1).
- Qonita, Nadya Rahmah (2019). *ASUHAN KEBIDANAN IBU BERSALIN DENGAN ATONIA UTERI PADA NY. "H" DI BPM BD*.
- Susilawati, U., Andayani, A., & Sundari, S. (2022). Pengetahuan tentang deteksi dini kanker serviks metode IVA test berhubungan dengan motivasi wanita usia subur

melakukan pemeriksaan IVA test. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 6(1), 24–30.
<https://doi.org/10.32536/jrki.v6i1.214>

Umar, N. (n.d.). *Faktor Resiko IPA*.

Wantini, N. A., & Indrayani, N. (2019). Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA). *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 6(1), 027–034. <https://doi.org/10.26699/jnk.v6i1.art.p027-0346910-18928-1-SM>. (n.d.).

Wathan, F. M., Aisyah, S., & Januar, R. (. (2022). Analisis Determinan Keikutsertaan WUS Dalam Pemeriksaan IVA Untuk Deteksi Dini Kanker Serviks Dengan HBM Care. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 10(2), 315.

Yuliani, I., Lusya, B. A., & Widiati, E. N. (2020). Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (Kanker Serviks) Dengan Metode IVA. *Dharma Bakti*, 3(2).

GLOSARIUM

CO ₂	: Karbon Dioksida
DNA	: Deoxyribosenucleic Acid
HPV	: Human Papilloma Virus
IVA Test	:Inspeksi Visual Asam Asetat
N ₂ O	: Dinitrogen Oksida
NIS	: Neoplasia Intraepitel Serviks
OUI	: Ostium Uteri Internum
OUE	: Nostium Uteri Eksterinum
WUS	: Wanita Usia Subur
WHO	: World Health Organization

INDEKS

A

Abnormal 6

Aceto White Epthelium 6

B

Biopsy 4

H

HPV 4, 9

I

Iva test 10, 11, 12

K

Kanker 3

Kanker leher Rahim 3, 4

Koposkopi 4, 10

L

Leher Rahim 3

N

Nis 10

O

OUI 3

OUE 3

P

Pap smear 4

Paritas 3

S

Skrinning 4, 10

Servikografi 10

W

Wus 18, 19

BAB 4

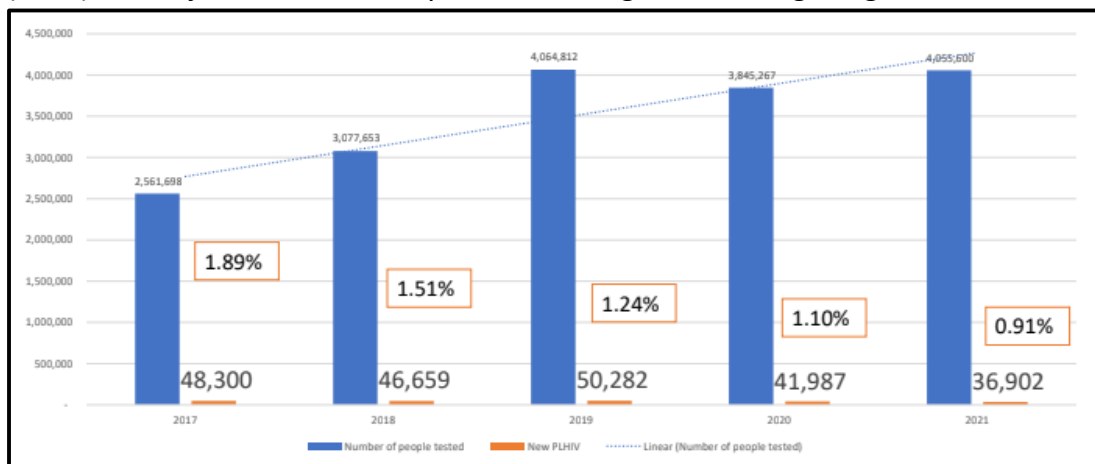
INOVASI PENANGGULANGAN HIV AIDS

Rizka Ayu Setyani, SST, MPH

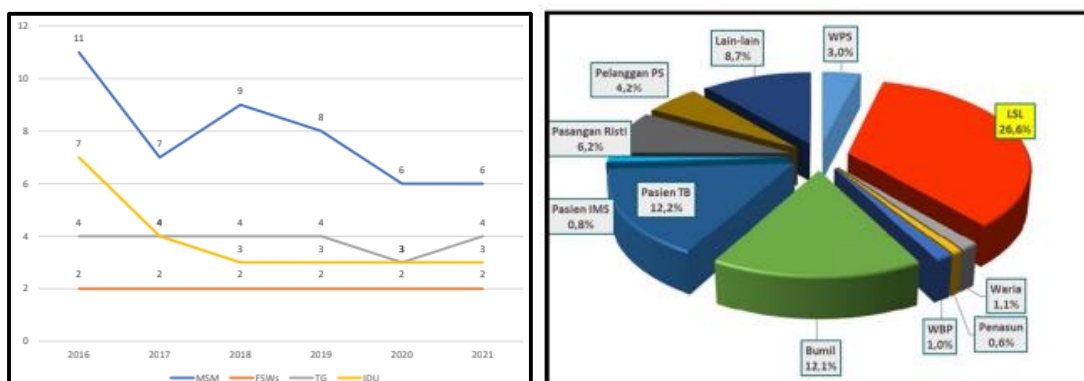


A. Pendahuluan

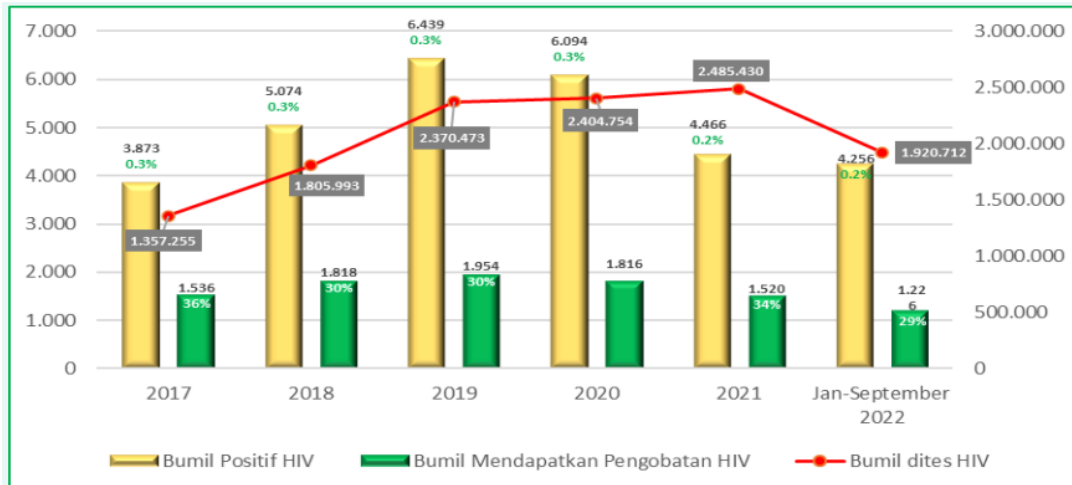
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan epidemi HIV tercepat di dunia. Walaupun secara umum proporsi peningkatan kasus baru HIV menurun, namun tingkat infeksi HIV masih tinggi terutama pada populasi kunci (Januraga *et al.*, 2018). Infeksi baru HIV pada umur 15-24 tahun sebesar 51% dari estimasi infeksi HIV baru, dan hanya 14,5% remaja perempuan (15-24 tahun) yang memiliki pengetahuan benar tentang pencegahan HIV (Kemenkes, 2021). Hal ini berpengaruh ke masa kehamilan. Ibu hamil menjadi kelompok dengan proporsi kasus baru HIV tertinggi kedua setelah kelompok laki-laki suka laki-laki (LSL). Meskipun demikian, kasus infeksi baru HIV pada ibu hamil mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021, dengan peningkatan cakupan tes HIV pada ibu hamil. Selain itu, kematian karena AIDS di Indonesia juga masih meningkat sejak 2010. Data Kemenkes (2021) menunjukkan bahwa hanya 41% dari target 95% orang dengan HIV on ART.



Gambar 4.1. Perkembangan Kasus Baru HIV 2017 – 2021 (SIHA, 2021)



Gambar 4.2. Test Positivity Rate dan Proporsi Kasus Baru HIV Populasi Kunci (SIHA, 2021)



Gambar 4.3. Perkembangan Kasus HIV Ibu Hamil 2017 – September 2022 (SIHA, 2021)

Chapter ini memberikan perspektif berbasis bukti tentang tantangan yang dihadapi Indonesia, serta membahas apa yang diperlukan untuk mengadopsi pendekatan kesehatan masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual. Hal ini untuk mengatasi tantangan spesifik konteks, menghadapi hambatan struktural dan heterogenitas epidemi HIV yang berkembang saat ini.

B. Tantangan Utama Penanggulangan HIV AIDS di Indonesia

Menurut Gedela *et al.*, (2020), ada isu struktural yang membuat pencapaian target kaskade pengobatan HIV menjadi tantangan di Indonesia, antara lain:

1. Kepemimpinan politik dan investasi domestik yang tidak konsisten dan beragam di tingkat lokal, selain birokrasi yang rumit. Meskipun terdapat peningkatan yang signifikan dan investasi politik di tingkat provinsi, namun masih terdapat keterbatasan pengetahuan, infrastruktur, tata kelola dan keterlibatan masyarakat serta tingginya stigma terkait layanan kesehatan khususnya akses pada tes dan pengobatan serta strategi pencegahan HIV.
2. Keanekaragaman geografis dengan tingkat migrasi internal yang tinggi di antara populasi kunci khususnya setelah diagnosis HIV.
3. Hukum dan peraturan yang melarang, mengkambinghitamkan dan meningkatkan stigma institusional terhadap populasi kunci.
4. Upaya untuk menjembatani risiko penularan HIV dari populasi kunci ke populasi risiko rendah; serta kurangnya strategi untuk memitigasi hal ini.
5. Heterogenitas dalam populasi kunci dan rendahnya tingkat literasi HIV dan kesehatan seksual.
6. Kurangnya dukungan kesehatan mental dan perawatan holistik untuk menangani konsekuensi dari infeksi HIV.

C. Pendekatan dalam Pencegahan HIV

Dalam upaya penanggulangan HIV AIDS, tidak ada pendekatan tunggal yang dapat mengendalikan epidemi HIV secara efektif. Sehingga diperlukan pendekatan dalam pencegahan HIV yang bertujuan untuk mengurangi risiko transmisi, mengurangi risiko terinfeksi, serta merubah perilaku dengan strategi kombinasi terintegrasi. Upaya mengurangi risiko transmisi, yaitu menggunakan kondom dan pelumas, skrining darah dan produk darah, *harm reduction* (OST dan NEP), ART pada PMTCT dan TasP, serta pengobatan IMS. Upaya mengurangi risiko terinfeksi yaitu menggunakan kondom dan pelumas, sirkumsisi medis sukarela (VMMC), pengobatan IMS, *Pre Exposure Prophylaxis* (PrEP), *Post Exposure Prophylaxis*, serta vaksin. Upaya merubah perilaku yaitu meningkatkan pengetahuan dan merubah sikap (pendekatan individu, komunitas, struktural), mempromosikan kondom, serta mendorong tes HIV (Setyani, 2020).

D. Inovasi Biomedis dalam Pencegahan HIV

1. Sirkumsisi biomedis adalah tindakan operasi medis untuk menghilangkan kulit kepala penis (foreskin) dengan tujuan menurunkan risiko terinfeksi HIV pada lelaki dalam hubungan heteroseksual sampai 60%. Tindakan ini terutama dilakukan pada negara dengan *generalized epidemic*, yang mulai dikampanyekan di Tanah Papua melalui *pilot study* di empat kabupaten/kota. Namun, studi belum mampu menunjukkan dampak yang bermakna pada pengendalian epidemi HIV di Tanah Papua karena cakupan yang tidak meluas Sirkumsisi biomedis memiliki potensi dalam pencegahan HIV, meskipun isu yang berkaitan keamanan, budaya dan kepercayaan masih menjadi hambatan penting. Akibatnya kebutuhan terhadap teknologi ini pasca program masih rendah (Mitchell *et al.*, 2019).
2. *PrEP oral (tenofovir DF dan emtricitabine)* efektifitasnya sangat bergantung pada kepatuhan. Adanya kepatuhan yang tinggi, PrEP oral dapat menurunkan risiko terinfeksi HIV lewat hubungan seks sampai 99%. Di Indonesia, inisiasi PrEP oral sudah dilakukan di 21 Kabupaten/Kota. Hasilnya, cakupan masih lebih rendah dari yang ditargetkan, dikarenakan terdapat kesan bahwa komunitas kurang tertarik. Jika dibandingkan dengan penggunaan PrEP di negara lain, membutuhkan 1-2 tahun untuk membangun kebutuhan setelah produk tersedia. Selain itu, masih ada keraguan layanan dan tenaga kesehatan profesional, serta persepsi penggunaan ARV sebagai terapi bukan pencegahan. Oleh sebab itu, perlu pengembangan sistem dukungan untuk mengatasi masalah di lapangan dan peningkatan kapasitas komunikasi yang tepat dalam menyampaikan manfaat dan risiko PrEP dengan tepat dan sesuai nilai/norma setempat.
3. *Dapivirine vaginal ring (DVR)* adalah *long-acting slow releases* ARV berbentuk cincin yang dipasang di dalam vagina. Hal ini memberi kontrol lebih besar pada perempuan untuk mencegah HIV. Ring Study (IPM-027) dan ASPIRE (MTN-020)

menunjukkan penurunan risiko infeksi HIV pada perempuan sebesar 30%, sementara studi DREAM dan HOPE menghasilkan penurunan risiko yang lebih besar yaitu 50%. WHO sudah merekomendasikan DVR sebagai metode pencegahan tambahan (kombinasi dengan metode pencegahan lainnya) pada perempuan dengan risiko substantial (misalnya pekerja seks) terinfeksi HIV. Afrika Selatan adalah salah satu negara yang sudah meregistrasi penggunaan DVR. UNAIDS berencana melakukan studi acceptability DVR pada pekerja seks perempuan di negara Asia dan Pasifik termasuk Indonesia.

4. *Long-acting injectable* PrEP dimulai tahun 2015. Beberapa studi melaporkan potensi injeksi cabotegravir, antara lain: Studi pada MSM dan TG (4600 orang) terbesar HPTN 083 yang dilaporkan tahun 2020 menunjukkan potensi *injectable* PrEP mencegah infeksi HIV yang lebih baik dibandingkan oral PrEP. Satu-satunya regulator yang sudah menyetujui *injectable* PrEP adalah FDA dengan nama dagang Apretude. Masalah dengan *injectable* PrEP adalah ketika berhenti, kadar obat dalam darah bisa bertahan cukup lama yang menimbulkan resistensi sehingga membutuhkan waktu 2-4 tahun ke depan untuk membuat Indonesia mengimplementasikan opsi ini.
5. DoxyPEP yaitu pemberian *antibiotic doxycycline* setelah hubungan seksual tanpa kondom untuk mencegah IMS. Laporan dari IAS 2022 menunjukkan studi ini dihentikan lebih cepat karena efikasi yang tinggi. Doxycycline terbukti dapat mengurangi risiko STI sampai 66% (efikasi tertinggi dilaporkan untuk Klamidia, kemudian Gonore dan Sifilis). Hanya saja studi melaporkan potensi resistensi terutama pada Gonore sehingga masih butuh studi yang lebih besar untuk menilai resistensi. Beberapa studi terkait yang sedang dilaksanakan adalah DoxyPrEP di Australia, Kanada dan Prancis.
6. Pengembangan vaksin HIV tidak semudah vaksin COVID-19. Hal ini dikarenakan pengembangan teknologi mRNA untuk vaksin HIV masih pada tahap awal. Pengembangan vaksin dalam kerangka *iterative trial design* termasuk *experimental medicine vaccine trials* perlu mendapat prioritas karena mempercepat proses pembuktian efikasi. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi yang sistematis dan strategis, mengidentifikasi kemajuan dan hambatan serta mengembangkan solusi bersama. Vaksin yang baik harus menunjukkan efikasi yang baik, dirancang untuk dapat didistribusikan dengan baik ke seluruh dunia, pada berbagai kondisi, terutama di daerah dengan teknologi kesehatan yang masih belum memadai, serta terjangkau dari aspek pembiayaan.
7. *Antibody-Mediated Prevention* (AMP) meliputi broadly neutralizing antibody (bNAb) dikenal sebagai VRC01. Jejaring penelitian terkait AMP ada dalam lingkup studi HIV Prevention Trials Network (HPTN) dan HIV Vaccine Trials Network (HVTN). Tujuan penelitian untuk mengevaluasi kemampuan bNAb melindungi infeksi HIV. Secara keseluruhan, VRC01 tidak mengurangi risiko untuk terinfeksi

HIV secara bermakna tetapi studi menunjukkan VRC01 mampu melindungi beberapa individu dari infeksi HIV yang sensitif atau rentan terhadap antibodi ini. Kemungkinan terdapat potensi kombinasi bNAb untuk perlindungan yang lebih menyeluruh.

8. Implant PrEP berupa islatravir mempunyai potensi untuk menurunkan kadar CD4 dalam darah. Terobosan baru yaitu capsid inhibitor (lenacapavir) diperkenalkan sebagai injeksi di bawah kulit setiap 6 bulan sekali. Inovasi ini dirancang juga untuk PrEP dan sedang dalam studi investigasi.

E. Inovasi dalam Intervensi Perubahan Perilaku

Tujuan inovasi ini untuk menurunkan perilaku berisiko, meningkatkan perilaku perlindungan, terhadap risiko, meningkatkan penerimaan dan kepatuhan terhadap produk biomedis, serta menciptakan lingkungan yang mendukung. Inovasinya antara lain: Program distribusi kondom, *community based screening* dan *self screening*, *medically assisted therapy (MAT) with comprehensive service*, *motivational interviewing* untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan terhadap pengobatan, *Simplified ART initiation (SAI)*, serta *website/app campaign* (Setyani, 2020).

Distribusi kondom adalah pencegahan HIV yang *cost-effective*, yaitu memastikan kondom tersedia bagi yang membutuhkan. Hal ini merupakan bagian integral dari upaya pencegahan HIV yang berhasil. Upaya intervensi perubahan perilaku untuk memastikan ketersediaan dan pemanfaatan kondom. Intervensi ini dianggap berhasil apabila kondom tersedia ketika dibutuhkan. Studi IBBS 2018-2019 melaporkan 24% shelter tidak memiliki kondom dan hanya 28% yang mengaku mendapatkan kondom gratis. Pemberdayaan serta dukungan institusional dan struktural yang adekuat diperlukan untuk memastikan dan mendorong kepercayaan masyarakat bahwa kondom sebagai alat perlindungan diri dalam pencegahan HIV.

Penerimaan *self screening* masih rendah karena teknologi baru. Harapannya, dengan berjalannya waktu maka adopsi untuk melakukan tes secara mandiri kapanpun dimanapun dengan kontrol individu akan meningkat asalkan produknya tersedia. Hambatan implementasi program ini yaitu sistem informasi untuk merangkum skrining mandiri masih pada tahap awal padahal ada beberapa metode yang digunakan dengan sistem rujukan yang bervariasi. Hal ini menimbulkan potensi kehilangan data capaian tes dan *follow up* klien, serta masalah dalam registrasi kit.

Model *Medically assisted therapy (MAT)* dengan layanan komprehensif meliputi : Tes dan pengobatan HIV, tes dan pengobatan TB, tes hepatitis dan penanganan terkait, kesehatan seksual dan reproduksi termasuk IMS, penilaian kesehatan mental dan penanganan yang sesuai, pengobatan umum, serta intervensi psikososial termasuk konseling keluarga.

SAI (*Simplified ART Initiation*) merupakan bagian dari studi HATI (HIV awal (early) treatment Indonesia). Studi ini menyederhanakan prosedur memulai ART

dengan melewati beberapa pemeriksaan laboratorium yang sering dilakukan klinik sebelum memulai ART. SAI memungkinkan fasilitas layanan primer melakukan skrining risiko dengan instrumen sederhana untuk memisahkan mereka yang tidak eligible untuk memulai ART segera. SAI telah diadopsi dalam bentuk kebijakan *test and treatment* di Indonesia. Beberapa isu dari hasil studi ini yaitu kemandirian layanan dalam menegakkan diagnosis, serta belum semua layanan tes mampu memulai pengobatan (Lazuardi *et al.*, 2020).

Motivational Interviewing (MI) menggunakan pendekatan inovatif untuk menilai tingkat kesiapan sosial-psikologis pasien dalam menerima kondisi dan juga upaya perbaikan kondisi-nya untuk kemudian bisa diberikan intervensi konseling yang sesuai. MI di Indonesia pernah digunakan dalam studi HATI untuk meningkatkan serapan pengobatan HIV dan kaskade pengobatannya. Isu dan hambatan dalam pelaksanaan implementasi studi MI yaitu beban kerja petugas layanan yang tinggi sementara MI membutuhkan dedikasi waktu yang lebih banyak, serta alur pelayanan yang sering kurang mendukung model konseling individu MI (Lazuardi *et al.*, 2019).

Program GEBRAK (Gerakan Bersama Kader) terbukti efektif untuk meningkatkan partisipasi VCT pada remaja (Setyani *et al.*, 2019). GEBRAK merupakan program pemberdayaan masyarakat bersama kader peduli HIV dan AIDS yang bertujuan sebagai upaya promosi kesehatan dalam pengurangan stigma terhadap HIV dan AIDS. Program ini adalah inovasi pengembangan dari *peer educator* yang diimplementasikan melalui karang taruna.

Perkembangan penggunaan media promosi kesehatan dari konvensional (berbasis *paper*) kearah digital (berbasis *mobile*) terjadi pada upaya pencegahan HIV dan AIDS pada generasi muda. Remaja umumnya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang teknologi informasi termasuk teknologi digital. Pemahaman ini merupakan peluang untuk memanfaatkan teknologi informasi dan teknologi digital dalam menjangkau remaja untuk menyampaikan berbagai literasi kesehatan tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS (Govender *et al.*, 2019). Pemanfaatan teknologi digital berbasis komunitas terbukti meningkatkan upaya penanggulangan HIV, misalnya penggunaan kondom dan tes HIV pada kelompok populasi kunci yang mengalami stigma (Abubakari *et al.*, 2021).

Intervensi media digital melalui *Storytelling 4 Empowerment* (S4E) telah dilakukan pada penelitian Cordova *et al.* (2020). Hasilnya, S4E dapat mengurangi penggunaan narkoba, perilaku seksual berisiko, dan meningkatkan partisipasi tes IMS/HIV di kalangan 50 remaja umur 13-21 tahun. Hasil yang serupa juga terjadi pada studi Ofoegbu *et al.* (2019), bahwa *educational digital storytelling intervention* (EDSI) dapat meningkatkan pengetahuan dan persepsi risiko HIV pada 98 remaja. Penelitian Richardson *et al.* (2019) dan Nielsen *et al.* (2021) menyebutkan bahwa pemanfaatan media digital dapat meningkatkan penggunaan kondom, partisipasi tes IMS, dan pemeriksaan kesehatan dengan umpan balik terintegrasi dalam penyampaian

konseling dokter, walaupun hasilnya tidak signifikan. Sehingga, diperlukan media digital yang interaktif seperti games, khususnya bagi remaja agar lebih tertarik dalam mengakses (Sabben *et al.*, 2019).

Penelitian sebelumnya tentang uji coba sistem berbasis *website* untuk skrining kelayakan dan pengumpulan data hasil tes HIV, sebagai dasar rekomendasi tes HIV di layanan kesehatan dan secara mandiri. Hasilnya, penambahan layanan tes HIV mandiri yang didukung oleh sistem pengumpulan data berbasis web mampu meningkatkan identifikasi kasus HIV pada kelompok pekerja seks (Yunus *et al.*, 2021). Beberapa isu terkait *website/app campaign* antara lain adanya sensor, jangkauan kampanye yang meskipun memiliki potensi tidak terbatas tetapi justru faktanya menjangkau secara terbatas karena jalur pencarian informasi dari komunitas yang berbeda beda, mengemas pesan yang sesuai pada kondisi perbedaan konteks sosial, nilai, norma, budaya yang dihadapi komunitas, serta menghubungkan dengan sistem layanan yang tersedia di Indonesia yang demikian luas dan bervariasi.

F. Simpulan dan Rekomendasi

Stigma dapat menghambat implementasi inovasi penanggulangan HIV AIDS di Indonesia. Pada level struktural dan institusional, stigma pada kelompok minoritas dan berisiko dapat mempengaruhi perluasan inovasi pencegahan HIV terutama biomedik dan secara negatif mempengaruhi akses. Pada level personal, stigma dapat mempengaruhi tata nilai dan kepercayaan diri dari komunitas terdampak dalam menegosiasikan upaya perlindungan risiko dan akses ke pelayanan kesehatan.

Oleh sebab itu, perlunya penelitian, kebijakan, dan program yang merespon stigma di level struktural dan institutional; promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang merekognisi dampak stigma pada upaya mengadopsi inovasi pencegahan untuk komunitas terdampak; meningkatkan mobilisasi dan partisipasi komunitas dalam berbagai strategi dan pendekatan pencegahan HIV; serta memperluas pendekatan penelitian dan evaluasi dalam upaya pengurangan stigma dan hubungannya dengan pencegahan HIV. Inovasi berbasis pemberdayaan kelompok usia muda juga perlu dilakukan dikarenakan otonomi klien di bawah 18 tahun dalam pengambilan keputusan dapat melalui wali/pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakari, G. M., Turner, D., Ni, Z., Conserve, D. F., Dada, D., Otchere, A., Amanfoh, Y., Boakye, F., Torpey, K., & Nelson, L. E. (2021). Community-Based Interventions as Opportunities to Increase HIV Self-Testing and Linkage to Care Among Men Who Have Sex With Men - Lessons From Ghana, West Africa. *Frontiers in public health*, 9, 660256.
- Cordova, D., Munoz-Velazquez, J., Mendoza Lua, F., Fessler, K., Warner, S., Delva, J., Adelman, N., Youth Leadership Council, Fernandez, A., & Bauermeister, J. (2020). Pilot Study of a Multilevel Mobile Health App for Substance Use, Sexual Risk Behaviors, and Testing for Sexually Transmitted Infections and HIV Among Youth: Randomized Controlled Trial. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(3), e16251.
- Gedela, K., Wirawan, D. N., Wignall, F. S., Luis, H., Merati, T. P., Sukmaningrum, E., & Irwanto, I. (2021). Getting Indonesia's HIV epidemic to zero? One size does not fit all. *International journal of STD & AIDS*, 32(3), 290–299.
- Govender, D., Naidoo, S., & Taylor, M. (2019). Knowledge, attitudes and peer influences related to pregnancy, sexual and reproductive health among adolescents using maternal health services in Ugu, KwaZulu-Natal, South Africa. *BMC public health*, 19(1), 928.
- Januraga, P., Reekie, J., Mulyani, T., Lestari, B., Iskandar, S., Wisaksana, R., Kusmayanti, N., Subronto, Y., Widyanthini, D., Wirawan, D., Wongso, L., Sudewo, A., Sukmaningrum, E., Nisa, T., Prabowo, B., Law, M., Cooper, D. and Kaldor, J. (2018). The cascade of HIV care among key populations in Indonesia: a prospective cohort study. *The Lancet HIV*, 5(10), e560-e568.
- Lazuardi, E., Newman, C. E., Anintya, I., Rowe, E., Wirawan, D. N., Wisaksana, R., Subronto, Y. W., Kusmayanti, N. A., Iskandar, S., Kaldor, J., & Bell, S. (2020). Increasing HIV treatment access, uptake and use among men who have sex with men in urban Indonesia: evidence from a qualitative study in three cities. *Health policy and planning*, 35(1), 16–25.
- Lazuardi, E., Newman, C., Tasya, I., Rowe, E., Wirawan, D., Wisaksana, R., Subronto, Y., Kaldor, J., Kusmayanti, N., Iskandar, S. and Bell, S. (2019). Understanding the Social Influences on Engaging Key Populations With HIV Prevention: A Qualitative Study With Men Who Have Sex With Men in Three Indonesian Cities. *AIDS Education and Prevention*, 31(3), 206-223.
- Mitchell, E., Lazuardi, E., Rowe, E., Anintya, I., Wirawan, D., Wisaksana, R., Subronto, Y., Prameswari, H., Kaldor, J. and Bell, S. (2019). Barriers and Enablers to HIV Care Among Waria (Transgender Women) in Indonesia: A Qualitative Study. *AIDS Education and Prevention*, 31(6), 538-552.
- Nielsen, A. M., De Costa, A., Gemzell-Danielsson, K., Marrone, G., Boman, J., Salazar, M., & Diwan, V. (2021). The MOSEXY trial: mobile phone intervention for sexual health

in youth-a pragmatic randomised controlled trial to evaluate the effect of a smartphone application on sexual health in youth in Stockholm, Sweden. *Sexually transmitted infections*, 97(2), 141–146.

Ofoegbu, T. O., Otu, M. S., Christopher, I., Uche, A., Nwabuko, L. O., Ebere, I., Dike, I. C., Ngozi, O., Chinedozie, U., & Muhammed, A. (2020). Impact of an educational digital storytelling intervention on HIV risk perception among Nigerian adolescents. *The Journal of international medical research*, 48(1), 300060519854635.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual.

Richardson, L., Parker, E. O., Zhou, C., Kientz, J., Ozer, E., & McCarty, C. (2021). Electronic Health Risk Behavior Screening With Integrated Feedback Among Adolescents in Primary Care: Randomized Controlled Trial. *Journal of medical Internet research*, 23(3), e24135.

Sabben, G., Mudhune, V., Ondeng'e, K., Odero, I., Ndivo, R., Akelo, V., & Winskell, K. (2019). A Smartphone Game to Prevent HIV Among Young Africans (Tumaini): Assessing Intervention and Study Acceptability Among Adolescents and Their Parents in a Randomized Controlled Trial. *JMIR mHealth and uHealth*, 7(5), e13049.

Setyani, R.A. (2020). *Evidence Based Pengelolaan HIV dalam Kebidanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Setyani, R.A., Indrawati, F.L., Prabasari, D. (2019). Model Pemberdayaan Masyarakat “GEBRAK” dalam Optimalisasi Partisipasi Remaja pada Voluntary Counseling and Test di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 4(3), 30-38.

SIHA (2021). *Laporan Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Widyanthini, D., Januraga, P., Wisaksana, R., Subronto, Y., Sukmaningrum, E., Kusmayanti, N., Dewi, H., Law, M., Kaldor, J. and Wirawan, D. (2021). HIV self-testing for men who have sex with men: an implementation trial in Indonesia. *AIDS Care*, 1-8.

Yunus, J. O., Sawitri, A. A. S., Wirawan, D. N., Mahendra, I. G. A. A., Susanti, D., Utami Ds, N. K. A. D., Asanab, D., Narayani, I. A., Mukuan, O. S., Widiastuti, A., Magnani, R., & Januraga, P. P. (2021). Web-Based Multifaceted Approach for Community-Based HIV Self-Testing Among Female Sex Workers in Indonesia: Protocol for a Randomized Community Trial. *JMIR research protocols*, 10(7), e27168.

BAB 5

KESEHATAN REPRODUKSI

PADA INDIVIDU DISABILITAS

Nina Hidayatunnikmah, S.Keb.,BD.MKes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Pendahuluan

Diperkirakan sebanyak 10% populasi di dunia yaitu 650 juta orang hidup dengan kondisi disabilitas. Seorang individu disabilitas memiliki hak sama atas kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi seperti individu yang lainnya. Hambatan terbesar yang sering di dapatkan oleh individu dengan disabilitas adalah informasi dan layanan terkait kesehatan reproduksi. Penolakan dan sikap masyarakat, individual seseorang, dan penyedia layanan kesehatan meningkatkan sebagian besar hambatan tersebut bukan inidividu disabilitas itu sendiri. Pada faktanya seharusnya layanan yang ada bisa di adaptasi dengan mudah untuk mengakomodir individu dengan disabilitas. Meningkatkan kesedaran pemerintah, masyarakat, individu diasbilitas, dan penyedia layanan kesehatan merupakan langkah utama dan penting. Pembuatan suatu program yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi untuk individu disabilitas dapat dicapai secara maksimal ketika melibatkan individu disabilitas dalam pembentukan program tersebut (Organization 2009).

Disabilitas secara eksplisit telah disebutkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai sebuah alasan untuk mengambil pendekatan berbasis hak individu dalam menyediakan informasi dan layanan kontrasepsi (OMS 2014), dalam beberapa tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yaitu tujuan 3.7 yang menyebutkan tentang akses universal pada layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan tujuan 10.2 tentang inklusi semua individu tanpa memandang disabilitas seseorang, dan sebuah hak ekuitas dan nondiskriminasi (Nations 2016).

Kebutuhan kesehatan seksual dan reproduksi individu dengan disabilitas merupakan suatu bidang yang sangat terabaikan baik dalam penelitian dan pelayanan (Carew et al. 2017). Terdapat sebuah tinjaun dari bukti sosial dan emprise pada individu dengan kondisi disabilitas yang dilakukan pada tahun 2001, menemukan bahwa penyandang disabilitas cenderung menghadapi tingkat kesulitan yang tidak proposional dalam memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksinya dibandingkan dengan orang tanpa memiliki disabilitas meskipun setiap individu tersebut memiliki kebutuhan reproduksi yang sama tanpa adanya perbedaan (Milligan and Neufeldt 2001). Individu dengan disabilitas cenderung menghadapi beberapa hambatan Ketika individu tersebut mengungkapkan seksualitas dan mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang terletak pada individunya (seperti bentukan tubuh yang buruk), sosial (sikap negative), dan struktur (lingkungan yang sulit diakses) (Taleporos and McCabe 2002).

Dibutuhkan sebuah literatur yang cukup baik untuk melakukan upaya perbaikan layanan kesehatan reproduksi khususnya untuk individu dengan disabilitas.

B. *Family Planning* Untuk Wanita Dengan Disabilitas

1. Pendahuluan

Setiap individu memiliki hak yang mendasar untuk secara bebas memutuskan segala hal untuk diri sendiri, apakah, kapan, dan berapa banyak anak yang akan dimiliki. Pada tahun 2017, Catalina Devandas merupakan seorang pelapor hak-hak dari penyandang disabilitas yang mendesak komunitas global untuk menghargai kebutuhan perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas untuk diberikan informasi dan memungkinkan untuk membuatnya secara mandiri terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi.

Evidence based yang terkait dengan *family planning* (keluarga berencana) untuk perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas telah berkembang pesat dan telah dinilai memiliki nilai dengan ukuran yang sedang. Sebagian besar evidence based dari negara FP2020 pembuat komitmen yaitu Ethiopia, Ghana, Nepal, Senegal dan Uganda fokus pada tantangan yang dihadapi oleh perempuan dengan gangguan disabilitas. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akses dan penggunaan *family planning* yaitu faktor individual, lingkungan, sikap, dan Lembaga.

Masih terdapat kesenjangan yang cukup besar pada sebuah evidence pada sebuah praktik yang baik dalam meningkatkan sebuah kebebasan yang penuh dalam memilih kontrasepsi dan informasi terkait kontrasepsi untuk perempuan penyandang disabilitas. Meskipun telah banyak sebuah komunitas dan organisasi yang menyoroti dan menangani masalah terkait hak kebebasan dalam *family planning* akan tetapi hal tersebut tidak dievaluasi dan didokumentasikan dengan baik. Para ahli menyoroti hal ini sehingga dibutuhkan pendekatan multi-komponen dengan menggunakan strategi yang sesuai. Terdapat beberapa strategi praktik yang menjanjikan dan paling sering disebutkan pada sebuah literatur yaitu:

1. Mengikut sertakan perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas dalam pengembangan kebijakan dan program keluarga berencana termasuk bermitra secara aktif dengan organisasi layanan disabilitas lokal untuk meningkatkan sebuah aksesibilitas
2. Pendidikan sebaya untuk meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas tentang metode dan layanan keluarga berencana
3. Mengatasi hambatan sikap dengan komunitas dan *caregiver*
4. Menyesuaikan pesan-pesan penting untuk peningkatan kesadaran dan Pendidikan tentang *family planning* dengan kebutuhan para penyandang disabilitas.

5. Mengatasi sikap negatif diantara petugas layanan kesehatan dan memastikan memastikan pilihan kontrasepsi yang terinformasi berdasarkan dengan pelatihan
6. Melibatkan anggota keluarga dalam memberikan intervensi keluarga berencana untuk mendapatkan dukungan *caregiver* dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk meningkatkan akses dan penggunaan keluarga berencana
7. Layanan satelit dan Pendidikan seksualitas bagi penyandang disabilitas
8. Mengumpulkan data untuk merubah kebijakan dan layanan
9. Memastikan layanan keluarga berencana dapat diakses oleh perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aksesibilitas

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akses untuk mendapatkan pelayanan *family planning* untuk wanita dan anak perempuan dengan disabilitas, Adapun faktor tersebut adalah

1. Faktor Individu

Strategi dari program DFID untu pembangunan inklusif disabilitas pada tahun 2018-2023 mengakui bahwa penyandang disabilitas menghadapi berbagai bentuk diskriminasi. Penyandang disabilitas selalu bersinggungan dengan berbagai sumber diskriminasi atau ketidakberuntungan dalam lingkungan sosial lainnya yang mungkin membatasi akses dan pemahaman terkait keluarga berencana seperti usia, jenis kelamin, seksualitas, etnis, jenis gangguan, atau kemiskinan ekonomi (Heera and Maini 2018)(DFID 2018).

Beberapa studi telah mengkonseptualisasikan beberapa faktor yang tumpang tindih dengan cara yang berbeda, seperti pendapat (Ayiga and Kigozi 2016) bahwa faktor faktor tersebut terdiri dari faktor predisposisi (usia, status pernikahan, Pendidikan dll), faktor mungkin (akses ke informasi KB, fasilitas kesehatan, lokasi geografis, kekayaan) dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan akan kontrasepsi (jumlah anak, intensi fertilitas). Sedangkan menurut (Fraser and Corby 2019) mereka menggunakan framework marginalisasi untuk membedakan antara faktor individu yang mempengaruhi akses dan pelayanan family planning yaitu:

a. *Universal Factors*

Aspek pasti dari identitas individu terlepas dari pengaturannya, seperti usia, jenis kelamin, status kesehatan, dan status disabilitas

b. *Contextual Factors*

Faktor yang lebih kompleks dan dapat berubah oleh beberapa pengaturan seperti Bahasa, kasta, status migrasi dan kemiskinan dan status keluarga.

Berdasarkan evidence yang telah didapatkan menunjukan bahwa banyaknya faktor ini berpotongan dan menciptakan gambaran, bergantung pada konteks. Seperti contoh terdapat suatu penelitian menemukan faktor usia, disabilitas, dan jenis kelamin terkait dengan beberapa hambatan aksesibilitas dan penerimaan sehingga dapat menciptakan banyaknya kerentanan diantara orang-orang muda dengan disabilitas.

Hambatan yang didapatkan oleh individu dengan disabilitas tergantung pada tipe dan tingkat keparahan gangguan karena keperluan solusinya akan berbeda dalam mengakses dan menggunakan pelayanan keluarga berencana. Diperlukan sebuah peringatan bahwa individu dengan disabilitas merupakan masalah yang kompleks dan bukanlah kelompok yang bersifat homogen. Maka dari itu, layanan dan informasi perlu disesuaikan, dan tidak ada istilah pendekatan *one-size-fits-all* untuk memastikan layanan keluarga berencana dapat diterima oleh wanita dan anak perempuan dengan disabilitas. Terdapat suatu penilaian yang telah dilakukan di Addis Ababa Ethiopia terkait dengan kebutuhan keluarga berencana pada penyandang disabilitas menemukan sebuah hambatan yang bergantung pada jenis gangguannya dalam melakukan penilaian kebutuhan tersebut, meliputi:

1. Seseorang dengan gangguan pendengaran

Hambatan yang berkaitan dengan Teknik komunikasi, terbatasnya akses layanan informasi terkait keluarga berencana, belum tersedianya ahli bahasa isyarat di fasilitas kesehatan, dan penyebaran informasi berbasis media yang tidak disesuaikan dengan kondisi tuna rungu. Terdapat beberapa individu dengan kelainan tuna rungu yang memiliki sikap negative terhadap *family planning* dan tidak mendukung atas penggunaannya, hal ini disebabkan karena adanya rumor dan miskonsepsi tentang metode KB diantara orang tuna rungu

2. Individu dengan kelaianan melihat dan mendengar

Tidak ada translator pada fasilitas kesehatan sikap yang negative oleh tenaga kesehatan sebagai pemberi layanan

3. Individu dengan kelaian visual

Rendahnya design fasilitas kesehatan serta infrastrukturnya, kondisi jalan yang buruk untuk mencapai pada tempat layanan kesehatan, kurangnya pembinaan pada fasilitas kesehatan, dan pengalaman negative di bidang fasilitas kesehatan

4. Individu dengan disabilitas fisik

Dibutuhkan kesadaran lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain. Hambatan utama yang ditemukan adalah tidak sopan dan perlakuan yang buruk dari tenaga kesehatan serta design fasilitas kesehatan yang tidak dapat diakses oleh individu dengan disabilitas.

5. Individu dengan disabilitas intelektual

Hambatan yang ditemukan adalah mendapatkan perlakuan yang buruk dari beberapa petugas kesehatan dan pegawai lainnya di fasilitas kesehatan.

Pada berbagai konteks, terdapat beberapa bukti yang mengindikasikan bahwa remaja dengan disabilitas secara partikular akan menghadapi tantangan yang serius, seperti halnya kesulitan diskusi *family planning* pada orang tua, edukator, dan konselor. Remaja putri dengan adanya pendaftar. Remaja perempuan penyandang.

2. Faktor Lingkungan

a. Hambatan fisik untuk aksesibilitas

Terdapat sebuah contoh-contoh tidak bisanya aksesibilitas secara fisik pada layanan kesehatan reproduksi yang di telah disebutkan dalam bebrabagai literatur meliputi kurangnya jalur landau, tempat tidur yang dapat disesuaikan, kursi roda, sanitasi yang ramah disabilitas pada klinik *family planning*, fasilitas kesehatan dan rumah sakit (Ahumuza et al. 2014). Terdapat sebuah hasil penelitian yang dilakukan di Nepal pada 293 orang muda yang berusia 15-30 tahun dengan 3 jenis disabilitas (penglihatan, pendengaran, dan fisik) menemukan bahwa hanya 38% anak muda mengatakan bahwa mereka menganggap pusat layanan kesehatan reproduksi terdekat dapat diakses secara fisik oleh penyandang disabilitas dan ramah disabilitas (Services 2020). Terdapat berbagai laporan dari negara ke *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) terkait dengan tantangan aksesibilitas infrastruktur kesehatan, fasilitas, informasi dan layanan untuk penyandang disabilitas

b. Antrian pada Fasilitas Kesehatan

Antrian yang ada di fasilitas kesehatan dapat menambah hambatan fisik dalam mengakses layanan, contohnya terdapat sebuah penelitian yang dilakukan di Uganda menemukan bahwa penyandang disabilitas seringkali harus mengantri panjang Ketika datang ke layanan kesehatan untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi dan *family planning*. Antrian pada layanan kesehatan merupakan kondisi dan situasi normal dan biasaya yang terjadi di pelayanan kesehatan akan tetapi kurangnya pertimbangan untuk aksesibilitas penyandang disabilitas merupakan masalah dalam kemudahan akses layanan kesehatan reproduksi untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status ataupun kondisi dari individu (Ahumuza et al. 2014)

c. Perjalanan yang Panjang dan sulit untuk ke klinik

Terbatasnya layanan kesehatan reproduksi pada penyandang disabilitas, maka pemilihan layanan kesehatan akan memungkinkan untuk mendapatkan layanan yang jauh dari tempat tinggal terutama pada daerah terpencil, menjadikan hambatan yang khusus terhadap aksesibilitas dan penyerapan layanan keluarga berencana (Ahumuza et al. 2014)(Mirza 2015). Terdapat suatu

laporan Negara Malawi kepada CPRD tentang tantangan mobilitas dari berbagai tempat tinggal ke fasilitas kesehatan termasuk dalam fasilitas kesehatan yang jaraknya sangat jauh

d. Aksesibilitas Pesan dan Materi *Family Planning*

Terdapat sebuah bukti yang menyatakan bahwa penyerapan materi terkait perencanaan keluarga tergantung pada aksesibilitas informasi dan Pendidikan kesehatan reproduksi. Berbagai Negara melaporkan serta terdapat hasil penelitian yang dilakukan di Ghana, Kenya, dan Rwanda menyoroti kesenjangan kesadaran antara penyandang disabilitas, misalnya penyandang disabilitas pendengaran mengalami kesulitan dengan pesan radio atau mengikuti lokakarya tanpa juru bahasa isyarat, atau individu dengan penyandang disabilitas visual hambatan adalah tidak disediakan materi braille. Hambatan lainnya adalah pesan televisi yang tidak diberikan judul atau diterjemahkan ke dalam bahasa isyarat (Mprah, 2014; Mesfin Yesgat et al. 2020; Tanabe et al. 2015)

3. Faktor Sikap

a. Persepsi bahwa Penyandang disabilitas dianggap aseksual

Persepsi individu atas penyandang disabilitas adalah aseksual merupakan penyebab pemotongan informasi seksualitas dengan asumsi bahwa anak perempuan dan wanita penyandang disabilitas “Tidak Membutuhkan” layanan informasi terkait seksualitas (Ahumuza et al. 2014). Beberapa penelitian menyoroti asumsi yang salah bahwa penyandang disabilitas bukanlah individu seksual, yang menyebabkan kurangnya Pendidikan kesehatan seksual, hambatan aksesibilitas ke pelayanan kesehatan, penyerapan perencanaan keluarga, pelecehan, eksploitasi seksual, serta faktor resiko HIV dan penyakit menular seksual lainnya (Rohleder 2018).

b. Diskriminasi dari Petugas Kesehatan pada Perempuan dan anak Perempuan Penyandang Disabilitas

Sigma dan sikap negative oleh penyedia dan staf layanan kesehatan adalah salah satu hambatan yang paling sering dikutip dalam beberapa literatur (Devkota, Kett, and Groce 2019). Hambatan ini dapat diperparah bagi penyandang disabilitas yang memiliki identitas terpinggirkan lainnya seperti status pengungsi. Terdapat sebuah studi di Uganda tentang pengungsi penyandang disabilitas mengamati betapa negatif dan tidak sopannya sikap provider puskesmas dan rumah sakit rujukan nasional terhadap penyandang disabilitas. Hal ini merupakan “penghalang yang sangat berpengaruh” yang mana akan menghalangi pengungsi penyandang disabilitas mengakses layanan keluarga berencana (Tanabe et al. 2015). Terdapat sebuah sejarah atau bahkan masih berlangsung pada praktik di berbagai negara tentang sterilisasi paksa terhadap perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas. Hal ini

penting untuk mengatasi sikap negative dan diskriminasi dan memastikan “penuh tanpa paksaan dan informed consent dari individu, baik sendiri atau dengan dukungan”. Beberapa penelitian menyoroti bagaimana anak perempuan dan wanita muda penyandang disabilitas menjadi kekanak-kanakan, tidak berdaya, dan tidak memiliki suara, pilihan dan control untuk membuat keputusan tentang tubuh dan seksualitasnya sendiri (Aguilar and Chief 2017).

c. Sikap *Overprotective* dan Kurangnya Komunikasi Seputar Kesehatan Reproduksi oleh Orang Tua atau Pengasuh

Terdapat sebuah penelitian yang dilakukan multi negara di Etiopia, Uganda, dan Rwanda mengamati hal hal terkait seksualitas anatar orang tua dan anak muda penyandang disabilitas adalah “sangat rendah”, hanya 22% respon yang mendiskusikan seks dan keluarga berencana dengan orang tua atau pengasuhnya (Kassa et al. 2016). Percapakan terkait dengan seksualitas untuk gadis muda dan belum menikah sangat tabu khususnya dalam budaya konservatif. Hasil sebuah penelitian di Yordania dengan orang tua dan penyandang disabilitas remaja usia 12-18 tahun dengan down syndrome menemukan bahwa terdapat hambatan budaya dalam mendiskusikan seksualitas, keluarga berencana dan juga memandangnya hal yang memalukan berdiskusi seksualitas dengan anak (Mostafa Amr1 , Nevin FW Zaki2* et al. 2017).

d. Kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan pasangan intim/ *Intimate Partner Violence* (IPV)

Kekerasan berasal dari sebuah sikap, norma, dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan dapat membatasi akses dan mengadopsi metode perencanaan keluarga. Terdapat sebuah penelitian yang menemukan bahwa perempuan penyandang disabilitas menjadi korban pemerkosaan, pelecehan seksual, dan IPV dengan jumlah terbanyak pelaku umumnya dalah pasangan laki-lakinya(Remme, Michaels-Igbokwe, and Watts 2015). Mitos sekitar aksesualitas dapat berkontribusi pada IPV dan bentuk kekerasan lainnya yang tidak terdeteksi. Penelitian yang dilakukan dalam kemitraan dengan penyandang disabilitas muda menemukan kerentanan tinggi terhadap kekerasan seksual dan karena itu resiko tinggi kehamilan yang tidak diinginkan, terutama dikalangan gadis muda dengan tunarungu. Penelitian juga menunjukkan bahwa perempuan tunagrahita lebih tiinggi risiko, cenderung menerima Pendidikan seksual, sering disosialisakan untik patuh dan lebih bergantung pada orang tua dan pengasuh (Remme, Michaels-Igbokwe, and Watts 2015). Melakukan kekerasan berbasis gender oleh petugas kesehatan dalam posisi kekuasaan dan otoritas, termasuk sterilisasi paksa, juga dapat bertindak sebagai penghalang yang cukup besar

untuk keluarga berencana bagi perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas (Bell et al. 2015)

4. Faktor Institusi

- a. Perlunya kebijakan nasional untuk menangani hak-hak reproduksi perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas: meskipun terdapatnya sebuah kemajuan yang dibuat oleh beberapa LMIC dalam mengaktifkan CRPD, masih banyak negara masih terdapat kekurangan jaminan hukum dan kebijakan nasional untuk penyandang disabilitas untuk memiliki hak yang sama atas kesehatan dan non diskriminasi. Sebagai contoh, tinjauan terhadap tujuh dokumen kebijakan dan praktik utama layanan kesehatan seksual dan reproduksi dari sumber-sumber pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) menyimpulkan bahwa perhatian yang diberikan pada kebutuhan layanan kesehatan seksual dan reproduksi penyandang disabilitas bersifat ‘Singkat’ dengan kebutuhan akan panduan lebih lanjut dan penelitian untuk memastikan disabilitas-pelayanan dan informasi yang lebih bersahabat dengan penyandang disabilitas (Mprah, Anafi, and Sekyere 2014). Terapat 16 laporan negara CRPD mencatat bahwa “ada yang tidak memadai upaya menangani perawatan kesehatan ibu dan hak reproduksi perempuan penyandang disabilitas” serta menyoroti beberapa tantangan termasuk:

- Tidak ada ketentuan dalam konstitusi tentang hak atas kesehatan
- Sikap profesional kesehatan yang tidak profesional terhadap penyandang disabilitas
- Tidak dapat diakses prasarana kesehatan, sarana, informasi, pelayanan dan kampanye kesehatan masyarakat tentang KB

Terdapat sebuah contoh praktik kebijakan yang baik yang dilakukan oleh Kamerun yang mana telah berkomitmen untuk menetapkan suatu garis anggaran untuk mensubsidi keluarga berencana bagi masyarakat pengguna yang paling rentan, termasuk remaja, anak mudan dan orang dewasa dengan disabilitas.

- b. Kurangnya Data Tentang Akses dan Penerapan *Family Planning* untuk Wanita dan Gadis dengan Disabilitas:

Kurangnya data yang terpilah berdasarkan dengan usia, jenis kelamin, dan kecacatan menghalangi pemahaman tentang sejauh mana akses penggunaan keluarga berencana bagi penyandang disabilitas, sehingga membuatnya tidak terlihat jelas. Selain itu terdapat kesenjangan pengetahuan dalam pengalaman okumentasi tentang inklusi disabilitas dalam perencanaan keluarga “kebutuhan, pengalaman, dan pandangan tidak tertangan pada proses evaluasi” (Buchy et al. 2017).

- c. Kurangnya Keahlian Teknis
Kurangnya keahlian teknis terkait dengan program keluarga berencana dari perspektif disabilitas: terdapat berbagai penelitian telah menyoroti kurangnya pengetahuan komprehensif tentang praktik yang tepat untuk family planning untuk wanita dan perempuan dengan disabilitas (Kassa et al. 2016).
- d. Biaya Tinggi pada Penyandang Disabilitas untuk Mengakses Layanan KB
Beberapa studi penelitian telah menemukan sebuah hambatan finansial terhadap suatu layanan keluarga berencana yang dialami oleh penyandang disabilitas, khususnya remaja putri (Tanabe et al. 2015). Penelitian kualitatif yang telah dilakukan pada anak yang berusia 18-24 dengan kelainan fisik, visual, dan tunarungu di Senegal menemukan bahwa biaya keuangan merupakan penghalang utama untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi
- e. Kurangnya Kerahasiaan jika Bantuan Komunikasi diperlukan
Sebuah penelitian di Ibadan, Nigeria dengan 167 anak perempuan berusia 11-24 tahun dengan gangguan pendengaran menemukan bahwa lebih dari sepertiga (37%) anak perempuan merasa malu untuk bertanya dihadapan seorang penerjemah. 53% partisipan menghawatirkan kerahasiaan interaksi, dan merasa di kecualikan atas keputusan terkait dengan kesehatannya mereka sendiri (*not oriented patient center care*)(Arulogun et al. 2013)

D. Perawatan yang Baik Untuk Peningkatan Aksesibilitas

1. Beberapa kelompok bekerja untuk meningkatkan akses dan penggunaan layanan keluarga berencana bagi perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas. Terdapat suatu tinjauan sistematis yang membuktikan pengetahuan dan penggunaan kontrasepsi diantara penyandang disabilitas intelektual, fisik, atau sensorik dari negara berpenghasilan tinggi menunjukkan bahwa setelah dilakukan pasca-intervensi terdapat peningkatan pengetahuan dan penggunaan kontrasepsi (Horner-Johnson et al. 2019)
2. Mengikutseratakan penyandang disabilitas dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi yang akan meluas pada program keluarga berencana. Terdapat sebuah bukti sebelumnya bahwa kurangnya pemantauan dalam menilai inklusi penyandang disabilitas, dengan banyak program yang sedang berjalan lama dan tidak dirancang dengan mempertimbangkan inklusi sehingga dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan disabilitas dalam kegiatan monitoring dan evaluasi
3. Perlunya pendekatan multikomponen untuk merencanakan strategi yang sesuai. Contoh praktik yang paling sering disebutkan oleh beberapa literatur adalah :
 - a. Pelibatan perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas dalam pengembangan kebijakan dan program layanan kesehatan reproduksi dengan prinsip "*nothing about us, without us*" (Burke et al. 2017). Program harus secara aktif bekerjasama dengan individu disabilitas untuk memastikan bahwa strategi

bersifat fleksibel dan responsive terhadap kebutuhan khususnya konteks perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas. Terdapat sebuah contoh dari praktik yang menjanjikan dari Filipina adalah *Participatory Action Groups* (PAG) yang difasilitasi sejawat (kelompok terstruktur yang menyatukan perempuan penyandang disabilitas untuk membahas masalah kesehatan seksual dan reproduksi). Evaluasi dari program PAG menunjukkan perubahan yang positif dalam kehidupan perempuan yang dikaitkan dengan partisipasi peserta dalam PAG, termasuk peningkatan dalam pengetahuan tentang seksualitas, kesehatan dan hak reproduksi, peningkatan kepercayaan diri, dukungan sebaya dan akses layanan.

b. Pendidikan Sebaya

Meningkatkan kesadaran penyandang disabilitas tentang metode keluarga berencana dan layanan kesehatan seksual. Terdapat sebuah penelitian yang menemukan bahwa keterpaparan terhadap Pendidikan sebaya terkait secara signifikan dengan kehadirannya di layanan kesehatan, dan Pendidikan sebaya dipandang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan menggunakan Metode inovatif yang dikembangkan secara lokal seperti boneka tuli, pesan teks yang banyak digunakan oleh penyandang disabilitas tunarungu.

c. Mengatasi Hambatan Sikap dengan Pengasuh dan Masyarakat

Terdapat sebuah inovatif praktik yang bertujuan untuk mengatasi hambatan adalah *Dance Into Space Foundation*. Pertunjukan tari kontemporer memberikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas untuk berbagi cerita dan membahas mitos seputar disabilitas dan seksualitas di depan penyandang disabilitas lainnya, pengasuh dan masyarakat sekitar penyandang disabilitas. Terdapat sebuah laporan bahwa adanya kegiatan tersebut dapat mencerahkan dan mengubah persepsi mereka tentang disabilitas dan seksualitas (Development 2017)

d. Menyesuaikan pesan-pesan penting untuk meningkatkan kesadaran dan Pendidikan tentang keluarga berencana dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Pengadaan metode Pendidikan pelayanan keluarga berencana menggunakan bahasa isyarat dan membuat inovatif Alat Bantu KB (AKB) dalam versi braille. Terdapat sebuah inovasi teknologi dan media sosial yang didanai oleh UNFPA yaitu aplikasi berbasis web dan seluler yang mana menargetkan 800.000 pengguna remaja tuna rungu yang mencari informasi layanan kesehatan reproduksi dalam bahasa isyarat, dan kampanye sukses untuk pemuda tuna rungu menggunakan poster dengan kode batang yang memberi mereka akses ke video dengan bahasa tangan yang mana membahas tentang seksualitas dan kesehatan seksual (Aguilar and Chief 2017)

e. Mengatasi sikap negative diantara petugas layanan kesehatan dan memastikan informasi pilihan kontrasepsi melalui pelatihan. Dalam upaya mewujudkan hal

tersebut dapat melibatkan konferensi kepekaan terhadap individu disabilitas dengan kementerian kesehatan, LSM lokal, dan pekerja layanan kesehatan. Sumber daya yang ada juga telah dikembangkan untuk membantu membangun kapasitas dan keterampilan komunikasi interprofessional penyedia layanan kesehatan. Seperti halnya panduan sumber daya untuk penyedia layanan kesehatan reproduksi/keluarga berencana tentang penyertaan penyandang disabilitas dalam layanan kesehatan reproduksi, menyediakan panduan Langkah demi Langkah untuk mengutamakan disabilitas dan mengembangkan pendekatan bertarget khusus disabilitas (UNFPA 2018)

- f. Melibatkan anggota keluarga dalam intervensi keluarga berencana. Hal ini penting untuk mendapatkan dukungan dari pengasuh dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan KB, terutama penting dalam konteks budaya konservatif. Seperti halnya pelatihan yang dilakukan dengan menggandeng beberapa organisasi mitra lokal yang berkaitan dengan berbagai kegiatan layanan kesehatan reproduksi : pelatihan untuk remaja penyandang disabilitas, pendidikan sebaya, ruang aman, kegiatan sekolah dan penyediaan informasi dalam format yang dapat diakses (Dutch Coalition on Disability and Development 2017)
- g. Layanan satelit dan Pendidikan seksualitas yang ditawarkan kepada individu dengan disabilitas dan sekolah khusus untuk masyarakat penyandang disabilitas merupakan upaya pendekatan lainnya yang berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan keluarga berencana. Terdapat sebuah kegiatan Pendidikan seksual yang di rancang oleh *Niketan Foundation* dan *Rutgers Foundation* yaitu Pendidikan seksual “Its my body” yang digunakan di sekolah sekolah khusus dengan mengintegrasikan kedalam sebuah mata kuliah kesehatan seksual dan reproduksi yang mana bertujuan untuk memberdayakan remaja perempuan dan laki-laki penyandang disabilitas intelektual usia 13-15 tahun.
- h. Mengumpulkan data untuk menghasilkan pengetahuan baru untuk membantu perubahan perencanaan pemerintah dan layanan untuk wanita dan gadis perempuan dengan disabilitas.
- i. Memastikan bahwa layanan keluarga berencana dapat diakses oleh perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas seperti halnya panduan global tentang “ Keluarga Berencana: Buku Pegangan Global untuk Penyedia” oleh organisasi kesehatan dunia dan USAID yang didalamnya merekomendasikan fasilitas yang mudah diakses secara fisik (landau untuk kursi roda, kamar mandi besar dengan adanya pelang pegangan), program pengjangkauan untuk masyarakat dengan mobilitas terbatas, dan materi cetak dengan grafik yang sederhana, besar dan braille serta ditambah dengan format audio. Terdapat program lainnya yang di dirikan oleh foundation di Uganda

dimana mereka mendirikan klinik keliling dengan tim multidisiplin terlatih untuk meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi bagi anak perempuan dan perempuan muda penyandang disabilitas di pedesaan atau daerah terpencil(Aguilar and Chief 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, Anne-Birgitte AlbrechtsenCatalina Devandas, and Chief. 2017. "Let Me Decide and Thrive." *Review of Disability Studies, An International Journal* 2(Recognising the most Disempowered): (4)1-20. Plan International United Nations Office in Geneva and our Global Gender and Inclusion Team with support of many colleagues across the Federation including the Global Influencing and Partnerships Department.
- Ahumuza, Sharon Eva, Joseph K.B. Matovu, John Bosco Ddamulira, and Florence Kyoheirwe Muhanguzi. 2014. "Challenges in Accessing Sexual and Reproductive Health Services by People with Physical Disabilities in Kampala, Uganda." *Reproductive Health* 11(1): 1–9.
- Arulogun, Oyedunni S et al. 2013. "Experiences of Girls with Hearing Impairment in Accessing Reproductive Health Care Services in Ibadan, Nigeria." *African journal of reproductive health* 17(1): 85–93.
- Ayiga, Natal, and Stella Kigozi. 2016. "Access to and Uptake of Contraception by Women with Disabilities." *Journal of Social Sciences* 12(4): 171–81.
- Bell, Emma et al. 2015. "DFID GUIDANCE NOTE: PART A RATIONALE AND APPROACH Addressing Violence against Women and Girls in Health Programming About the Violence against Women and Girls Helpdesk." (3): 1–23.
- Buchy, By Marlène, Elisabeth Resch, Lorraine Wappling, and Stephen Jones. 2017. "Scoping Study : Donor Support for Disability - Inclusive Country - Led Evaluation Systems and Processes." (July).
- Burke, Eva et al. 2017. "A Qualitative Study to Explore the Barriers and Enablers for Young People with Disabilities to Access Sexual and Reproductive Health Services in Senegal." *Reproductive health matters* 25(50): 43–54.
- Carew, Mark T. et al. 2017. "The Sexual Lives of People with Disabilities within Low- and Middle-Income Countries: A Scoping Study of Studies Published in English." *Global Health Action* 10(1). <https://doi.org/10.1080/16549716.2017.1337342>.
- Development, Dutch Coalition on Disability and. 2017. *Everybody Matters: Good Practices for Inclusion of People with Disabilities in Sexual and Reproductive Health and Rights Programmes, Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) and Share-Net International*.
- Devkota, Hridaya R., Maria Kett, and Nora Groce. 2019. "Societal Attitude and Behaviours towards Women with Disabilities in Rural Nepal: Pregnancy, Childbirth and Motherhood." *BMC Pregnancy and Childbirth* 19(1): 1–13.
- DFID. 2018. "DFID's Strategy for Disability Inclusive Development 2018-23." (December). https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/760997/Disability-Inclusion-

Strategy.pdf?_ga=2.163578047.1842669681.1566976735-725364533.1566976735.

- Dutch Coalition on Disability and Development. 2017. *Everybody Matters: Good Practices for Inclusion of People with Disabilities in Sexual and Reproductive Health and Rights Programmes*. Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) and Share-Net International.
- Fraser, Erika, and Nick Corby. 2019. "Family Planning for Women and Girls with Disabilities." *Disability Inclusion Helpdesk Report* (January): 1–15.
- Heera, Sonali, and Arti Maini. 2018. "Disability Inclusion." (November): 79–88.
- Horner-Johnson, Willi et al. 2019. "Contraceptive Knowledge and Use among Women with Intellectual, Physical, or Sensory Disabilities: A Systematic Review." *Disability and health journal* 12(2): 139–54.
- Kassa, Tigist Alemu, Tobias Luck, Assegedech Bekele, and Steffi G. Riedel-Heller. 2016. "Sexual and Reproductive Health of Young People with Disability in Ethiopia: A Study on Knowledge, Attitude and Practice: A Cross-Sectional Study." *Globalization and Health* 12(1): 1–11. <http://dx.doi.org/10.1186/s12992-016-0142-3>.
- Mesfin Yesgat, Yibeltal et al. 2020. "<p>Utilization of Family Planning Methods and Associated Factors Among Reproductive-Age Women with Disability in Arba Minch Town, Southern Ethiopia</P>." *Open Access Journal of Contraception* Volume 11: 25–32.
- Milligan, Maureen S., and Aldred H. Neufeldt. 2001. "The Myth of Asexuality: A Survey of Social and Empirical Evidence." *Sexuality and Disability* 19(2): 91–109.
- Mirza, Mansha. 2015. "Disability-Inclusive Healthcare in Humanitarian Camps: Pushing the Boundaries of Disability Studies and Global Health." *Open Access* 2(1): 479–500. www.dgsjournal.org.
- Mostafa Amr¹, Nevin FW Zaki^{2*}, Dahoud Raddad³ et al. 2017. "Journal of Behavior Therapy and Mental Health ISSN NO : 2474 - 9273 Ingredients of Intensive Case Management : " (2): 1–20.
- Mprah, Wisdom Kwadwo, Patricia Anafi, and Frank Owusu Sekyere. 2014. "Does Disability Matter? Disability in Sexual and Reproductive Health Policies and Research in Ghana." *International quarterly of community health education* 35(1): 21–35.
- Nations, United. 2016. "Arsenic and the 2030 Agenda for Sustainable Development." *Arsenic Research and Global Sustainability - Proceedings of the 6th International Congress on Arsenic in the Environment, AS 2016*: 12–14.
- OMS. 2014. "Ensuring Human Rights in the Provision of Contraceptive Information and Services." *Oms*: 34.

- Organization, World Health. 2009. *Promoting Sexual and Reproductive Health for Persons with Disabilities*. Geneva: rhrpublication.
- Remme, M, C Michaels-Igbokwe, and C Watts. 2015. "What Works to Prevent Violence against Women and Girls Evidence Reviews." (June). <https://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2018/04/2015-WW-Evidence-Review-4.pdf>.
- Rohleder, Poul. 2018. *Disability and Sexual Health*. UK.
- Services, Reproductive Health. 2020. "Understanding the Factors Affecting Access and Utilization of Sexual and Reproductive Health Services among Persons with Request for Proposals." (August).
- Taleporos, George, and Marita P. McCabe. 2002. "The Impact of Sexual Esteem, Body Esteem, and Sexual Satisfaction on Psychological Well-Being in People with Physical Disability." *Sexuality and Disability* 20(3): 177–83.
- Tanabe, Mihoko et al. 2015. "Intersecting Sexual and Reproductive Health and Disability in Humanitarian Settings: Risks, Needs, and Capacities of Refugees with Disabilities in Kenya, Nepal, and Uganda." *Sexuality and disability* 33(4): 411–27.
- UNFPA. 2018. *Young Persons with Disabilities: Global Study on Ending Gender-Based Violence and Realising Sexual and Reproductive Health and Rights*. New York: UNFPA.

BAB 6

PERILAKU MAKAN MENYIMPANG PADA REMAJA

Astin Nur Hanifah, SST, M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Pendahuluan

Masalah utama remaja Indonesia salah satunya yaitu masalah kesehatan yang berhubungan dengan gizi. Jika zat gizi seseorang kurang atau berlebih, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh sehingga menimbulkan masalah gizi. Menurut Sulistyoningih, masalah gizi yang dialami remaja antara lain seperti gizi kurang, gizi lebih, anemia, obesitas, dan masalah yang berhubungan dengan gangguan perilaku makan berupa *anorexia nervosa* dan *bulimia nervosa* (Ferina, 2020).

Permasalahan gizi kurang dan gizi lebih pada remaja di dunia menurut WHO tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah anak dan remaja yang mengalami kurang gizi di dunia mencapai 104 juta, Asia Selatan merupakan prevalensi kurang gizi terbesar di dunia yaitu 46%, disusul Afrika 28% dan Amerika Latin 7%. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa terdapat 8,7% remaja usia 13- 15 tahun dan 8,1% remaja usia 16-18 tahun dengan kondisi kurus dan sangat kurus, sedangkan prevalensi berat badan lebih dan obesitas sebesar 16,0% pada remaja usia 13-15 tahun dan 13,5% pada remaja usia 16-18 tahun (Riskesdas Jatim, 2018).

Masalah gizi yang terjadi pada remaja diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu perilaku makan yang tidak baik. Kekurangan gizi pada remaja sering terjadi akibat dari adanya pembatasan konsumsi makanan dengan tidak memperhatikan kandungan gizi dan kaidah kesehatan. Hal inilah yang dilakukan remaja yang tidak puas terhadap bentuk tubuh dan berat badannya, agar mendapatkan badan yang ideal dengan tubuh tinggi dan kurus. Perilaku makan yang tidak baik dapat menyebabkan gangguan makan. Gangguan makan ditandai dengan persepsi negatif mengenai bentuk tubuhnya, perubahan perilaku makan menjadi kurang baik, dan pengaturan berat 2 badan yang kurang tepat.

Kategori gangguan makan yaitu *Anorexia Nervosa* (AN), *Bulimia Nervosa* (BN), *Binge Eating Disorder* (BED), *Eating Disorder No Otherwise Specified* (EDNOS). *Anorexia nervosa* adalah keadaan kelaparan kronis dengan keabnormalan kelenjer endokrin, kurang optimalnya pertumbuhan selama remaja, osteoporosis, anemia, hipotermia, sinus bradycardia dan penyakit lainnya. Sedangkan, dampak seseorang yang mengalami *bulimia nervosa* seperti perdarahan esophagus, metabolisme asam, karies gigi, *renal calculi* dan dehidrasi. *Binge eating disorder* adalah gangguan makan yang tidak dapat mengontrol makanannya dan tidak diikuti dengan pembersihan fisik atau latihan yang berlebihan, yang akan mengalami kelebihan berat badan atau

obesitas. Dampak lain dari gangguan makan yaitu gangguan pada jantung, dimana resiko tertinggi pada penderita adalah gagal jantung.

Studi yang dilakukan oleh Galmiche dalam *The American Journal Of Clinical Nutrition* mendapatkan terjadinya peningkatan prevalensi gangguan makan global pada periode 2000-2006 sebesar 3,5% menjadi 7,8% untuk periode 2013-2018. Galmiche menemukan bahwa studi gangguan makan lebih banyak terjadi pada wanita. Studi lain dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terutama di negara-negara Asia mengenai gangguan makan, mengalami kenaikan seperti yang dijelaskan oleh Fairburn bahwa adanya peningkatan prevalensi gangguan makan dalam populasi Asia. Jepang memiliki prevalensi gangguan makan tertinggi di Asia, diikuti oleh Hongkong, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Prevalensi wanita muda yang berada di Singapura beresiko untuk menderita gangguan makan sebesar 7,4%.

Prevalensi gangguan makan di Indonesia tidak diketahui secara pasti dikarenakan masih kurangnya penelitian mengenai topik ini. Tetapi, beberapa peneliti sudah memulai melakukan studi mengenai gangguan makan terutama pada remaja. Studi yang dilakukan pada siswi SMAN 70 Jaksel menyebutkan lebih dari 88,5% responden memiliki gangguan makan. Penelitian pada remaja putri di SMAN 6 Jakarta Selatan didapatkan hasil bahwa 6,8% remaja putri menderita *anorexia nervosa*, 50,0% menderita *bulimia nervosa*, 6,4% menderita binge eating disorder dan 0,4% menderita EDNOS. Penelitian lain menyebutkan bahwa 5,1% remaja putri dan 3,5% remaja putra di SMAN 1 Sleman Yogyakarta mengalami gangguan makan. Selain itu, penelitian pada SMAK St. Stanislaus Surabaya didapatkan hasil 85,7% beresiko rendah mengalami gangguan makan dan 14,3% beresiko tinggi mengalami gangguan makan.

Faktor yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan makan seperti faktor individu, keluarga, biologis, dan psikologis. Selain itu, juga terdapat penyebab lain terjadinya gangguan makan seperti kepercayaan diri yang kurang, perilaku diet yang tidak sehat dan perhatian terhadap citra tubuh yang berlebihan. Pengaruh lingkungan seperti status ekonomi orang tua, kelompok atau teman, iklan di media massa dan tersediannya berbagai macam makanan dengan kandungan gizi yang tidak seimbang dapat memicu terjadinya perubahan kebiasaan makan yang tidak baik. Berbagai studi yang meneliti mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan makan pada remaja di Indonesia mendapatkan hasil yang bervariasi. (Ferina, 2020)

Gizi seimbang sangat dibutuhkan untuk remaja, agar tidak mengalami gangguan pola makan. Gizi Seimbang untuk remaja usia 10-19 tahun (Pra-pubertas dan Pubertas) Kelompok ini adalah kelompok usia peralihan dari anak-anak menjadi remaja muda sampai dewasa. Kondisi penting yang berpengaruh terhadap kebutuhan zat gizi kelompok ini adalah pertumbuhan cepat memasuki usia pubertas,

kebiasaan jajan, menstruasi dan perhatian terhadap penampilan fisik citra tubuh (body image) pada remaja putri. Dengan demikian perhitungan terhadap kebutuhan zat gizi pada kelompok ini harus memperhatikan kondisi-kondisi tersebut. Khusus pada remaja putri, perhatian harus lebih ditekankan terhadap persiapan mereka sebelum menikah.

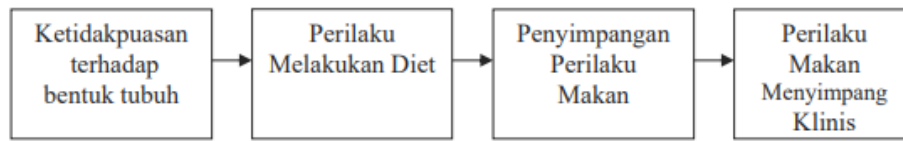
Pesan Gizi Seimbang untuk remaja usia 10-19 tahun (Pra-Pubertas dan Pubertas) Secara umum anak usia 10-19 tahun telah memasuki masa remaja yang mempunyai karakteristik motorik dan kognitif yang lebih dewasa dibanding usia sebelumnya. Anak remaja laki-laki pada umumnya menyukai aktivitas fisik yang berat dan berkerenget. Dari sisi pertumbuhan linier (tinggi badan) pada awal remaja terjadi pertumbuhan pesat tahap kedua. Hal ini berdampak pada pentingnya kebutuhan energi, protein, lemak, air, kalsium, magnesium, vitamin D dan vitamin A yang penting bagi pertumbuhan. Pesan Gizi Seimbang untuk remaja sama dengan pesan-pesan untuk anak usia 6-9 tahun, yang membedakan adalah porsi yang lebih banyak. Sedangkan untuk remaja putri dan calon pengantin diberikan pesan khusus seperti biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan khususnya bagi remaja putri dan calon pengantin serta banyak makan sayuran hijau dan buah-buahan berwarna. (Permenkes RI, 2014)

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa negara telah mengatur terkait kebutuhan gizi yang dituangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Dalam rancangan ini, pemerintah mengupayakan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas di masa yang akan datang. Khususnya hal ini lebih ditekankan pada remaja perempuan, untuk mempersiapkan dirinya agar siap apabila ingin merencanakan program kehamilan ketika sudah menikah nanti tanpa resiko baik bagi dirinya maupun janin yang dikandung.

B. Definisi perilaku makan menyimpang

Perilaku makan menyimpang atau yang biasa disebut *eating disorders* adalah gangguan perilaku makan yang kompleks dan memberikan efek pada kesehatan fisik atau mental atau keduanya (Fairburn, 2000 dalam Garrow, 2000). Hal ini biasa terjadi karena perhatian yang berlebihan terhadap berat dan bentuk tubuh. Perilaku makan menyimpang memberikan pengaruh yang cukup serius dalam prevalensinya dan sangat berpotensi mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan mental dan aktivitas fisik (Brown, 2005).

Menurut *Mental Health Guidelines dalam Grosvenor dan Smolin (2002)*, ada tiga kategori perilaku makan menyimpang yaitu *anorexia nervosa*, *bulimia nervosa* dan *eating disorder not otherwise specified (EDNOS)* yang termasuk *binge eating disorder*.



Gambar 6.1 Rangkaian Penyimpangan dan Kecemasan yang Berkaitan dengan Berat Badan

C. Penyebab penyimpangan makan

1. Faktor sosial

Standar kecantikan dan nilai tinggi yang diberikan pada penampilan perempuan berkontribusi menyebabkan gangguan makan. Kesimpulan ini didukung oleh bukti-bukti epidemiologis dan penelitian lain yang mendokumentasikan bahwa :

- a. Gangguan makan jauh lebih lazim di kalangan perempuan muda dibanding laki-laki muda.
- b. Prevalensi gangguan makan meningkat, ketika gambaran tentang perempuan ideal semakin menekankan kekurusan ekstrem.
- c. Perempuan muda sangat berkemungkinan untuk mengembangkan gangguan makan selama masa remaja dan dewasa muda, umur dimana budaya kita memberikan penekanan besar pada penampilan kecantikan, dan kekurusan.
- d. Gangguan makan bahkan lebih lazim lagi di kalangan perempuan muda yang bekerja di bidang-bidang yang menekankan berat badan dan penampilan, seperti model, penari balet, dan pesenam. Fakta tersebut memperjelas bahwa gadis remaja dan perempuan muda beresiko untuk mengembangkan gangguan makan, sebagian karena mereka berusaha membentuk dirinya, secara cukup harfiah, agar cocok dengan gambaran proporsi perempuan kurus.

2. Faktor psikologis

Gangguan makan pada umumnya juga dapat mengakibatkan masalah psikologis yang serius, seperti disfungsi sosial yang dialami baik di lingkungan rumah, sekolah atau pun tempat kerja, dan juga dapat berdampak pada gangguan pada kesehatan apabila tidak segera diatasi. Para peneliti telah menghipotesiskan tentang banyak faktor psikologis yang berkontribusi pada gangguan makan, yaitu yang terdiri dari :

- a. Perjuangan untuk Meraih Kesempurnaan dan Kontrol
- b. Depresi, *Self Esteem* Rendah dan Disforia
- c. Pencitraan Tubuh Negatif

3. Faktor Media Sosial

Media sosial diketahui dapat berperan langsung maupun tidak langsung terhadap kejadian gangguan makan pada remaja, hal tersebut dipengaruhi oleh :

- a. Implikasi dalam menciptakan gambaran tubuh yang ideal melalui foto atau gambar yang diunggah, sehingga menyebabkan remaja tidak percaya diri dan timbul keinginan memiliki bentuk tubuh serupa yang berdampak pada kejadian gangguan makan. (Kleemans et al. 2018)
- b. Fenomena yang menyebabkan timbulnya citra tubuh negatif mampu menurunkan kepercayaan diri remaja, karena penampilan tubuh yang dianggap kurang menarik sehingga berkorelasi dengan kejadian gangguan makan. (Saunders & Eaton, 2018)
- c. Tingginya interaksi dengan teman sebaya, meskipun pada dasarnya media sosial dapat diakses oleh berbagai tipe masyarakat. Dapat mempengaruhi pola gangguan makan pada remaja, karena faktor lingkungan sosialnya. (Fitzsimmons-Craft dan Wilksch et al, 2020).

4. Faktor Stress

Stress merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi gangguan makan atau sering dikenal dengan sebutan *Eating disorder*, hal ini disebabkan oleh tingkat keparahan stress yang tidak segera ditangani. Penyebabnya antara lain :

- a. Tingkat kecemasan remaja terhadap tugas sekolah, terkadang membuat remaja menjadi *overthinking* terhadap tugas yang mempengaruhi pola makan.
- b. Aktivitas fisik remaja yang banyak, membuat remaja seringkali lupa terhadap jadwal makan yang tentunya akan mengganggu pola makanya.
- c. Tuntutan yang dihadapi oleh remaja baik dari orang tua, guru, maupun lingkungan sekitar membuat remaja mengalami stress yang berdampak pada pola makan.

5. Faktor Lingkungan

Lingkungan sering kali menjadi faktor terpenting dalam pertumbuhan remaja, karena pola asuh yang dilakukan sejak kecil hingga remaja khususnya yang berkaitan dengan pola makan akan dibawa sampai dewasa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

a. Lingkungan Keluarga

Keluarga menjadi salah satu tolak ukur yang dapat dikaitkan dengan pola makan remaja, dimana pemberian makan kepada anak sejak kecil khususnya untuk makanan yang disukai maupun yang tidak disukai biasanya dibawa sejak kecil.

b. Lingkungan Pergaulan

Seiring berjalannya waktu, dimana remaja mulai memiliki teman pergaulan yang tidak hanya digunakan sebagai wadah untuk sharing tentang tugas sekolah tetapi juga sebagai teman bermain. Dimana remaja akan mencari makan disela keseruannya bermain, namun saat ini remaja cenderung banyak memilih

makanan *junk food* tanpa membatasi konsumsinya yang kemudian berpengaruh pada pola makan.

c. Lingkungan masyarakat

Lingkungan masyarakat sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi pola makan remaja, khususnya bagi remaja yang berada di lingkungan perdesaan. Dimana keberadaan masyarakat yang masih sering kali ikut campur dalam urusan orang lain, seperti body shaming yang dilakukan jika melihat remaja yang memiliki tubuh gemuk atau kurus. Hal tersebut akhirnya berimbas pada gangguan pola makan pada remaja, berbeda dengan masyarakat di perkotaan yang acuh terhadap lingkungan sekitar.

D. Macam-macam penyimpangan makan pada remaja

1. Anorexia nervosa

a. Definisi

Anorexia nervosa sering kali diartikan sebagai gangguan pola makan dengan cara membuat dirinya merasa tetap lapar (*self-starvation*). Biasanya terjadi pada remaja wanita yang ingin menginjak bangku SMA (sekolah menengah atas), dengan tujuan agar memiliki penampilan fisik yang ramping dan menarik sehingga dapat menarik perhatian lawan jenisnya. Anoreksia nervosa merupakan sebuah gangguan makan, hal tersebut ditandai dengan adanya penolakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat yang disertai rasa takut berlebihan terhadap peningkatan berat badan akibat penampilan fisik. Penampilan fisiki pada penderita Anorexia nervosa dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya dipengaruhi faktor kognitif (pola penyimpangan dalam menilai suatu situasi) hal ini dapat menyebabkan cara berpikir dan cara memandang fisiknya yang kemudian berpengaruh pada pola makan. Anorexia nervosa sendiri merupakan sebuah penyakit kompleks yang merupakan bagian beberapa komponen seperti psikologikal, sosiologikal, dan fisiologikal, biasanya pada penderita ditemukan peningkatan rasio enzim hati ALT (Alanine Transaminase) dan GGT (Gamma-glutamyl grand frase), sehingga menyebabkan disfungsi hati akut pada tingkat lanjut. Seseorang yang menderita Anorexia nervosa sering dijuluki dengan *anoreksik* atau (lebih tidak umum) anorektik. Istilah ini sering kali namun tidak benar disingkat menjadi anorexia, yang berarti gejala medis kehilangan nafsu makan. Karena kata *anorektik* sendiri, dapat juga menunjuk pada salah satu contoh obat penahan nafsu. (H. Krisnani, dkk, 2017)

b. Gejala

Menurut H. Krisnani (2017) beberapa gejala awal Anoreksia nervosa yang perlu kita diwaspadai, diantaranya adalah berat badan yang tidak stabil, tidak seimbang dengan umur, postur, serta tinggi tubuh (biasanya mencapai 15% di

bawah berat normal). Gejala lain bagi seseorang yang menderita anorexia nervosa, antara lain:

- 1) Tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan berturut-turut (untuk wanita)
- 2) Tidak mau dan menolak makan di depan umum dengan berbagai alasan
- 3) Sering merasa gelisah di berbagai situasi
- 4) Tubuh lemah
- 5) Kulit terlihat kusam
- 6) Terjadinya gangguan pernafasan, yang mengakibatkan nafas pendek-pendek
- 7) Khawatir berlebih terhadap asupan kalori yang dikonsumsi

c. Klasifikasi

DSM IV mengklasifikasikan *anorexia nervosa* menjadi dua tipe yang lebih spesifik yaitu:

- 1) *Restricting Type* : Selama episode *anorexia nervosa*, penderita tidak secara rutin melakukan *binge eating/purging* (contoh: melakukan pemuntahan dengan sengaja atau penyalahgunaan laksatif, diuretik dan enema).
- 2) *Binge eating/Purging Type* : Selama episode *anorexia nervosa*, penderita secara rutin melakukan *binge eating/purging* (contoh: melakukan pemuntahan dengan sengaja atau penyalahgunaan laksatif, diuretik dan enema)

d. Dampak

Penderita anorexia nervosa dapat mengganggu kestabilan kerja sistem tubuh sehingga menimbulkan beberapa dampak buruk, diantaranya : penyusutan tulang, kehilangan mineral, rendahnya suhu tubuh, detak jantung yang tidak teratur, gangguan permanen terhadap pertumbuhan badan, rawan terkena gangguan tulang seperti osteoporosis, bahkan juga bulimia nervosa. Selain itu, dampak yang lebih buruk bisa menyerang penderita Anorexia nervosa, apabila penderita mengonsumsi laksatif yang diketahui sangat berbahaya bagi tubuh. Laksatif sendiri merupakan substansi yang akan memaksa tubuh untuk mengeluarkan cairan serta makanan yang masih diproses di dalam usus sehingga proses penyerapan nutrisi menjadi tidak sempurna. Selain itu laksatif mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang mungkin dapat diserap oleh tubuh, apalagi jika penggunaan laksatif dibiarkan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan permanen pada kestabilan sistem pencernaan serta menyebabkan tubuh kekurangan banyak nutrisi.

Walaupun begitu penderita anorexia nervosa tetap menghindari makan, karena ketertarikan pada makanan yang cukup intensif. Bahkan sering kali penderita Anorexia nervosa melakukan aktifitas seperti memasak untuk orang lain, berbicara tentang makanan, dan bersikeras untuk melihat orang lain

makan. Padahal penderita anoreksia nervosa memiliki gambaran tubuh yang terganggu, dengan menganggap bahwa mereka akan menjadi menarik hanya bila mereka terlihat seperti sebuah tengkorak. Penderita anorexia nervosa akan membuat dirinya merasa kelaparan sehingga, jumlah lemak didalam tubuh terus manurun sampai batas minimum. Hal tersebut tentunya akan menghambat pola mentruasi, bahkan sampai membuat menstruasi berhenti. (H. Krisnani, dkk, 2017)

2. Bulimia Nervosa

a. Pengertian

Menurut Z. Shabah dan D. Dhanny (2020), Bulimia nervosa merupakan gangguan pola makan yang dapat dicirikan dengan adanya usaha dari diri seseorang untuk memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan sebelumnya. Berbeda dengan penderita *anorexia nervosa* yang memiliki penurunan berat badan drastis, penderita *bulimia nervosa* memiliki berat badan yang ideal dengan fluktuasi berat badan yang sangat ekstrim karena pengkonsumsian makanan dalam jumlah besar. Seseorang yang menderita *bulimia* biasanya memiliki rata-rata berat badan yang sesuai dengan tingginya sehingga penderita *bulimia* jarang dapat dideteksi dan diketahui orang.

b. Karakteristik

Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM-IV)*, karakteristik penderita *bulimia nervosa* diantaranya:

- 1) Episode berulang *binge eating* dengan karakteristik:
 - a) Makan dalam periode waktu yang tetap (contoh: tiap 2 jam) dengan porsi yang lebih besar daripada porsi makan kebanyakan orang dalam periode dan situasi yang sama.
 - b) Adanya perasaan tidak dapat mengontrol porsi makan pada saat episode tersebut berlangsung (contoh: merasa tidak dapat menghentikan atau mengontrol berapa porsi yang dimakan).
- 2) Adanya perilaku kompensasi yang berulang kali dilakukan untuk mencegah kenaikan berat badan seperti : muntah yang disengaja, penyalahgunaan laksatif, diuretik, enema atau obat-obatan lainnya, puasa atau olahraga berlebihan.
- 3) Episode *binge eating* dan perilaku kompensasi lainnya berlangsung setidaknya dua kali seminggu dalam tiga bulan
- 4) Penilaian diri dipengaruhi oleh bentuk tubuh dan berat badan
- 5) Gangguan tersebut tidak terjadi secara eksklusif selama episode *anorexia nervosa*

c. Dampak

Menurut (H. Krisnani, dkk, 2017), dampak bagi penderita bulimia antara lain:

1. Pembengkakan, yang terjadi pada kelenjar ludah di pipi .
2. Jaringan parut, pada buku jari tangan yang biasanya digunakan sebagai rangsangan untuk muntah
3. Terjadinya pengikisan gigi akibat sering muntah dan mengeluarkan asam lambung
4. Rendahnya kadar kalium dalam darah.
5. Gigi menjadi sensitive, terhadap panas atau dingin.
6. Adanya masalah, pada kelenjar ludah yang berupa rasa nyeri atau pembengkakan.
7. Terjadinya paparan asam lambung berlebih, pada kerongkongan yang dapat menyebabkan borok, pecah atau penyempitan.
8. Terganggunya proses pencernaan akibat pencahar, yang dapat mengakibatkan disfungsi organ pencernaan.
9. Terjadinya ketidakseimbangan cairan tubuh, akibat stimulus zat diuretic secara berlebih.

3. Binge Eating Disorder

a. Definisi

Binge eating disorder biasanya ditandai dengan tidak terkendalinya jadwal makan yang dilakukan oleh penderita, biasanya penderita membuat jadwal minimal sekali seminggu dan kemudian merasa bersalah, serta disertai dengan makan sampai kekenyangan dalam sekali waktu, makan banyak meski tidak merasa lapar, makan makanan dengan sangat cepat, namun seringkali disertai rasa malu atau stres dengan pola makan tersebut. Pada umumnya, penderita eating disorders adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, dimana mereka merasa tidak berdaya, dan perasaan tidak sebanding dengan orang lain. Mereka menggunakan makanan dan diet sebagai cara untuk mengatasi masalah-masalah dalam hidup mereka, banyak dari mereka berpikir bahwa makanan adalah sumber kenyamanan atau penghilang stress sementara penurunan berat badan dianggap sebagai cara agar diterima oleh teman-teman dan keluarga (L. Rukmana, 2013).

b. Tahapan

1) Membangun Ketegangan

Binge Eating Disorder awalnya dibangun dengan adanya rasa ketegangan pada diri seseorang, hal ini biasanya ditandai dengan perasaan tidak tenang dan merasa ada sesuatu yang salah sehingga menyebabkan timbulnya ketegangan. Rasa ketidaktenangan tersebut seringkali dirasakan oleh

penderita, namun tidak semua penderita Binge Eating Disorder mampu merasakannya.

2) Melepas Ketegangan

Rasa ketegangan yang dialami pada penderita, kemudian akan mencapai titik kelelahan. Dimana penderita akan mulai makan dalam jumlah yang banyak, karena ingin menghilangkan perasaan negatif yang mengganggu. Namun, perasaan tersebut hanya berlangsung tidak lama.

3) Pasca Binge

Tahap ini terjadi ketika adanya rasa kekenyangan dalam diri penderita yang dapat timbul masalah seperti sakit kepala, mual, diare, dan kelelahan.

4) Awal Baru (*New Beginning*)

Terjadinya resolusi dan harapan baru dari penderita, yang ditandai dengan berkomitmen pada diri sendiri untuk tidak makan di keesokan harinya ataupun memutuskan untuk melakukan diet.

c. Ciri-Ciri

Pada penderita Binge Eating Disorder, sering kali ditemukan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Perubahan pola makan dengan porsi yang berlebihan, dalam waktu yang sama dibandingkan dengan biasanya.
- 2) Nafsu makan tidak terkendali, sehingga adanya keinginan untuk makan secara terus menerus tanpa memperdulikan apapun.
- 3) Proses mengolah makanan dalam mulut yang dilakukan lebih cepat, seperti pada saat mengunyah yang berdampak terhabatnya metabolisme pengelolaan dalam tubuh terganggu.
- 4) Mengonsumsi makanan saat merasa lapar, dan tetap makan meskipun tidak merasa lapar.
- 5) Timbul rasa bersalah, depresi, dan tidak suka terhadap diri sendiri karena sadar telah makan secara berlebihan.
- 6) Biasanya pada penderita tidak disertai dengan kompensasi, seperti memuntahkan makanan dengan disengaja dan meminum obat pencahar.

d. Penyebab

Faktor yang mempengaruhi seseorang dapat mengalami Binge Eating Disorder, antara lain:

1) Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang mempengaruhi Binge Eating Disorder ditandai dengan perasaan rendah diri, depresi, dan tidak berdaya pada penderita. Perasaan tersebut dapat timbul akibat trauma dimasa lalu, yang dijadikan sebagai pelampiasan.

2) Faktor Sosial

Standar kecantikan di lingkungan sosial yang semakin tinggi, membuat penderita berusaha untuk memenuhinya. Namun pada kenyataannya sering kali sulit dicapai, yang dapat membuat penderita memiliki permasalahan psikologi seperti stress bahkan sampai depresi.

3) Faktor Genetik

Bagi penderita yang memiliki orang dengan masalah berat badan, dapat berisiko menurunkan lebih tinggi kepada anaknya yang menyebabkan masalah berat badan yang sama pula.

e. Pencegahan

Hal-hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari masalah Binge Eating Disorder, sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi kebiasaan makan dan minum.
- 2) Mengatur jadwal makan.
- 3) Menemukan masalah pola makan dan mencari solusi agar terhindar dari masalah Binge Eating Disorder.
- 4) Membuat daftar makanan yang boleh dikonsumsi dan yang harus dihindari agar terhindar dari Binge Eating Disorder.
- 5) Melakukan aktivitas yang disukai.

4. Obesitas

a. Definisi

Obesitas adalah suatu kondisi dengan kelebihan lemak pada tubuh disebabkan oleh makan yang secara berlebihan atau terus menerus. Obesitas dikelompokkan sebagai gangguan medis kronis, bukan gangguan psikologis. Obesitas juga merupakan faktor risiko terbesar untuk penyakit kronis yang secara potensial membahayakan jiwa seperti sakit jantung, diabetes, dan beberapa bentuk kanker. Perilaku makan berlebihan dapat mengakibatkan gangguan berat badan seperti obesitas, selain itu perilaku mengurangi makan juga dapat menurunkan berat badan sehingga kurangnya nutrisi yang diperlukan tubuh. (T. Dewi, 2014). Pada remaja kejadian kegemukan dan obesitas merupakan masalah yang serius karena kejadian obesitas dapat berisiko untuk berlanjut hingga usia dewasa. Obesitas sendiri terutama disebabkan oleh pengaruh faktor lingkungan, khususnya terjadi melalui ketidakseimbangan antara kebiasaan pola makan dan perilaku makan sehari-hari. (O. Mokolensang, dkk, 2016)

b. Gejala

Obesitas bisa menyebabkan berbagai masalah ortopedik, termasuk nyeri punggung bawah dan memperburuk osteoarthritis (terutama di daerah pinggul, lutut dan pergelangan kaki). Juga kadang sering ditemukan kelainan

kulit. Seseorang yang menderita obesitas memiliki permukaan tubuh yang relative lebih sempit dibandingkan dengan berat badannya, sehingga panas tubuh tidak dapat dibuang secara efisien dan mengeluarkan keringat yang lebih banyak.

c. Faktor yang memengaruhi

1. Faktor makanan, salah satu faktor dari kejadian obesitas pada remaja adalah pola makan atau asupan makanan berlebih yang berasal dari jenis makanan olahan yang serba instan, minuman soft drink, makanan jajanan seperti makanan cepat saji (burger, pizza, hot dog) yang tersedia di gerai makanan. (Ebni, 2021)
2. Faktor keturunan, genetik merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan kepada anak bagi yang orang tua yang memiliki riwayat Obesitas.
3. Faktor Hormon, hormon yang mempengaruhi pada kejadian Obesitas diantaranya adalah hormon leptin, ghrelin, tyroid, insulin, dan esterogen.
4. Faktor Psikologis Pada beberapa individu kebutuhan akan makan lebih banyak dari biasanya bisa ia merasa membutuhkan kebutuhan khusus untuk keamanan emosional.
5. Gaya Hidup yang kurang tepat Kemajuan sosial ekonomi, teknologi dan informatika yang global telah menyebabkan gaya hidup yang meliputi pola pikir & sikap yang terlihat dari pola makan & aktivitas fisik biasanya.

5. Pica

a. Definisi

Kebiasaan makan benda yang tidak bisa dimakan (tidak lazim dimakan), yang tidak memiliki nutrisi dan nilai gizinya. Pica seringkali dikenal sebagai gangguan yang berbahaya, karena dapat membawa dampak negatif dan membutuhkan intervensi khusus bagi penderitanya. Biasanya penderita Pica lebih banyak menyerang pada individu yang memiliki gizi rendah dan individu dengan diagnosis autism. (G. Stephanie dan E. Djuwita, 2019). Gangguan makan Pica merupakan suatu perilaku abnormal yang ditunjukkan dengan adanya perilaku mengonsumsi makanan yang nonnutritif atau memakan suatu benda yang tidak bergizi seperti batu bata, sabun, pasta gigi, tembakau, pasir, penghapus, pensil, dan lain-lain. (M. Zuhriansyah, M. Dahria, dan S. Murniati. 2018)

b. Faktor penyebab

Pica terjadi karena kebiasaan anak mencoba-coba dan tidak disertai penjelasan dan bimbingan/dibiarkan karena tidak diketahui boleh orang tuanya. Selain itu, kemiskinan & pendidikan rendah orangtua juga ikut mempengaruhi terjadinya kebiasaan buruk tersebut.

E. Penanganan Gangguan Makan

Penanganan untuk gangguan makan menggunakan CBT (*Cognitive Behaviour Therapy*). CBT atau yang dikenal dengan Terapi Kognitif Behavior adalah terapi yang berpusat pada perubahan pola pikir kemudian diubah cara bertingkah laku pada klien. Adapun prosedur dalam Terapi Kognitif Behaviour adalah 5 sesi untuk penanganannya.

Menurut teori CBT Indonesia, memerlukan 5 sesi pertemuan yang secara sistematis dan terencana, meliputi:

- Sesi 1 : Assesment dan diagnosa awal
- Sesi 2 : Mencari emosi negatif, pikiran otomatis dan keyakinan utama yang berhubungan dengan gangguan.
- Sesi 3 : Menyusun rencana intervensi dengan memberikan konsekwensi positif-konsekwensi kepada klien dan significant person.
- Sesi 4 : Formulasi status, fokus terapi, intervensi tingkah laku lanjutan.
- Sesi 5 : Pencegahan Relapse

Terapi kognitif-perilaku (CBT) merupakan terapi yang mendasarkan pada teori kognitif perilaku yang menekankan pada kesaling terkaitan antara pikiran, perasaan dan perilaku, Menurut teori ini psikopatologi terjadi bila terdapat ketidak sesuaian antara tuntutan-tuntutan lingkungan dengan kapasitas adaptif individu.

Teori ini sangat efektif karena penderita telah memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki berat badan yang berlebih, pola makan yang tidak normal. Namun mereka tidak berdaya untuk mengendalikan dorongan makan pada saat perut terasa lapar sehingga diperlukan penyadaran pikiran dan perasaan agar subjek mampu mengenali dan kemudian mengevaluasi atau rnengubah cara berfikir, keyakinan dan perasaannya (mengenali diri sendiri dan lingkungan) yang salah, dapat mengubah perilaku maladaptive dengan cara mempelajari ketrampilan pengendalian diri dan staregi pemecahan masalah yang efektif (Okun, 1990).

Misalnya subjek diminta untuk melakukan latihan-latihan menantang pikiran yang negative seperti membandingkan gambar-gambar wanita atau pria yang mempunyai tubuh gemuk dan yang mempunyai tubuh ramping dengan tujuan mernbangkitkan persepsi yang berhubungan dengan body image-nya.

F. Upaya Pencegahan Gangguan Makan

Upaya – upaya pencegahan yang lebih sukses tidak memfokuskan secara langsung pada pencitraan tubuh atau gangguan makan. Sebuah contoh penting pendekatan tersebut adalah “*dissonance intervention*” yang partisipannya menyelesaikan tugas-tugas yang tidak konsisten dengan ideal tubuh kurus, misalnya mendiskusikan bagaimana cara membantu “gadis-gadis yang lebih muda” agar tidak menjadi terobsesi dengan penampilan mereka. Pendekatan sehat yang disebutkan terakhir menekankan manfaat makan dengan baik dan olahraga.

Suatu studi penting menempatkan secara acak 481 gadis remaja ke salah satu diantara kedua program pencegahan ini (masing-masing melibatkan tiga pertemuan kelompok yang masing-masing berdurasi satu jam) atau kelompok asesmen saja (kelompok kontrol tanpa penanganan) atau menulis tentang masalah-masalah emosional selama tiga jam. Hasil – hasil menunjukkan perbaikan akibat salah satu atau kedua intervensi dalam kaitannya ketidakpuasan tubuh, internalisasi ideal tubuh kurus, diet, *binge-eating/ purging* satu bulan setelah intervensi, dan dengan tingkat yang lebih terbatas, pada tindak lanjut 6 dan 12 bulan.

Hal yang penting, hasil-hasil untuk intervensi disonansi telah direplika dalam sebuah setting “dunia nyata”. Disamping itu, kelompok-kelompok disonansi yang dipimpin oleh remaja sebaya dalam kelompok-kelompok perempuan juga memperlihatkan efek-efek positif. Psikolog dan masyarakat harus menempuh jalan panjang untuk menolong para perempuan dan laki-laki untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara makan terlalu sedikit dan terlalu banyak, terobsesi dengan penampilan, dan lalai dengan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewita, Ebni. "Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Obesitas Pada Remaja Di Sma Negeri 2 Tambang." *Jurnal Kesehatan Tambusai* 2, No. `1 (2021): 7-9.
- G. Stephanie, E. Djuwita. "Efektivitas Teknik Antecedent Control Dan Differential Reinforcement of Alternative Behavior untuk Menurunkan Frekuensi Pica." *Seurune, Jurnal Psikologi Unsyiah* 2, No.2 (2019): 44-67.
- H. Krisnani, M. Santoso, D. Putri. "Gangguan Makan Anorexia Nervosa dan Bulimia Nervosa pada Remaja." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, No.3 (2017): 390-447.
- Kementerian Kesehatan RI, 2014 Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta; kementerian Kesehatan RI diakses pada tanggal 15 Desember 2022.
- Krisnani, Hetty., Meilany, B.S., Destia, P. 2017. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 390-447.
- L. Rukmana. "Kepercayaan Diri Pada Wanita Dewasa Awal Penderita Binge Eating." *Jurnal Psikologi* 10, No.100 (2017): 121-128.
- M. Zuhriansyah, M. Dahria, dan S. Murniyanti. "Sistem Pakar Mendiagnosa Gangguan Makan Pica (Pemakan Benda) Menggunakan Metode Dempster Shafer." *Jurnal CyberTech* 1, No.2 (2018): 267-274.
- Nevid, Jeffrey S., Spencer A. Rathus dan Beverly Greene. 2002. *Psikologi Abnormal: edisi kelima jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- O. Mokolensang, A. Manamping, dan Fatimah. "Hubungan Pola Makan Dan Obesitas Pada Remaja Di Kota Bitung." *Jurnal e-Biomedik* 4, No. 1 (2016).
- Riskesdas Jatim. (2018). Laporan Provinsi Jawa Timur RISKESDAS 2018. In *Kementerian Kesehatan RI*.
- T. Dewi. "Studi Deskriptif: Perilaku Makan pada Mahasiswa Universitas Surabaya." *Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 3, No.2 (2014): 1-15.
- T. Tunga. "Gangguan Makan pada Remaja Dipengaruhi oleh Media Sosial Melalui Citra Tubuh Negatif." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, No.1 (2022): 19.
- Z. Shabah, D. Dhanny. "Persepsi Tubuh dan Bulimia Nervosa pada Remaja Putri." *Muhammadiyah Journal of Nutrition and Food Science* 1, No. 2 (2020): 60.

BAB 7

PENGUNAAN SMARTPHONE TERHADAP PERILAKU SEXTING PADA REMAJA

Jusni, S.ST., M.Kes



BAB 7

PENGUNAAN SMARTPHONE TERHADAP PERILAKU SEXTING PADA REMAJA

Jusni, S.ST., M.Kes

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang, mempunyai penduduk berusia remaja yang cukup besar. *World Health Organization* (WHO) tahun 2014 mengemukakan bahwa remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18. Di dunia diperkirakan kelompok remaja berjumlah 1 milyar atau 18% dari jumlah penduduk dunia (Kemenkes 2015).

Jumlah remaja yang hampir sepertiga jumlah penduduk Indonesia ini merupakan modal untuk menciptakan generasi penerus bangsa berkualitas yang dibutuhkan untuk membangun suatu bangsa. Namun Salah satu perkembangan revolusi industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar di sektor teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi di kalangan remaja yaitu penggunaan Smartphone yang cukup meningkat, karena Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19, sehingga mengharuskan remaja belajar dalam jaringan (daring).

Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Jika dilihat dari segi kematangan biologis dan seksual, remaja sedang menunjukkan karakteristik seks sekunder sampai mencapai kematangan seks. Dilihat dari segi perkembangan kejiwaan, remaja sedang berkembang dari sifat anak-anak menjadi dewasa (Purwatiningsih dkk 2010). Saat ini intensitas remaja mengakses internet sangat tinggi, sehingga menimbulkan potensi remaja terpapar dari dampak negatif digital. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian/Lembaga agar dapat memastikan pencegahan pada anak dari konten-konten negatif baik pornografi, radikalisme, dan kekerasan.

Pada masa remaja terjadi perubahan fisik dan seksual yang signifikan sehingga ketertarikan seksual terhadap lawan jenis cukup besar dan dorongan seksual juga berkembang. Perubahan fisik yang pesat dan perubahan hormon merupakan pemicu masalah kesehatan remaja karena timbulnya dorongan motivasi seksual yang menjadikan remaja rawan terhadap penyakit dan masalah kesehatan reproduksi (kespro), termasuk perilaku seksual remaja salah satunya adalah sexting (kusumaryani Merry 2017).

Naiknya angka penggunaan Smartphone dan Internet selama pandemi COVID-19 mencapai hingga dua kali lipat dibandingkan dengan negara lain. Seperti China angka 4,3%. Tak hanya pada dewasa 14,5%, remaja juga mengalami peningkatan dalam penggunaan internet selama masa pandemi COVID-19. Sehingga meningkat mencapai 19,3%, Penggunaan internet yang meningkat pun tak hanya pada sisi produktivitas atau edukasi, melainkan untuk membuka media sosial diantaranya WhatsApp, Instagram, Facebook, Telegram, Line dan aplikasi lainnya.

Peningkatan yang cepat menuntut penyesuaian perilaku remaja tetapi umumnya penyesuaian perilaku tidak dapat mengikuti cepatnya pertumbuhan. Matangnya fungsi-fungsi seksual pada remaja, akan menimbulkan dorongan dan keinginan untuk pemuasan seksual. Munculnya smartphone yang menyediakan kebebasan bermedia sosial dan provider yang menyediakan murah layanan media sosial, jelas mengakibatkan remaja melupakan batasan-batasan pergaulan yang seharusnya mereka ketahui (Hanjani 2013).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat banyak orang bergantung pada kecanggihan teknologi, salah satunya dengan memanfaatkan smartphone. Smartphone sebenarnya tidak sekedar alat komunikasi saja, tetapi juga perangkat elektronik yang memiliki fitur hiburan seperti untuk memainkan musik, video maupun games. Sehingga dapat memicu rasa keingintahuan yang tinggi pada masa remaja, salah satunya keinginan menjadi seperti orang dewasa menyebabkan remaja ingin mencoba dan melakukan apa yang sering dilakukan oleh orang dewasa termasuk seksualitas. Jika tidak ada pemberian informasi yang tepat, remaja akan melakukan pencarian sendiri dari berbagai media seperti internet yang dapat diakses dengan mudah. Hasilnya mereka membaca, mendengar dan bahkan melihat hal-hal yang berhubungan dengan seks tanpa penjelasan yang benar membuat remaja jatuh kedalam perilaku seks yang tidak sehat. Rasa ingin tahu segala hal terkadang membuat remaja terjerumus dalam hal-hal yang tidak patut untuk dilakukan diusianya sehingga melakukan perilaku seks yang tidak sehat seperti sexting.

Istilah sexting mengacu pada pengiriman dan penerimaan gambar secara seksual melalui beberapa bentuk pesan virtual yang dimana seseorang mengirimkan pesan atau materi berupa gambar dan video secara elektronik terutama melalui smartphone, internet dan media elektronik lainnya (Andrea 2017). Meskipun sexting dipandang sebagai hal biasa untuk usia remaja, namun hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja, dimana remaja juga berpartisipasi dalam perilaku ini sehingga menyebabkan kekhawatiran diberbagai kalangan. Sexting juga digunakan untuk memberikan kepuasan hasrat seseorang dalam berhubungan *Long Distance Relationship* (LDR) misalnya ketika jarang bertemu orang yang LDR biasanya tetap bisa memberi kepuasan seksual kepada pasangannya dengan cara sexting.

Berdasarkan hasil penelitian Mirnawati Jufri (2019) tentang perilaku sexting pada remaja dikota Makassar memperlihatkan hasil 90,1% remaja sudah terpapar

perilaku sexting. Sedangkan di Indonesia sendiri pelanggaran sexting masuk dalam UU Pornografi pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan gambar yang berhubungan dengan telanjang, mempertunjukkan alat kelamin, atau aktivitas seksual baik yang normal maupun menyimpang. Pelaku bisa terkena jeratan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah.

Dengan semakin meningkatnya jumlah remaja dan diikuti permasalahan remaja yang sangat kompleks, terutama yang paling menonjol adalah masalah perilaku seks remaja, yang merupakan awal terjadinya permasalahan kesehatan reproduksi remaja, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang korelasi penggunaan smartphone terhadap perilaku sexting pada remaja di Kabupaten Bulukumba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada korelasi penggunaan smartphone terhadap perilaku sexting pada remaja di Kabupaten Bulukumba.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui korelasi penggunaan smartphone terhadap perilaku sexting pada remaja di Kabupaten Bulukumba

D. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kasmiran (2008) bahwa menggunakan metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang akan diteliti. Rancangan penelitian ini menggunakan desain koefisien korelasi yaitu jenis penelitian yang menekan pada waktu pengukuran/observasi yang dilakukan hanya satu waktu pada saat itu (Notoatmodjo 2012).

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian. karena dengan adanya analisis data, maka dapat diambil suatu kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan (Arikunto 2010). Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah kuantitatif.

1. Analisis Univariat

Analisis ini tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Dalam analisis data kuantitatif kumpulan data yang besar atau banyak belum jelas maknanya. Analisis ini berfungsi untuk

menyederhanakan dan meringkas kumpulan hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

p : Presentase

f : Frekuensi

n : Jumlah Sampel

2. Analisis bivariate

Analisis bivariate digunakan untuk melihat independen dan dependen dengan menggunakan uji korelasi “*koefision korelas*” Untuk mengetahui korelasi antar 2 variabel tersebut bermakna atau tidak bermakna. Menurut Lind, Marchal, Wathen, 2008 karakteristik dari koefision korelasi adalah:

- Sampel dari koefision Korelasi diidentifikasi oleh huruf r kecil
- Nilai r menunjukkan arah dan kekuatan dari hubungan linier antara 2 variabel
- Hubungan sempurna / sangat kuat merupakan bila $r=1$ ata $r=-1$
- Sebuah nilai mendekati 0 menunjukkan sedikit hubungan antar variabel / lemah
- Sebuah nilai mendekati 1 menunjukkan sebuah arah positif antar variabel
- Sebuah nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan kebalikan atau negatif antar variabel

Pedoman arti Korelasi

0,00 – 0,199 = Sangat rendah kekuatan dan arah koefifon korelasi

0,20 – 0,399 = Rendah

0,40 – 0,599 = Sedang

0,60 – 0,799 = Kuat

0,80 – 1,000 = Sangat kuat

E. Landasan Teori Tentang Remaja

1. Pengertian remaja

Istilah remaja berasal dari kata latin adolescence (kata bendanya, adolescence yang berarti remaja) yaitu tumbuh kearah kematangan, mulai dari kematangan fisik, sosial, dan psikologis (Widyastuti 2009). Remaja merupakan masa berkembang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa (Alamsyah 2009).

Pada masa ini remaja rawan terpengaruh oleh hal-hal negatif, bukan hanya itu perkembangan teknologi yang sangat pesat di era sekarang sangat berpengaruh terhadap remaja salah satunya adalah perilaku sexting akibat penggunaan dari teknologi.

2. Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Masa Remaja

Pertumbuhan dan perkembangan masa remaja merupakan proses yang saling terkait, bersinambungan, dan berlangsung secara bertahap. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan continue serta berlangsung selama periode tertentu. Pesat pertumbuhan remaja sering menimbulkan kejutan pada diri remaja itu sendiri. Yang juga menimbulkan gangguan regulasi dan tingkah laku. Perkembangan adalah perubahan psikis yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan sifat-sifat yang baru. Perkembangan remaja sedang berada dalam fase perkembangannya yang amat pesat, fisik sudah semakin kuat dan semakin menarik. Sudah mulai mampu berfikir untuk memecahkan masalahnya, emosinya sedang menggelora sehingga memiliki semangat membara. Hubungan sosial semakin menunjukkan toleransi kepada orang lain, apalagi dengan sesamanya remaja, bahasanya semakin kompleks dan memiliki bahasa khusus di kalangan remaja sendiri dan mereka sudah mulai mencoba sesuatu yang membuat mereka penasaran (Fatimah 2010; Hermawan 2013).

3. Perkembangan Pada Remaja

Tahap-tahap perkembangan remaja. Perkembangan pada hakikatnya adalah usaha penyusaian diri, yaitu untuk secara aktif mengatasi stress dan mencari jalan keluar baru dari berbagai masalah. Dalam proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada tiga tahap perkembangan remaja (Sundari, 2004).

a. Remaja awal (early adolescence)

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis, ia sudah berfantasi erotik, kepekaan yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap “ego”. Hal ini menyebabkan pada remaja awal sulit dimengerti orang dewasa.

b. Remaja madya (middle adolescence)

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “narastis”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang punya sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana peka atau tidak peduli, ramai-

ramai atau sendiri, optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari Oedipoes complex (perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa kanak-kanak) dengan mempererat hubungan dengan teman-teman dari lain jenis.

c. Remaja akhir (late adolescence)

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal, yaitu:

- 1) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
- 2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru.
- 3) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- 4) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- 5) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*privat self*) dan masyarakat umum (*the public*)

F. Landasan teori tentang Sexting

1. Pengertian Sexting

Sexting berasal dari kata Sex (Seks) dan Chatting (percakapan). Sedangkan menurut Bauermeister, Yeagley, Meanley, dan pingel menjelaskan bahwa sexting pada dasarnya berasal dari kata Seks (Sex) dan Short Message Service atau pengiriman pesan pendek yang lazim disebut dengan SMS (Texting) (Wahyu Rahardjo 2015). Istilah sexting muncul dibagian awal abad ini, tetapi maknanya telah berkembang dari waktu ke waktu, awalnya disebutkan bagi orang yang menggunakan ponsel untuk mengatur tanggal seks (atau Booty call).

Seiring waktu istilah berevolusi untuk merujuk mengirim pesan teks eksplisit secara seksual atau bernada seksual. Sebagai teknologi telah berkembang dan banyak orang memiliki kamera ponsel, dan sebagai kapasitas untuk menyimpan dan mentransfer data dalam jumlah besar telah meningkat, sexting sebagai istilah telah berkembang untuk juga merujuk pada transfer elektronik gambar telanjang dan setengah telanjang via telepon seluler (Kath Albury 2013).

Istilah “sexting” diciptakan pada tahun 2005 (Walker dkk 2013) berasal dari bahasa media (Ybarra & Mitchell, 2014) yang terdiri dari kata sex dan texting (Weidman dkk 2015). Sexting merupakan pengiriman dan penerimaan gambar sugestif dan eksplisit. Dimana terjadi pertukaran dan penyebaran gambar seksual dari satu ponsel ke ponsel lain. Baik melalui pesan teks, email atau pesan virtual ke internet maupun media sosial lainnya. Termasuk memposting di internet gambar yang ditayangkan secara seksual (Rayeed 2016).

2. Tipe-tipe sexting

Terdapat tiga tipe pelaku dalam alur proses melakukan sexting, yaitu:

- a. Receiver atau individu yang pernah menerima foto, gambar dan pesan seksual sugestif.
- b. Senders atau individu yang pernah mengirim foto, gambar dan pesan seksual sugestif.
- c. Two-way Sexters atau individu yang pernah menerima dan mengirim foto, gambar dan pesan seksual sugestif.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan sexting

Menurut pendapat ahli faktor-faktor yang menyebabkan sexting diantaranya:

- a. Pertukaran gambar semata-mata antara dua mitra romantis.
- b. Pertukaran antara mitra yang berbagi dengan orang lain diluar hubungan dan
- c. Pertukaran antara seseorang yang belum menjalin suatu hubungan, tetapi salah satu orang tersebut berharap untuk menjadi orang spesial.

4. Penyebab Perilaku Sexting

Perilaku sexting dapat disebabkan karena berbagai faktor antara lain:

a. Perkembangan teknologi

Masalah sexting muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi digital yang bercampur dengan hormon remaja yang bergejolak (Rayeed 2017). Komunikasi mobile elektronik, seperti pesan singkat dan teks mes-saging, telah mengubah lingkungan sosial pemuda masa kini (Houck dkk 2013). Teknologi telah mengubah cara remaja berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebayanya dalam banyak kasus, sexting adalah bagian dari bentuk komunikasi bagi remaja (Prather & Vandiver 2014).

Remaja yang lebih sering menggunakan ponsel lebih mungkin untuk menerima gambar seksual (Melissa dkk 2016). Prevalensi penggunaan telepon seluler juga dikaitkan dengan kemungkinan peningkatan mengirim dan menerima gambar sexting. Remaja yang secara teratur menggunakan pesan teks lebih sering bahkan lebih cenderung mengirim dan menerima pesan sexting dibandingkan remaja yang tidak menggunakan pesan teks secara teratur (Prather & vandiver 2014).

b. Pengetahuan

Minimnya informasi yang remaja miliki dan masih banyaknya orang tua yang masih merasa tabu membicarakan masalah seksual dengan anaknya. Sehingga menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dasar tentang seks dan berpaling pada sumber-sumber yang tidak akurat (Kusmira 2011). Remaja melakukan pencaharian sendiri dari berbagai media seperti internet yang dapat diakses dengan mudah. Hasilnya, mereka membacakan, mendengar dan bahkan melihat hal hal yang berhubungan dengan seks tanpa penjelasan yang benar (Kusmiran 2011).

- c. Pola asuh yang tidak efektif
Individu dengan pola asuh yang buruk, seperti kurangnya ikatan, pemantauan yang buruk, dan disiplin yang tidak konsisten atau tidak efektif lebih mungkin untuk mengalami pengendalian diri yang rendah. Kontrol diri yang rendah mencakup ketidakmampuan untuk menahan godaan saat ada kesempatan dan tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perilaku yang mereka perbuat. Sehingga pengendalian diri yang rendah merupakan faktor prediktor kriminalitas seperti sexting (Marcum dkk 2014).
 - d. Teman sebaya
Pergaulan dengan teman sebaya yang menyimpan meningkatkan kemungkinan perilaku sexting lebih tinggi (Marcum dkk 2014). Insiden lebih tinggi terjadi pada remaja khususnya perempuan dalam mengirim gambar diri mereka sendiri serta menerima gambar sexting (Prather dan vandiver 2014). Hal ini terjadi karena sexting lebih dapat diterima di kalangan remaja sehingga menyebabkan mereka mungkin tertekan untuk bisa menyesuaikan dengan trend atau mendapatkan tekanan dari seseorang (Rayeed 2017) salah satunya tertekan oleh pacar. Remaja juga sering kali melakukan sexting untuk menggoda, untuk mendapatkan perhatian, meminta sex, untuk sekedar lelucon, diperas, dipaksa, ataupun diancam oleh seseorang (Parather dan Vandiver 2014).
5. Dampak Negatif Sexting
- Perilaku sexting dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan remaja. Dampak buruk dari perilaku sexting antara lain:
- a. Perilaku seksual beresiko
Meskipun remaja mungkin lebih cerdas secara digital dibandingkan orang tua mereka, kurangnya kedewasaan dan kurangnya perhatian menyebabkan mereka dapat dengan cepat melakukan tindakan yang mengarah pada perilaku negatif (Houck dkk 2013). Remaja yang melakukan sexting lebih beresiko untuk melakukan seks dibandingkan dengan remaja yang tidak melakukan sexting (Kushner 2013). Rice dkk (2012) dan Hock dkk (2013). Menemukan bahwa remaja yang sexting 7 kali lebih aktif secara seksual dan hampir 2 kali lebih mungkin pernah melakukan hubungan seks tanpa kondom dari pada teman sebaya mereka.
 - b. Pornografi
Remaja semakin sering terpapar dengan konten pornografi, baik yang diproduksi sendiri maupun diperoleh dari sumber lain sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan akses terhadap pornografi pada kaum remaja (Andrea 2017). Hal ini disebabkan karena bagi anak laki-laki mereka lebih merasa aman dalam meminta hubungan seksual dengan anak perempuan secara online melalui internet. Sedangkan bagi anak perempuan mereka merasa aman dalam memproduksi dan mengirim gambar seksual, karena lingkungan online

menciptakan persepsi privasi bagi remaja. Sehingga sexting juga menjadi alternatif lain untuk melakukan seks dimana resiko kehamilan tidak ada. Hal ini menjadikan sexting sebagai bagian dari fase eksperimen seksual bagi remaja yang belum siap untuk melakukan aktivitas hubungan seksual secara fisik (Andrea 2017).

c. Eksploitasi seksual secara online

Sexting juga dapat menyebabkan eksploitasi seksual secara online. Akibat perlakuan ini sexting muda telah dibangun sebagai ancaman tidak hanya untuk diri mereka sendiri tetapi juga pada rekan-rekan mereka (Karaian & Meyl 2015).

d. Depresi

Sexting dapat mengakibatkan korban mengalami tekanan psikologis, seperti depresi, kecemasan dan pikiran untuk bunuh diri. Bagi anak perempuan penyebaran gambar dapat menyebabkan munculnya rasa malu dan mengalami penghinaan. Baik itu dari teman sebayanya maupun dari masyarakat sehingga mereka lebih cenderung menyalahkan diri sendiri (Andrea 2017).

Munculnya perasaan tidak nyaman dan terancam setelah menerima seks atau melakukan seks dari orang lain yang mereka temui secara online. Perasaan ini muncul disebabkan bukan hanya karena konten seksual yang didapatkan tetapi juga karena belum pernah bertemu pengirimnya. Ancaman ketika gambar yang dibuat bocor akan menimbulkan perasaan cemas dan paranoid bagi kaum muda yang bisa berlangsung bertahun-tahun setelah gambar dikirim (Andrea 2017).

e. Cyber online

Remaja rentan menjadi korban dan pelaku kejahatan online akibat perilaku sexting, seperti Cyber bullying, kasus pornografi yang dapat memberikan dampak negatif pada remaja (Marcum dkk 2014)

6. Pencegahan sexting

a. Edukasi

Pendidikan seksual disekolah sangat dibutuhkan oleh para siswa. Dimana dengan adanya pendidikan seksual ini dapat membantu dalam perkembangan fisik dan seksualitas remaja. Mereka membutuhkan lebih banyak informasi kesehatan seksual. Disinilah peran sekolah dalam menghadirkan konten kesehatan seksual bagi para siswa (Brewin dkk, 2014).

b. Kampanye publik

Membuat kampanye publik seperti menonton film pendek. "Megan's Story" merupakan salah satu film pendek yang ditayangkan di Australia. Kisah Megan ini sebagai kampanye publik melawan seks, memberi manfaat sebagai titik awal untuk menganalisis pemahaman praktik seks saat ini oleh kaum muda. Penayangan film ini bertujuan untuk memperingatkan kaum muda terhadap bahaya mobile 'sexting' (Albury & Crawford 2016). Dapat pula dilakukan

pencegahan secara online dengan melakukan kampanye pencegahan sexting melalui media internet (Doring 2014). Dengan membuat pesan pencegahan untuk menghindari perilaku sexting yang menggunakan media internet ataupun media sosial.

c. Peningkatan pengawasan orang tua

Psikolog Elly Risman Musa menjelaskan bahwa efek buruk information technology (IT), seperti pornografi, pornovisual dan komunikasi tanpa batas yang berujung pada hubungan seks merupakan akibat dari kelalaian orangtua (Sinergi 2016). Adanya pengawasan orang tua tentang penggunaan ponsel ini dapat membantu pencegahan perilaku sexting pada anak (Prather & Vandiver, 2014). Sangat perlu adanya pengawasan karena anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah (titipan) yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Oleh karena itu orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan barakhlaqul karimah. Elly juga mengingatkan kepada para orang tua, dimana mereka harus mampu menjelaskan kepada anak tentang sisi positif dan negatif dari teknologi (Sinergi 2016).

d. Membuat kebijakan sekolah

Tidak adanya kebijakan, kurikulum atau program pendidikan tentang sexting disekolah menjadi salah satu penyebab perilaku sexting kalangan remaja. Untuk itu perlu adanya pelaksanaan kebijakan di sekolah atau program pendidikan sexting dan dampaknya pada remaja untuk membantu upaya pencegahan yang efektif (Prather & Vandiver 2014). Seperti di Texas pada tahun 2011 membuat program pendidikan tentang pencegahan dan kesadaran sexting untuk mengatasi perilaku sexting pada anak (Melissa dkk 2016).

e. Pendidikan Keagamaan

Anak harus diajarkan mengenai akhlak yang baik sesuai dengan alquran dan hadis. Akhlak yang baik seperti masalah kesopanan, pandangan hidup tentang baik dan buruk, benar dan salah, etika dan moral, sopan santun diantara manusia, hubungan manusia dengan Allah, dan manusia dengan makhluk lainnya. Karena akhlak merupakan satu kesatuan utuh dari ajaran Islam, maka baik-buruk, benar-salah, haruslah bersumberkan kepada ajaran Allah. Tolok ukur kelakuan baik dan buruk mestilah merujuk kepada ketentuan Allah. Diyakini sepenuhnya bahwa apa yang dinilai baik oleh Allah pasti baik dalam esensinya begitu pula sebaliknya. Dalam al-Qur'an, karakter yang baik merupakan interaksi seluruh totalitas manusia, bukan nalar saja, tapi gabungan antara nalar dengan kesadaran moral dan kesucian jiwa. Karena itu karakter yang terpuji adalah hasil internalisasi nilai-nilai agama dan moral pada diri seseorang yang ditandai oleh sikap dan perilaku positif (Sari 2017).

Perilaku sexting merupakan salah satu perilaku negatif yang dilakukan remaja, dimana remaja memamerkan tubuhnya (aurat) secara eksplisit baik semi telanjang maupun telanjang dengan memotret atau dalam bentuk video dan mengirimkannya ke orang lain melalui smartphone (Anastassiou 2017). Dalam Islam diperintahkan untuk menutup aurat bagi yang sudah baligh (dewasa). Aurat adalah suatu anggota badan yang tidak boleh di tampilkan dan diperlihatkan oleh lelaki atau perempuan kepada orang lain.

f. Melakukan Konseling

Di Illinois pada tahun 2010 menerapkan cara untuk mengatasi perilaku sexting pada anak di bawah umur yang terlibat dalam sexting dengan mendapatkan konseling (Brewin dkk 2016). Diharapkan dengan melakukan konseling dapat meminimalisir perilaku sexting pada remaja.

g. Menjaga pergaulan

Pergaulan dengan teman sebaya yang memiliki sifat buruk dan menyimpang meningkatkan kemungkinan perilaku sexting lebih tinggi terjadi (Marcum dkk 2014). Agar supaya kita tidak terpengaruh oleh hal hal negatif yang ada disekitar untuk itu hendaknya para remaja berhati-hati dalam pergaulan. Bergaul dengan teman yang memiliki sifat dan perilaku baik tentunya akan membuat kita baik pula.

G. Landasan teori smartphone

1. Pengertian smartphone

Menurut Williams & Sawyer (2011) smartphone adalah telepon seluler dengan mikroprosesor, memori, layar dan modem bawaan. Smartphone merupakan ponsel multimedia yang menggabungkan fungsionalitas PC dan handset sehingga menghasilkan gadget yang mewah, dimana terdapat pesan teks, kamera, pemutar musik, video, game, akses email, tv digital, search engine, pengelola informasi pribadi, fitur GPS, jasa telepon internet dan bahkan terdapat telepon yang juga berfungsi sebagai kartu kredit.

2. Dampak positif dan negatif pada smartphone

Dampak positif smartphone dalam dunia pendidikan yaitu:

- a. Mempermudah komunikasi antara guru, pelajar dan orang tua
- b. Media hiburan, banyak aplikasi hiburan yang bisa menjadi sarana untuk belajar sekaligus bermain bagi mereka. Misalnya game yang mengasah kemampuan mengingat atau berhitung.
- c. Meningkatkan pengetahuan, hal ini sangat membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas.

3. Dampak negatif smartphone dalam dunia pendidikan yaitu:

- a. Tidak fokus saat belajar
- b. Dapat menyebabkan kecanduan

- c. Prestasi akademik menurun
- d. Dapat merubah perilaku seseorang

H. Hasil Penelitian

Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai korelasi penggunaan smartphone terhadap perilaku sexting pada remaja di Kabupaten Bulukumba dengan jumlah responden 35 yaitu siswa yang memiliki smartphone, adapun distribusi frekuensi karakteristik responden dan penggunaan smartphone, perilaku sexting serta korelasi antara penggunaan smartphone terhadap perilaku sexting pada remaja di Bulukumba sebagai berikut:

Analisa Univariat

1. Umur

Tabel 7.1 Distribusi Frekuensi Menurut Umur Responden Di Kabupaten Bulukumba

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	> 16 tahun	18	51,4
2	≤ 16 tahun	17	48,6
Total		35	100

Sumber Data : Primer tahun 2021

Dari Tabel 7.1 diketahui bahwa dari 35 responden ternyata responden usia >16 tahun sebanyak 18 (51,4%), sedangkan usia ≤16 tahun lebih sedikit yaitu 17 (48,6%).

2. Jenis Kelamin

Tabel 7.2 Distribusi Frekuensi Menurut Jenis Kelamin Responden di Kabupaten Bulukumba

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	13	37,1
2	Perempuan	22	62,9
Total		35	100

Sumber Data : Primer tahun 2021

Berdasarkan tabel 7.2 diketahui bahwa dari 35 responden diperoleh responden jenis kelamin laki-laki lebih sedikit yaitu 13 (37,1%) dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 22 (62.9%).

3. Penggunaan smartphone

Tabel 7.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penggunaan Smartphone

No	Penggunaan Smartphone	Jumlah	Persentase
1	Negatif	23	65,7
2	Positif	12	34,3
Total		35	100

Sumber Data : Primer tahun 2021

Berdasarkan tabel 7.3 bahwa dari 35 responden didapatkan penggunaan smartphone kategori negatif lebih banyak yaitu 23 (65,7%) responden dibandingkan dengan penggunaan smartphone kategori positif 12 (34,3%) responden.

4. Perilaku *Sexting*

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku *Sexting*

No	Perilaku <i>Sexting</i>	Jumlah	Persentase
1	Ya	26	74,3
2	Tidak	9	25,7
	Total	35	100

Sumber Data : Primer tahun 2021

Berdasarkan tabel 7.4 diketahui bahwa dari 35 responden, menunjukkan bahwa yang berperilaku *sexting* lebih tinggi yaitu 26 (74,3%) responden dibandingkan yang tidak berperilaku *sexting* sebanyak 9 (25,7%).

Analisa Bivariat

1. Korelasi SmartPhone Terhadap Perilaku *Sexting*

Tabel 4.5 Distribusi Koefisien Korelasi Penggunaan

Variabel	N	R	P
Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku <i>Sexting</i>	35	0,539	0,001

Hasil analisis bivariat dengan anova berdasarkan hasil uji korelasi antara penggunaan smartphone berkorelasi sedang ($r=0,539$) terhadap perilaku *sexting* dan hubungan tersebut secara statistik adalah ada hubungan yang signifikan ($p=0,001$). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin banyak yang menggunakan smartphone dalam kategori negatif maka akan semakin banyak yang berperilaku *sexting*.

I. Pembahasan

Menurut Williams & Sawyer (2011) smartphone adalah telepon seluler dengan mikroprosesor, memori, layar dan modem bawaan. Salah satu dampak negatif smartphone dalam dunia pendidikan adalah dapat merubah perilaku seseorang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian bahwa dari 35 responden didapatkan penggunaan smartphone kategori negatif lebih banyak yaitu 65,7% di

bandingkan dengan penggunaan smartphone kategori positif 34,3% sehingga berdampak pada perilaku remaja dimana terdapat 74,3% yang berperilaku sexting.

Menurut teori sexting merupakan pengiriman dan penerimaan gambar sugestif dan eksplisit. Dimana terjadi pertukaran dan penyebaran gambar seksual dari satu ponsel ke ponsel lain. Termasuk memposting di internet gambar yang ditayangkan secara seksual (Rayeed, 2016). Sedangkan Perilaku sexting menurut Anastassiou (2017) merupakan salah satu perilaku negatif yang dilakukan remaja, dimana remaja memamerkan tubuhnya (aurat) secara eksplisit baik semi telanjang maupun telanjang dengan memotret atau dalam bentuk video dan mengirimkannya ke orang lain melalui smartphone. Pada hasil penelitian didapatkan dari 35 responden yang berperilaku sexting lebih tinggi yaitu 26 (74,3%) responden dibandingkan yang tidak berperilaku sexting sebanyak 9 (25,7%). Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Mirnawati Jufri (2019) tentang perilaku sexting pada remaja dikota Makassar memperlihatkan hasil 90,1% remaja sudah terpapar perilaku sexting.

Pada hasil uji korelasi antara penggunaan smartphone terhadap perilaku sexting adalah berkorelasi sedang ($r=0,539$) dan hubungan tersebut secara statistik adalah ada hubungan yang signifikan ($p=0,001$). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin banyak yang menggunakan smartphone dalam kategori negatif maka akan semakin banyak yang berperilaku sexting. Angka tersebut menggambarkan bahwa 53,9% terdapat korelasi sedang dan ada hubungan yang signifikan ($p=0,001$). Hasil uji korelasi ini sejalan dengan beberapa teori dimana perilaku sexting dapat disebabkan karena berbagai faktor antara lain adalah perkembangan teknologi dimana masalah sexting muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi digital yang bercampur dengan hormon remaja yang bergejolak (Rayeed 2017), sehingga menurut Melissa dkk (2016) perkembangan teknologi dapat membuat remaja yang lebih sering menggunakan ponsel lebih mungkin untuk menerima gambar seksual, dan dimana pada masa pandemi COVID-19 ini remaja dianjurkan untuk melalui online sesuai Surat Edaran Nomor 15 ini untuk meningkatkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam masa Darurat Corona virus Disease (COVID-19). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak yang menggunakan smartphone dalam kategori negatif maka akan semakin banyak yang berperilaku sexting.

Hasil ini dapat diperkuat dengan karakteristik responden dimana menurut Prather dan vandiver (2014). Insiden lebih tinggi terjadi pada remaja khususnya perempuan dalam mengirim gambar diri mereka sendiri serta menerima gambar sexting. Dapat dilihat dari hasil penelitian ini bahwa responden jenis kelamin laki-laki lebih sedikit yaitu 13 (37,1%) dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 22 (62.9%). Masa remaja adalah masa percobaan, pembuktian dan masa pencarian identitas diri. Rasa penasaran dan ingin mencoba sesuatu hal yang baru

adalah hal yang wajar mereka rasakan. Pengetahuan yang masih kurang, rasa penasaran yang tinggi, masa percobaan, pembuktian dan pencarian identitas diri menjadikan remaja sebagai kelompok masyarakat yang beresiko terhadap perilaku negatif dari perkembangan teknologi, salah satunya adalah perilaku sexting yang menjadi trend baru dikalangan remaja saat ini (Walker dkk 2013).

Sedangkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan teori yang ada, peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi atau penggunaan smartphone selama masa pandemi COVID-19 berperan dan ada korelasi terhadap perilaku sexting pada remaja karena semakin banyak yang menggunakan smartphone dalam kategori negatif maka akan semakin banyak yang berperilaku sexting.

J. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 35 responden didapatkan penggunaan smartphone kategori negatif lebih banyak yaitu 65,7% di bandingkan dengan penggunaan smartphone kategori positif 34,3% sehingga berdampak pada perilaku remaja dimana terdapat 74,3% yang berperilaku sexting. Pada hasil penelitian didapatkan dari 35 responden yang berperilaku sexting lebih tinggi yaitu 26 (74,3%) responden dibandingkan yang tidak berperilaku sexting sebanyak 9 (25,7%).

Pada hasil uji korelasi antara penggunaan smartphone terhadap perilaku sexting adalah berkorelasi sedang ($r=0,539$) dan hubungan tersebut secara statistik adalah ada hubungan yang signifikan ($p=0,00$). Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa semakin banyak yang menggunakan smartphone dalam kategori negatif maka akan semakin banyak yang berperilaku sexting. Angka tersebut menggambarkan bahwa 53,9% terdapat korelasi sedang dan ada hubungan yang signifikan ($p=0,001$). Hasil uji korelasi ini sejalan dengan beberapa teori dimana perilaku sexting dapat disebabkan karena berbagai faktor antara lain adalah perkembangan teknologi dimana masalah sexting muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi digital yang bercampur dengan hormon remaja yang bergejolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara penggunaan smartphone terhadap perilaku sexting, walaupun hanya termasuk kategori berkorelasi sedang.

K. Saran

1. Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi atau gambaran untuk penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan dengan desain penelitian yang berbeda dengan menggunakan penelitian ini sebagai referensi awal dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi siswa

Siswa dapat meningkatkan pengetahuan tentang perilaku sexting, mengetahui perilaku yang termasuk dalam sexting, dampak buruknya, serta pencegahan yang dapat dilakukan remaja agar terhindar dari perilaku sexting. Manfaat positif dan negatif dari penggunaan media internet meningkatkan pemahaman agama, dengan mencari informasi yang baik dan akurat serta dapat memilih teman yang baik, lebih memperdalam pengetahuan agama, yang bisa dilakukan dengan memperbanyak membaca buku keagamaan, mengikuti organisasi/kegiatan keagamaan, agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif yang merugikan diri sendiri maupun pihak lain sehingga tidak terpengaruh dalam perilaku negatif.

3. Bagi pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar, sumber dan bahan pemikiran untuk pengembangan penelitian selanjutnya, terlebih lagi dalam penelitian ini sebagian besar remaja tidak mengetahui dampak dari perilaku sexting sehingga pihak sekolah dapat mengembangkan kurikulum dan meningkatkan peran pendidik khususnya bagi sekolah. Misalnya dengan menerapkan peraturan berperilaku yang baik sesuai norma agama yang berlaku, membuat kebijakan seperti melarang membawa smartphone disekolah guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan media tersebut ke hal-hal yang negatif dan perlunya mengadakan penyuluhan pendidikan tentang perilaku seksual remaja, perilaku sexting dan penyuluhan secara berkala dan berkesinambungan tentang penggunaan media social secara bijak agar siswa tidak terjerumus lebih dalam ke hal-hal negatif. Dimana penyuluhan ini dapat disampaikan oleh tenaga kesehatan/tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dibidang kesehatan dengan menambahkan kegiatan tersebut dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib. Selain itu, dengan menghidupkan atau mengaktifkan kegiatan-kegiatan keagamaan disekolah secara rutin sehingga remaja lebih mampu memperdalam pengetahuan agama yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Albury, Kath & Crawford, Kate. 2016. Sexting, consent and young people's ethics: Beyond Megan's Story. *Continuum: Journal of Media & Cultural Studies*. Vol. 26, No. 3. ISSN: 1030-4312.
- Alamsyah (2009), Psikologi Perkembangan. Jakarta :Erlangga
- Anastassiou, Andrea. 2017. Sexting and Young People: A Review of the Qualitative Literature. Volume 22, Number 8, Article 9, 2231-2239.<http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol22/iss8/9>
- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka kerja
- Brewin, Dorothy dkk. 2014. Behind Closed Doors: School Nurses and Sexual Education. *The Journal of School Nursing*. Vol. 30 (1) 31-41. DOI: 10.1177/1059840513484363.
- Döring, N. (2014). Consensual sexting among adolescents: Risk prevention through abstinence education or safer sexting. *Cyberpsychology*. Volume 8 (1) 1-18. <http://dx.doi.org/10.5817/CP2014> 1-9 Akses 13 Oktober 2017.
- Houck, Christopher D dkk. 2013. Sexting and Sexual Behavior in At-Risk.
- Hanjani (2013), Peningkatan Kebutuhan akan Media Sosial Pada Remaja
- Karaian, Lara & Van Meyl, Katherine. 2015. Reframing Risqué/Risky: Queer Temporalities, Teenage Sexting, and Freedom of Expression. ISSN 2075- 471X. Doi:10.3390/laws4010018. www.mdpi.com/journal/laws/ Akses 26 Agustus 2017.
- Kusmiran E. 2011. Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita. Jakarta: Salemba Medika.
- Kusumaryani, Merry 2017. Psikologi kepribadian, edisi revisi, Malang: UNM Press
- Kushner, Alexandra. 2013. The Need For Sexting Law Reform: Appropriate Punishments For Teenage Behaviors. Vol. 16, Iss. 3. <https://ldfebui.org/wp-content/uploads/2017/08/BN-06-2017.pdf>
- Marcum, Catherine D dkk. 2014. Sexting Behaviors among Adolescents in Rural North Carolina: A Theoretical Examination of Low Self-Control and Deviant Peer Association. *International Journal of Cyber Criminology (IJCC)* ISSN: 0974 – 2891. Vol 8 (2): 68–78. Akses 28 Agustus 2017.
- Majalah Triwulanan SINERGI. 2016. Penerbit: Jajaran Komunikasi Perusahaan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- Melissa R., McNiel, Dale E & Binder, Rene'e L. 2016. Minors and Sexting: Legal Implications. *J Am Acad Psychiatry Law* 44:73-81. Volume 44, Number 1. <http://jaap1/44/1/73.full> Akses 28 Agustus 2017.
- Notoadmojo S. 2010. Promosi Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo S. 2012. Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ott, B. L., & Mack, R. L. 2014. *Critical Media Studies :An Introduction*. Chichester: Wiley Blackwell
- Prather, Kathy & Vandiver, Donna M. 2014. Sexting among Teenagers in the United States: A Retrospective Analysis of Identifying Motivating Factors, Potential Targets, and the Role of a Capable Guardian. *International Journal of Cyber Criminology (IJCC)* ISSN: 0974 – 2891. Vol 8 (1)
- Rice, Eric. Rhoades, Harmony. Winetrobe, Hailey. Sanchez, Monica. Montoya, Jorge.
- Plant, Aaron. Kordic, Timothy. 2012. Sexually Explicit Cell Phone Messaging Associated With Sexual Risk Among Adolescents, Vol 130 (4).
- Sari, Dewi Purnama. 2017. Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Vol 1 No.1. P-ISSN 2580-3638, E-ISSN 2580-3646
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7172/5610>
- Walker, Shelley dkk. 2013. Sexting: Young Women"s and Men"s Views on Its Nature and Origins. *Journal of Adolescent Health*.
- Wahyu, SR., Maizar, & Indria, H. (2015) Harga Diri, Sexting dan Jumlah Pasangan Seks yang Dimiliki oleh Pria Lajang Pelaku Perilaku Seks Beresiko. *Jurnal Psikologi*. 42 (2)
- Widyastuti. 2009. Kesehatan Reproduksi. Yogyakarta: Fitramaya. Management Leveraging Web 2.0 Technologies. CRC Press : U.S. Page 2
- Weidman, Lisa B. Hightow dkk 2015. Youth, Technology And HIV: Recent Advances And Future Directions. Vol 12 (4) : 500-515. Doi: 10.1007/s11904-015-0280 x.
- Williams, BK. & Sawyer, SC. (2011). *Using Information Technology : A Practical Introduction to Computers and Communications*. Ed. 9. The McGraw-Hill Companies Inc, New York.
- Ybarra, Michele L.J. Mitchell. 2014. "Sexting" and its relation to sexual activity and sexual risk behavior in a national survey of adolescents. Vol 55(6): 757–764.

GLOSARIUM

C

Cyber online: pelaku kejahatan online akibat perilaku sexting, seperti Cyber bullying, kasus pornografi yang dapat memberikan dampak negatif pada remaja

P

Perilaku sexting: salah satu perilaku negatif yang dilakukan remaja, dimana remaja memamerkan tubuhnya (aurat) secara eksplisit baik semi telanjang maupun telanjang dengan memotret atau dalam bentuk video dan mengirimkannya ke orang lain melalui smartphone

R

Remaja: merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa

Receiver : individu yang pernah menerima foto, gambar dan pesan seksual sugestif.

S

Senders : individu yang pernah mengirim foto, gambar dan pesan seksual sugestif.

Sexting: berasal dari kata Sex (Seks) dan Chatting (percakapan)

Smartphone: ponsel multimedia yang menggabungkan fungsionalitas PC dan handset sehingga menghasilkan gadget yang mewah, dimana terdapat pesan teks, kamera, pemutar musik, video, game, akses email, tv digital, search engine, pengelola informasi pribadi, fitur GPS, jasa telepon internet dan bahkan terdapat telepon yang juga berfungsi sebagai kartu kredit.

T

Two-way Sexters : individu yang pernah menerima dan mengirim foto, gambar dan pesan seksual sugestif.

W

WHO: *World Health Organization*

INDEKS

Perilaku

Remaja

Sexting

Smartphone

BAB 8

GANGGUAN MENSTRUASI

Bd. Fauziah Winda Gurnita, M.Tr.Keb



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

A. Pendahuluan

Tanda berkembangnya kesehatan reproduksi wanita adalah pengeluaran darah dan mukosa secara teratur dalam satu siklus melalui vagina dari kondisi uterus wanita yang tidak mengalami kehamilan yang terjadi secara periodik dan dikendalikan oleh sistem hormonal tubuh seperti hipofisis, ovarium, hipotalamus dan uterus (Indika & Sepdanius, 2017). Normalnya siklus ini terjadi secara periodic dalam rentang 21 sampai 35 hari setiap siklusnya. Menstruasi sangat erat kaitannya dengan proses hormonal dalam tubuh yang dapat menyebabkan beberapa gangguan dan perubahan seperti waktu menstruasi lebih lama, darah menstruasi yang lebih banyak, siklus yang tidak teratur bahkan tidak mengalami menstruasi dalam periode waktu tertentu (Ardiani & Oktriani, 2015).

Kelompok wanita di tahap remaja akhir sekitar 75% mengalami gangguan menstruasi seperti dalam satu siklus atau kurun waktu tertentu tidak mengalami menstruasi, tidak teraturnya menstruasi, nyeri sebelum dan saat menstruasi serta keluarnya perdarahan menstruasi yang sangat banyak melebihi normal (Santi & Pribadi, 2018). Bentuk gangguan menstruasi dapat terjadi melalui nyeri sebelum dan saat terjadi menstruasi, wanita yang memiliki siklus menstruasi panjang dan pendek, keluarnya darah menstruasi yang berlebihan dan tidak teraturnya siklus menstruasi. Hal ini membuat wanita menjadi tidak nyaman saat tiba dan menjalani rangkaian prosesn menstruasinya (Safitri, 2021) (Florenxia Cabral, 2019).

Kemunculan gejala gangguan menstruasi sangat memiliki keterkaitan dengan sistem dan pengaturan hormonal dalam tubuh. Bentuk keluhan secara fisik dan psikologis adalah bentuk dari terganggunya pengaturan hormone pada hipotalamus, hipofisis dan ovarium sehingga menyebabkan kenaikan hormone progesterone, estrogen dan prostaglandin (Safitri, 2021). Salah satu komplikasi yang dapat terjadi jika seorang wanita mengalami gangguan menstruasii seperti tidak teraturnya siklus menstruasi berkepanjangan akan memungkinkan mengalami infertilitas karena pada siklus menstruasi yang tidak teratur mengindikasikan tidak adanya proses ovulasi di siklus menstruasi tersebut (Florenxia Cabral, 2019). Selain itu, gangguan lainnya seperti banyaknya pengeluaran darah saat menstruasi dalam periode waktu yang cukup lama berpotensi besar wanita mengalami anemia (Kusniyanto & Suiyarti, 2019).

Berdasarkan keterangan di atas sehingga perlu diketahui dengan jelas terkait bagaimana gangguan menstruasi yang dapat dialami seorang wanita agar dapat

memberikan edukasi untuk mempertimbangkan segala keputusan wanita terkait kesehatan reproduksinya sendiri dengan baik.

B. Gangguan Menstruasi

Gangguan menstruasi merupakan keadaan yang dialami saat menstruasi. Bentuk kelainan seperti terganggunya siklus menstruasi, pengeluaran perdarahan yang sangat banyak, dan lamanya periode waktu menstruasi. Gangguan lainnya dapat bervariasi mulai dari kategori ringan hingga berat dan menyebabkan komplikasi bagi wanita yang sedang mengalaminya.(Sherwood, 2009)

Klasifikasi gangguan menstruasi dapat dijelaskan sebagai berikut(Bachtum, n.d.; Sherwood, 2009):

1. Durasi dan Jumlah Pengeluaran Darah

Pengeluaran darah saat menstruasi dengan jumlah sangat banyak (tidak normal) sekitar 80ml pada satu siklus atau durasi waktu pengeluarannya lebih lama dari yang normal (7 hari). Penyebab gangguan ini dapat disebabkan terganggunya proses homeostatis ataupun keadaan endometrium yang sangat tipis.

2. Siklus Menstruasi

Ada tiga jenis gangguan pada siklus menstruasi yaitu polimenorhea menstruasi dengan siklus pendek (<24 hari), oligomenorhea dimana kebalikannya memiliki siklus lebih panjang (35 hari) serta amenorrhea yaitu keadaan dimana wanita tidak mengalami menstruasi minimal 3 bulan berturut-turut bahkan lebih.

3. Perdarahan

Pengeluaran perdarahan yang terjadi diantara 2 siklus dengan jumlah yang sedikit atau lebih banyak dari normal diikuti durasi waktu yang lebih pendek atau lebih panjang dari normal.

4. Gangguan lainnya

Sindrom menstruasi atau sering dikenal dengan *premenstrual syndrome* (PMS) yang merupakan kumpulan gejala emosional dan fisik yang dirasakan seminggu sebelum terjadi menstruasi berupa gangguan mood, cemas, penurunan minat dan gangguan emosi lainnya. Selain itu dismenorhea juga dapat dirasakan berupa nyeri sebelum dan saat menstruasi. Rasa nyeri di bagian perut bawah akibat kontraksi uterus saat meluruhkan endometrium sebagai bentuk dari proses fisiologi menstruasi.

C. Gangguan Menstruasi dan Aseptor KB Hormonal

Alasan yang mendasari keterikatan antara terjadinya hubungan yang erat beberapa bentuk gangguan menstruasi pada aseptor KB hormonal karena adanya peran ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh karena dua proses tersebut yang sama sama melibatkan sistem hormonal di dalam tubuh (Qomariah, 2018). Proses fisiologis menstruasi melibatkan hipofisis anterior gonadotrophine hormon,

hormon perangsang folikel (Follicle-stimulating hormone/FSH) dan hormon pelutein (luteinizing hormone/LH)(Basri, 2018). Sedangkan dalam sistem kerja penggunaan KB hormonal di dalam tubuh terjadi penambahan hormon estrogen dan progesterone dalam rangka untuk mencegah terjadinya kehamilan (Qomariah, 2018)(Sety, 2016). Mekanisme kerja KB hormonal adalah melalui penambahan hormon tunggal (progesterone) dan hormon kombinasi (estrogene & progesterone) yang berfungsi mencegah pengeluaran sel telur dan mengentalkan secret servix sehingga menyulitkan perjalanan sperma, menipisnya lapisan endometrium yang sangat tidak memadai untuk implantasi hasil konsepsi(Sety, 2016)

Salah satu gangguan menstruasi yang sangat sering dialami aseptor KB hormonal adalah terganggunya siklus menstruasi dan munculnya bercak hingga perdarahan. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesterone dalam tubuh yang mempengaruhi endometrium. Hasil studi menyebut bahwa gangguan menstruasi pada aseptor KB hormonal sudah dapat di duga sebelumnya karena efek dari penggunaan KB hormonal yang berdampak pada dinding uterus menjadi dangkal sehingga pengeluaran darah menstruasi sedikit atau bahkan tidak terjadi layaknya menstruasi normal. Menstruasi dapat kembali normal setelah 1 sampai 3 bulan bahkan waktunya lebih lama hingga tahunan tergantung durasi pemakaian KB hormonal (Qomariah, 2018).

Konsumsi KB hormonal dengan penambahan hormon kombinasi (estrogen & progesterone) memiliki sedikit kemungkinan gangguan menstruasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa efek penggunaan hormon kombinasi membuat siklus menstruasi menjadi teratur, pengeluaran darah normal serta tidak adanya nyeri menstruasi (Sety, 2016). Hal ini dikarenakan dengan adanya penambahan hormon kombinasi di dalam tubuh wanita pengguna KB hormonal menyebabkan terjadinya keseimbangan sistem hormonal di dalam tubuh sehingga tidak menyebabkan gangguan menstruasi(Laely & Fajarsari, 2011).

Pemberian KB hormonal berupa estrogen secara tunggal diberikan pada wanita pengguna KB hormonal membuat pembuluh darah kapiler menjadi normal kembali dengan sel endotel intek yang mengandung glikoprotein cukup untuk melindungi dari kerusakan sehingga sistem kerja hormonal dan siklus menstruasi menjadi normal dan pengeluaran darah menjadi lebih banyak. Selain itu efek lainnya adalah tertekannya produksi *Luteinizing hormone(LH)* yang membuat endometrium menjadi lebih tipis dan non-aktifnya kelenjar sehingga tidak ideal sebagai tempat implantasi hasil konsepsi(Laely & Fajarsari, 2011).

Salah satu gangguan menstruasi yang sangat sering terjadi pada aseptor KB hormonal yang harus menjadi perhatian adalah gangguan pada ketidakteraturannya siklus menstruasi karena dapat menyebabkan potensi terjadinya infertilitas. Tubuh wanita memiliki sepasang ovarium yang siap menghasilkan sebuah ovum dalam sebuah siklus mestruasi, jika siklusnya terganggu menjadi lama atau tidak beraturan

maka proses pematangan ovum akan terganggu(Milla, Mudayatiningsih, & Dewi, 2018).

D. Gangguan Menstruasi dan Tingkat Stress

Studi menyebutkan bahwa *premenstrual syndrome* menjadi keluhan yang sangat berarti dirasakan wanita pada gangguan menstruasinya(Sianipar et al., 2009). Tingkat stress dan gangguan menstruasi sangat erat kaitannya karena dipercaya sebagai pemicu. Stress adalah respon alamiah tubuh yang tidak dapat dijelaskan secara spesifik dan muncul karena adanya stressor (rangsangan/pemicu) terhadap hal-hal yang mengancam mekanisme pertahanan homeostatis(Sherwood, 2009). Hipotalamus akan bereaksi atas stressor yang diterima oleh tubuh dan mengirimkan impuls untuk pengeluaran hormone prolactin dan kortisol yang dapat menurunkan atau menekan produksi *luteinizing hormone (LH)* dan berlanjut pada munculnya gangguan siklus menstruasi wanita(Islamy & Farida, 2019)(Kusniyanto & Suiyarti, 2019).

Premenstrual syndrome merupakan kumpulan berbagai gejala fisik, psikis/emosional dan kebiasaan yang terjadi selama satu minggu sebelum menstruasi dan dapat menghilang setelah terjadinya menstruasi ataupun hingga selesai menstruasi²⁹³². Tanda dan gejala stress tiap wanita berbeda karena sumber stressor yang berbeda tiap individunya. Stress mempengaruhi sistem kerja neuro endokrinologi yang mempengaruhi pola menstruasi. Selain itu, stress juga berpengaruh pada elevasi tulang rawan dan mengurangi kadar *luteinizing hormone (LH)* di dalam tubuh yang membuat tidak diproduksi estrogen dan progesterone yang menjadi penyebab utama tidak teraturnya siklus menstruasi(Salianto, Zebua, Suherry, & Halijah, 2022; Toduho, Kundre, & Malara, 2014). Gejala fisik yang dapat menyertai saat stress seperti jantung berdebar, ada nyeri dada, ketegangan otot, pernapasan yang cepat, ekstermitas terasa dingin hingga gangguan seksual¹²¹⁸.

Fruktuasi hormon kortisol saat PMS berefek pada penurunan serotonin dan dopamin pada otak yang mengatur nafsu makan, tidur, suasana hati dan emosi. Adanya stressor maka sangat mempengaruhi bahkan pemicu untuk memperberat kejadian PMS ^{2,54}. Hasil studi menyebutkan semakin tinggi tingkat stress yang dialami maka kejadian gangguan menstruasi yang dialami akan semakin tinggi, korelasi ini memungkinkan terjadi namun berifat korelasi lemah. Hal ini dikarenakan stressor masing-masing individu sangat berbeda sehingga produksi kortisol juga akan berpengaruh dalam rangka menghambat pengeluaran *luteinizing hormone (LH)*(Bachtum, n.d.).hasil studi lainnya menyebutkan bahwa setiap paparan stress dapat menurunkan siklus menstruasi wanita selama 1 hari dari rata-rata siklus menstruasi normal(Sinha, Kapoor, & Kapoor, 2011).

PMS memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan gangguan menstruasi lainnya yaitu dismenorhea khususnya dismenorhea primer. Disamping waktunya

terjadinya yang sangat berdekatan juga karena saat seorang wanita mengalami stress hormone endokrin akan memproduksi hormone adrenalin, estrogen, progesterone dan prostaglandin dalam jumlah yang banyak. Estrogen mempengaruhi bagaimana kontraksi uterus terjadi, hormone adrenalin membuat otot tubuh dan rahim menjadi tegang yang berdampak pada penurunan fungsi ke endometrium membuat pembuluh darah atrofi dan berkurangnya suplai oksigen serta iskemik (Sri Rejeki, Nikmatul Khayati, & Riski Yunitasari, 2019).

Keluhan PMS dan dismenorhea sejatinya tidak dapat di biarkan dan dijadikan hal lumrah oleh wanita. Karena terganggunya pengeluaran hormone estrogen dan progesterone berdampak tidak teraturnya siklus menstruasi sehingga terkadang kasus infertilitas tidak ditemukan karena adanya kelainan genetic pada organ reproduksi melainkan akibat kelainan fungsi fisiologis sistem hormonal yang terganggu ataupun proses produksi sel telur (Hatmanti, 2015).

E. Penutup

Kewaspadaan terhadap bentuk dari segala macam gangguan menstruasi agar dapat lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meminimalisir komplikasi yang mungkin muncul di kemudian hari yang dapat berakibat fatal.

Upaya memperbaiki edukasi pelayanan kesehatan reproduksi sejak dini perlu dilakukan dan ditingkatkan agar memiliki pemahaman komprehensif dalam setiap proses perubahan fisiologi reproduksi yang dialaminya.

Gangguan menstruasi mulai dari psikologis maupun fisik semua memiliki efek samping masing-masing. Sehingga sikap waspada tetap harus dipelihara demi kesehatan wanita disepanjang daur kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, Y. A. Y., & Oktriani, T. O. T. (2015). Hubungan Indeks Masa Tubuh dengan Gangguan Menstruasi pada Mahasiswa Kebidanan STIKes Yarsi Sumbar Bukittinggi Tahun 2014. *Jurnal Kesehatan*, 6(2).
- Bachtum, R. Y. B. (n.d.). Hubungan tingkat stres terhadap kejadian gangguan menstruasi pada mahasiswi preklinik di fakultas kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Basri, S. W. G. (2018). Pengaruh Intensitas Olah Raga terhadap Kadar Hormon GNRH (Gonadotropin Releasing Hormon) pada Siklus Haid Altet di Pusat Pembinaan Latihan Pelajar Makassar. *UMI Medical Journal*, 3(2), 46–58.
- Florencia Cabral, J. (2019). Gambaran Gangguan Menstruasi pada Mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo Kabupaten Semarang. Universitas Ngudi Waluyo.
- Hatmanti, N. M. (2015). Tingkat Stres dengan Siklus Menstruasi pada Mahasiswa. *Journal of Health Sciences*, 8(1).
- Indika, P. M., & Sepdanius, E. (2017). Pengetahuan Guru Penjasorkes Tentang Keterkaitan Aktivitas Fisik Terhadap Gangguan Menstruasi di Kota Padang. *Sporta Saintika*, 2(2), 295–309.
- Islamy, A., & Farida, F. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus menstruasi pada remaja putri tingkat III. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 7(1), 13–18.
- Kusniyanto, R. E., & Suiyarti, W. (2019). Pengaruh Menarche Dan Lamanya Haid Terhadap Peningkatan Kejadian Dismenorea Primer. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Indonesia Timur* (Vol. 1, pp. 278–282).
- Laely, F. N., & Fajarsari, D. (2011). Perbedaan pengaruh KB Suntik Depo Medroxi Progesteron Asetat (DMPA) dengan KB Implan Terhadap Gangguan Menstruasi di Wilayah Kerja Puskesmas 1 Purwonegoro Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011. *Bidan Prada*, 2(02).
- Milla, S. Y., Mudayatiningsih, S., & Dewi, N. (2018). HUBUNGAN OBESITAS DENGAN GANGGUAN MENSTRUASI PADA REMAJA PUTRI DI KELURAHAN TLOGOMAS. *Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 3(1).
- Qomariah, S. (2018). ANALISIS PENGGUNAAN KONTRASEPSI SUNTIK TERHADAP GANGGUAN MENSTRUASI. *Jurnal Asuhan Ibu Dan Anak*, 3(1), 11–17.
- Safitri, D. E. (2021). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Gangguan Menstruasi pada Wanita Usia Subur. *Tirtayasa Medical Journal*, 1(1), 8–12.

- Salianto, S., Zebua, C. F. P., Suherry, K., & Halijah, S. (2022). HUBUNGAN TINGKAT STRESS DENGAN SIKLUS MENSTRUASI PADA REMAJA: STUDI LITERATURE. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*, 4(1), 67–81.
- Santi, D. R., & Pribadi, E. T. (2018). Kondisi gangguan menstruasi pada pasien yang berkunjung di Klinik Pratama UIN Sunan Ampel. *Journal of Health Science and Prevention*, 2(1), 14–21.
- Sety, L. M. (2016). Jenis pemakaian kontrasepsi hormonal dan gangguan menstruasi di wilayah kerja Puskesmas. *Jurnal Kesehatan*, 5(1).
- Sherwood, L. (2009). Human Physiologi From Cells To Cells To System. *West Virginia Thomsan. Publishing Inc.*
- Sianipar, O., Bunawan, N. C., Almazini, P., Calista, N., Wulandari, P., Rovenska, N., ... Suarthana, E. (2009). Prevalensi gangguan menstruasi dan faktor-faktor yang berhubungan pada siswi SMU di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur. *Maj Kedokt Indon*, 59(7), 308–313.
- Sinha, R., Kapoor, A. K., & Kapoor, S. (2011). Adiposity Measures and Menstrual Cycle: Do We Envisage a Relation? *Journal of Anthropology*, 2011.
- Sri Rejeki, S. R., Nikmatul Khayati, N. K., & Riski Yunitasari, R. Y. (2019). Hubungan Tingkat Stres Dan Karakteristik Remaja Putri Dengan Kejadian Dismenore Primer. *Jurnal Kebidanan*, 8(1), 50–55.
- Toduho, S., Kundre, R., & Malara, R. (2014). Hubungan Stres Psikologis dengan Siklus Menstruasi pada Siswi Kelas 1 di Sma Negeri 3 Tidore Kepulauan. *Jurnal Keperawatan*, 2(2).

BAB 9

STRATEGI PENURUNAN RESIKO HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN

Maratusholikhah Nurtyas, SST, M.Kes



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

STRATEGI PENURUNAN RESIKO HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN

Maratusholikhah Nurtyas, SST, M.Kes

A. Latar Belakang

Angka Kematian Ibu (AKI) di dunia masih sangat tinggi, sekitar 295.000 wanita meninggal akibat komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Pada tahun 2017 komplikasi utama yang menyebabkan hampir 75% dari semua kematian ibu adalah perdarahan hebat (kebanyakan perdarahan setelah melahirkan), infeksi (biasanya setelah melahirkan), tekanan darah tinggi selama kehamilan (preeklampsia dan eklampsia), komplikasi dari persalinan dan aborsi tidak aman.

Sementara itu di Indonesia kematian ibu juga masih didominasi oleh tiga penyebab utama yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK) dan infeksi. Namun proporsinya telah berubah dengan proporsi perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan sedangkan HDK proporsinya semakin meningkat. Lebih dari 25% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2013 disebabkan oleh HDK terutama preeklampsia dan eklampsia. Pada tahun 2019 penyebab kematian ibu terbanyak adalah perdarahan (1.280 kasus), HDK (1.066 kasus), infeksi (207 kasus). Preeklampsia (PE) adalah sindrom pada kehamilan yang dapat mempengaruhi semua sistem organ dan terdiagnosis setelah kehamilan 20 minggu. Gejala dan tanda klinis dari PE mencakup tekanan darah tinggi, protein urin, oedema, sakit kepala, pandangan kabur, dan peningkatan berat badan yang mendadak. Preeklampsia secara klinis ditandai dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg yang diukur dua kali dengan interval waktu 4 jam, proteinuria ≥ 300 mg/24 jam, perbandingan protein-kreatinin didapat $> 0,3$ atau pembacaan dipstik urin $+1$.

Preeklampsia merupakan penyakit dengan berbagai teori (*disease of theory*) yang menggambarkan ketidakpastian patofisiologi dan penyebabnya. Salah satu konsep yang dikemukakan yang dapat diterima secara luas adalah teori “kelainan dua tahap”. Kelainan tahap satu ditandai dengan kegagalan proses remodeling vaskular arteri spiralis, sehingga terjadi vasokonstriksi dari lumen arteri spiralis yang mengakibatkan hambatan aliran darah uteroplasenta sehingga terjadi hipoksia dan iskemia plasenta. Sehingga hal ini lebih lanjut menyebabkan kelainan tahap dua yakni pelepasan faktor plasenta kedalam sirkulasi maternal yang akan memicu respon inflamasi dan aktivasi endotel sistemik. Keadaan hipoksia dan iskemia memicu pembentukan radikal bebas yang merupakan tanda terjadinya stress oksidatif.

Diet maternal diduga berperan dalam etiologi preeklampsia termasuk salah satunya asam lemak tidak jenuh rantai panjang. Asam lemak tersebut dapat berupa omega-3 dan omega-6 yang dikonversikan menjadi AA dan DHA di dalam tubuh manusia. AA (Asam Arakhidonat) dan DHA (Docosahexaenoic Acid) merupakan

komponen penting dari fosfolipid membrane yang berperan dalam meregulasi fungsi membrane sel dan dapat mencegah preeklampsia dengan memodulasi inflamasi dan fungsi vaskular yaitu mengurangi kadar tromboksan (TXA₂) dan meningkatkan prostasiklin (PGI₂) pada tubuh maternal.

Penelitian yang dilakukan Kemse *et al* suplementasi asam lemak omega-3 bermanfaat dalam mengurangi peradangan dan meningkatkan angiogenesis pada tikus hamil model hipertensi. Studi lebih lanjut perlu diterapkan pada manusia agar dapat menguji kemampuan dalam mengurangi resiko perkembangan hipertensi kehamilan. Sementara itu, hasil meta-analisis dari Chen *et al* menunjukkan bahwa suplementasi minyak ikan selama kehamilan trimester kedua dan ketiga tidak terkait dengan penurunan resiko gestasional diabetes mellitus (GDM), pregnancy induced hypertension (PIH), dan PE. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi manfaat potensial lainnya dari suplementasi minyak ikan pada ibu hamil dan bayi.

Ikan kembung (*Rastrelliger*) merupakan salah satu jenis ikan banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas karena ikan kembung banyak mengandung zat gizi diantaranya kalori, protein, lemak, kalsium, besi, fosfor, vitamin, air, serta Omega 3 dan Omega 6 yang baik bagi pencegahan penyakit dan kecerdasan otak.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah subjek penelitian yang berupa nugget ikan kembung yang merupakan salah satu makanan siap saji yang mudah diolah dan bisa tahan lama (dalam penyimpanan yang tepat/frozen food). Sehingga subjek penelitian bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh nugget ikan kembung (*Rastrelliger*) terhadap penurunan resiko pre eklamsia pada tikus putih (*rattus novergicus*).

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis pengaruh nugget ikan kembung terhadap penurunan resiko pre eklamsia pada tikus putih (*rattus novergicus*).

D. Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorik yang menggunakan rancangan acak lengkap dengan menggunakan pola *pre test post test control group design*. Dalam desain ini terdapat empat kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal, adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda signifikan.

Tabel 9.1 Desain Penelitian Eksperimen

		Pre test	Perlakuan	Post Test
R1	————→	O ₁₁	-	O ₂₁
R2	————→	O ₁₂	X	O ₂₂
R3	————→	O ₁₃	X	O ₂₃
R4	————→	O ₁₄	X	O ₂₄

Keterangan:

R1 : Kelompok kontrol

R2 : Kelompok perlakuan placebo (nugget tanpa ikan kembung)

R3 : Kelompok perlakuan 10 gram nugget ikan kembung

R4 : Kelompok perlakuan 15 gram nugget ikan kembung

O₁₁: Tekanan darah sebelum perlakuan pada kelompok kontrol

O₁₂: Tekanan darah sebelum perlakuan pada kelompok perlakuan placebo (nugget tanpa ikan kembung)

O₁₃: Tekanan darah sebelum perlakuan pada kelompok perlakuan 10 gram nugget ikan kembung

O₁₄: Tekanan darah sebelum perlakuan pada kelompok perlakuan 15 gram nugget ikan kembung

O₂₁: Tekanan darah sebelum perlakuan pada kelompok kontrol

O₂₂: Tekanan darah sebelum perlakuan pada kelompok perlakuan placebo (nugget tanpa ikan kembung)

O₂₃: Tekanan darah sebelum perlakuan pada kelompok perlakuan 10 gram nugget ikan kembung

O₂₄: Tekanan darah sebelum perlakuan pada kelompok perlakuan 15 gram nugget ikan kembung

X : Pemberian perlakuan

E. Nugget Ikan Kembung

Jenis ikan kembung di Indonesia diantaranya, ikan kembung perempuan (*Rastrelliger brachysoma* dan *R.neglectus*) serta ikan kembung lelaki (*Rastrelliger kanagurta*). Ikan dengan nama lain indian mackerel ini sangat populer dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan berbagai metode pengolahan.

Ikan kembung dikenal sebagai mackarel fish yang termasuk ikan ekonomis penting dan potensi tangkapannya naik tiap tahunnya. Ikan ini memiliki rasa cukup enak dan gurih sehingga banyak digemari oleh masyarakat. Komposisi gizi ikan kembung cukup tinggi, yakni setiap 100 gram daging ikan kembung mengandung air 76%, protein 22 g, lemak 1 g, kalsium 20 mg, pospor 200 mg, besi 1 g, vitamin A 30 SI dan vitamin B1 0,05 mg. Kandungan AA 3,17 %, DHA 10,62 % dan EPA 4,85 %.

Tabel 9.2 Kandungan Ikan Kembung per 100 gram

No.	Unsur Gizi	Jumlah	Satuan
1.	Kalori	103	Kal
2.	Protein	22	G
3.	Lemak	1	G
4.	Kalsium	20	Mg
5.	Besi	1,5	Mg
6.	Fosfor	200	Mg
7.	Vitamin A	30	Si
8.	Vitamin B1	0,05	Mg
9.	Air	76	G

Pemanfaatan ikan kembung menjadi produk bernilai tambah masih terbatas. Hal ini terkait dengan tingginya kandungan lemak pada ikan kembung. Asam lemak esensial disebut juga dengan asam lemak tidak jenuh ganda. Ada 2 jenis asam lemak tidak jenuh ganda yaitu asam lemak omega-3 dan asam lemak omega-6¹¹.

Ikan kembung mempunyai komposisi kimia yang menguntungkan, yaitu mengandung kadar protein tinggi dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak omega-3 merupakan salah satu asam lemak tidak jenuh yang tidak dapat dirubah menjadi kholesterol di dalam tubuh, sehingga omega-3 menurunkan kadar kolesterol darah¹⁰

Pengolahan ikan kembung menjadi nugget dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ikan kembung berdaging amis dan mudah busuk. Untuk alasan tersebut dibuatlah produk berupa nugget ikan kembung yang praktis, mengurangi bau amis dan disimpan dalam bentuk *frozeen food* yang bisa bertahan lama. Nugget dibuat dengan mencampur ikan kembung dengan sedikit tepung dan telur sebagai bahan dasar.

F. Tikus Putih (*Rattus Novergicus*)

Penggunaan hewan percobaan pada penelitian kesehatan banyak dilakukan untuk uji kelayakan atau keamanan suatu bahan obat dan juga untuk penelitian yang berkaitan dengan suatu penyakit. Tikus putih (*Rattus norvegicus*) banyak digunakan sebagai hewan percobaan pada berbagai penelitian. Tikus digunakan sebagai salah satu hewan coba dalam penelitian kesehatan dikarenakan tikus mempunyai struktur organ yang mirip dengan manusia. Jenis tikus yang biasa digunakan dalam penelitian adalah tikus putih besar (*Rat*) dari spesies *Rattus norvegicus*. Tikus telah digunakan sebagai model hewan yang penting untuk penelitian di bidang psikologi, kedokteran dan bidang lainnya.

Tikus putih memiliki beberapa sifat yang menguntungkan sebagai hewan uji penelitian diantaranya perkembangbiakan cepat, memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan mencit, mudah dipelihara dalam jumlah yang banyak. Tikus putih memiliki ciri-ciri seperti berkepala kecil, albino, ekor yang lebih panjang

dibanding badannya, pertumbuhannya cepat, kemampuan laktasi tinggi, tempramennya baik dan tahan terhadap arsenik tiroksid.

G. Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK)

1. Definisi HDK

Hipertensi pada kehamilan sering terjadi dan merupakan penyebab utama kematian ibu melahirkan, serta memiliki efek serius lainnya saat melahirkan. Hipertensi pada kehamilan terjadi pada 5% dari semua kehamilan (Karthikeyan, 2015). Di Amerika Serikat angka kejadian kehamilan dengan hipertensi mencapai 2 6-10 %, dimana terdapat 4 juta wanita hamil dan diperkirakan 240.000 disertai hipertensi setiap tahun. Hipertensi merupakan faktor risiko stroke dan insidennya meningkat pada kehamilan dimana 15% kematian ibu hamil di Amerika disebabkan oleh pendarahan intraserebral (Malha et al., 2018). Kondisi ini memerlukan strategi manajemen khusus agar hasilnya lebih bagus. Hipertensi pada kehamilan mempengaruhi ibu dan janin, dan dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu dan janin jika tidak dikelola dengan baik (Karthikeyan, 2015). Hipertensi yang diinduksi kehamilan dianggap sebagai komplikasi obstetrik. Ada efek maternal merugikan yang signifikan, beberapa menghasilkan morbiditas atau kematian maternal yang serius. Namun, harus diingat bahwa kondisi ibu dengan abrupcio plasenta, gagal ginjal akut, pendarahan intraserebral dan edema paru akan memiliki efek buruk pada janin. Demi untuk keselamatan ibu perlu rencana untuk melahirkan janin lebih awal. Kelahiran dini ini akan menyelamatkan ibu namun meningkatkan risiko pada bayi. Kesulitan dokter kandungan adalah memutuskan apakah melanjutkan kehamilan atau segera melahirkan (Coutts, 2007). Hipertensi yang diinduksi kehamilan memiliki risiko lebih besar mengalami persalinan premature, IUGR (intrauterine growth retardation), kesakitan dan kematian, gagal ginjal akut, gagal hati akut, pendarahan saat dan setelah persalinan, HELLP (hemolysis elevated liver enzymes and low platelet count), DIC (disseminated intravascular coagulation), pendarahan otak dan kejang (Khosravi et al., 2014; Mudjari and Samsu, 2015). Oleh karena itulah dokter obsetri dalam penatalaksanaan hipertensi pada kehamilan harus melibatkan internis, kardiologis dan nefrologis terutama apabila dijumpai kelainan target organ atau didapatkan hipertensi akselerasi (Malha et al., 2018).

2. Dampak HDK

Peningkatan tekanan darah yang tidak terlalu tinggi (*high normal / prehipertensi*) telah terbukti meningkatkan insiden penyakit kardiovaskular. Insiden penyakit kardiovaskular selama 10 tahun pada mereka yang tekanan darahnya prehipertensi adalah 8% pada laki-laki dan 4% pada perempuan. Sehingga disimpulkan bahwa semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi pula angka kejadian kelainan kardiovaskular (Nadar, 2015). JNC 7 juga melaporkan

bahwa peningkatan tekanan darah sistolik 20 mmHg atau diastolik 10 mmHg akan meningkatkan risiko kejadian penyakit kardiovaskular dua kali lipat (Nadar, 2015; Burt et al., 1995). Sebaliknya penurunan tekanan diastolik 2 mmHg dapat menurunkan penyakit jantung koroner, stroke dan 4 transient ischemic attack (TIA) sebesar 6% (Vassan et al., 2001). Tetapi apabila tekanan darah diastolik diturunkan hingga < 70 mmHg dapat meningkatkan angka mortalitas (Kimm et al., 2018; Vidal-Petiot et al., 2016; Tringali et al., 2013). Konsekuensi hipertensi pada kehamilan (Mustafa et al., 2012; Malha et al., 2018) :

- a) Jangka pendek Ibu : eklampsia, hemoragik, isemik stroke, kerusakan hati (HELL sindrom, gagal hati, disfungsi ginjal, persalinan cesar, persalinan dini, dan abruptio plasenta. Janin : kelahiran preterm, induksi kelahiran, gangguan pertumbuhan janin, sindrom pernapasan, kematian janin.
- b) Jangka panjang Wanita yang mengalami hipertensi saat hamil memiliki risiko kembali mengalami hipertensi pada kehamilan berikutnya, juga dapat menimbulkan komplikasi kardiovaskular, penyakit ginjal dan timbulnya kanker. Hipertensi pada kehamilan dapat berkembang menjadi pre-eklampsia, eklampsia dan sindrom HELLP. Kemudian dapat bermanifestasi dengan kejadian serebral iskemik atau hemoragik pada pra, peri, dan postpartum menjadi penyakit stroke. Gejala pre-eklampsia/eklampsia adalah sakit kepala, gangguan penglihatan (kabur atau kebutaan) dan kejang. Hal ini dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian bagi ibu dan janin bila tidak segera dilakukan penanganan (Vidal et al., 2011).

3. Klasifikasi HDK

Hipertensi pada kehamilan apabila tekanan darahnya $\geq 140/90$ mmHg. Dibagi menjadi ringan-sedang ($140 - 159 / 90 - 109$ mmHg) dan berat ($\geq 160/110$ mmHg) (Malha et al., 2018).

Terdapat beberapa jenis hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama adalah hipertensi gestasional. Hipertensi ini adalah tipe yang paling ringan, biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu, tanpa ditemukan adanya protein pada urin. Yang kedua adalah preeklampsia. Preeklampsia adalah bentuk hipertensi kehamilan yang lebih berat daripada hipertensi gestasional. Preeklampsia ditandai dengan tekanan darah yang tinggi disertai adanya protein pada pemeriksaan urin. Preeklampsia dikelompokkan menjadi preeklampsia ringan dan berat, tergantung pada tekanan darah sistolik dan diastoliknya. Yang ketiga adalah eklampsia. Eklampsia adalah tipe hipertensi dalam kehamilan yang paling berat. Eklampsia ditandai dengan adanya hipertensi, protein pada pemeriksaan urin, dan disertai adanya kejang. Dan yang keempat adalah hipertensi kronis yang diperberat dengan kehamilan. Tipe ini biasanya ditemukan pada ibu hamil dengan riwayat tekanan darah tinggi sebelum kehamilan.

a. Hipertensi gestasional

Hipertensi gestasional adalah hipertensi yang terjadi setelah 20 minggu kehamilan tanpa proteinuria. Angka kejadiannya sebesar 6%. Sebagian wanita (> 25%) berkembang menjadi pre-eklampsia diagnosis hipertensi gestasional biasanya diketahui setelah melahirkan (Leslie and Collins, 2016; Malha et al., 2018). Hipertensi gestasional berat adalah kondisi peningkatan tekanan darah > 160/110 mmHg. Tekanan darah baru menjadi normal pada post partum, biasanya dalam sepuluh hari. Pasien mungkin mengalami sakit kepala, penglihatan kabur, dan sakit perut dan tes laboratorium abnormal, termasuk jumlah trombosit rendah dan tes fungsi hati abnormal (Karthikeyan, 2015). Hipertensi gestasional terjadi setelah 20 minggu kehamilan tanpa adanya proteinuria. Kelahiran dapat berjalan normal walaupun tekanan darahnya tinggi. Penyebabnya belum jelas, tetapi merupakan indikasi terbentuknya hipertensi kronis di masa depan sehingga perlu diawasi dan dilakukan tindakan pencegahan (Roberts et al., 2013).

b. Preeklampsia

Pre-eklampsia adalah sindrom pada kehamilan (>20 minggu), hipertensi ($\geq 140/90$ mmHg) dan proteinuria ($>0,3$ g/hari). Terjadi pada 2-5% kehamilan dan angka kematian ibu 12-15% (Malha et al., 2018).

Pre-eklampsia juga dapat disertai gejala sakit kepala, perubahan visual, nyeri epigastrium, dan dyspnoea. Beberapa faktor telah diidentifikasi terkait dengan peningkatan risiko pre-eklampsia seperti usia, paritas, pre-eklampsia sebelumnya, riwayat keluarga, kehamilan ganda, kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (diabetes mellitus tipe I), obesitas dan resistensi insulin, hipertensi kronis, penyakit ginjal, penyakit autoimun, sindrom anti-fosfolipid, penyakit rematik), merokok, peningkatan indeks massa tubuh (BMI), peningkatan tekanan darah, dan proteinuria. Selain itu, beberapa faktor yang terkait termasuk keterpaparan sperma yang terbatas, primipaternitas, kehamilan setelah inseminasi donor / sumbangan oosit / embrio telah ditemukan memainkan peran penting pada kejadian pre- eklampsia/eklampsia (Karthikeyan, 2015).

Faktor risiko pre-eklampsia/eklampsia adalah hipertensi kronis, obesitas, dan anemia parah (Bilano et al., 2014). Faktor risiko utama pre-eklampsia adalah sindrom antifosfolipid, relative risk, pre-eklampsia sebelumnya, diabetes tipe I, kehamilan ganda, belum pernah melahirkan (nulliparity), sejarah keluarga, obesitas, usia >40 tahun, hipertensi (English et al., 2015). Sindrom antibodi antifosfolipid, pre-eklampsia sebelumnya, hipertensi kronik, diabetes tipe I, teknologi pembantu reproduksi dan BMI (body mass index) sangat berkaitan erat dengan terjadinya pre-eklampsia (Bartsch et al., 2016).

Tabel 9.3. Faktor risiko timbulnya pre-eklampsia (Lesli and Collins, 2016)

Faktor risiko tinggi	Faktor risiko menengah
Hipertensi pada kehamilan sebelumnya	Kehamilan pertama
Penyakit ginjal kronik	Usia ≥ 40 tahun
Penyakit autoimmune (sindrom antifosfolipid)	Interval kehamilan ≥ 10 tahun
Diabetes mellitus tipe I / II	Sejarah keluarga
Hipertensi kronis	Kehamilan berganda

Patofisiologi pre-eklampsia (Leeman et al., 2016)

- Implantasi plasenta abnormal (cacat pada trofoblas dan spiral arteriol)
- Faktor angiogenik (faktor rendahnya pertumbuhan plasental)
- Predisposisi genetik (ibu, ayah, trombofilias)
- Fenomena imunologi
- Kerusakan endotelial vaskular dan stres oksidatif
- Fitur pre-eklampsia berat (Leeman et al., 2016)
- Peningkatan tekanan darah (sistolik ≥ 160 mmHg, diastolik ≥ 110 mmHg)
- Peningkatan kreatinin (> 1.1 mg/dL [$97 \mu\text{mol/L}$] atau $\geq 2x$ normal)
- Disfungsi hati (transamilase $\geq 2x$ normal atas) atau nyeri pada tubuh bagian atas
- Sakit kepala atau penglihatan kabur
- Trombosit $< 100 \times 10^3/\mu\text{L}$ ($100 \times 10^9/\text{L}$)
- Edema paru

Tabel 9.4 Penanganan Pre-eklampsia pada kehamilan (NICE, 2011)

Degree of hypertension	Mild hypertension (140/90 to 149/99 mmHg)	Moderate hypertension (150/100 to 159/109 mmHg)	Severe hypertension (160/110 mmHg or higher)
Admit to hospital	Yes	Yes	Yes
Treat	No	With oral labetalol [†] as first-line treatment to keep: • diastolic blood pressure between 80–100 mmHg • systolic blood pressure less than 150 mmHg	With oral labetalol [†] as first-line treatment to keep: • diastolic blood pressure between 80–100 mmHg • systolic blood pressure less than 150 mmHg
Measure blood pressure	At least four times a day	At least four times a day	More than four times a day, depending on clinical circumstances
Test for proteinuria	Do not repeat quantification of proteinuria	Do not repeat quantification of proteinuria	Do not repeat quantification of proteinuria
Blood tests	Monitor using the following tests twice a week: kidney function, electrolytes, full blood count, transaminases, bilirubin	Monitor using the following tests three times a week: kidney function, electrolytes, full blood count, transaminases, bilirubin	Monitor using the following tests three times a week: kidney function, electrolytes, full blood count, transaminases, bilirubin

c. Eklamsia

Eklampsia adalah terjadinya kejang pada wanita dengan pre-eklampsia yang tidak dapat dikaitkan dengan penyebab lainnya (Karthikeyan, 2015). Eklampsia keadaan darurat yang dapat mengancam jiwa, terjadi pada sebelum, saat, dan setelah persalinan (antepartum, intrapartum, postpartum). Eklampsia didahului dengan sakit kepala dan perubahan penglihatan, kemudian kejang selama 60-90 detik (Leeman et al., 2016).

Prinsip manajemen kejang eklampsia (Leeman et al., 2016)

- 1) Menjaga kesadaran
- 2) Menghindari polifarmasi
- 3) Melindungi jalur nafas dan meminimalkan risiko aspirasi
- 4) Mencegah cedera pada ibu hamil
- 5) Pemberian magnesium sulfat untuk mengontrol kejang
- 6) Mengikuti proses kelahiran normal

d. Hipertensi kronis

Hipertensi kronis pada kehamilan apabila tekanan darahnya $\geq 140/90$ mmHg, terjadi sebelum kehamilan atau ditemukan sebelum 20 minggu kehamilan. Seringkali merupakan hipertensi esensial / primer, dan didapatkan pada 3,6-9% kehamilan (Malha et al., 2018). Hipertensi kronis pada kehamilan adalah hipertensi ($\geq 140/90$ mmHg) yang telah ada sebelum kehamilan. Dapat juga didiagnosis sebelum minggu ke-20 kehamilan. Ataupun yang terdiagnosis untuk pertama kalinya selama kehamilan dan berlanjut ke periode post-partum (Karthikeyan, 2015).

Peningkatan tekanan darah pada hipertensi kronis terjadi sebelum minggu ke-20 kehamilan, dapat bertahan lama sampai lebih dari 12 minggu pasca persalinan (Leeman et al., 2016). Hipertensi, obesitas dan usia merupakan faktor risiko hipertensi kronis. Hipertensi kronis pada kehamilan meningkatkan risiko pre-eklampsia, pertumbuhan janin, persalinan dini, dan kelahiran dengan cesar (Seely and Ecker, 2014).

Wanita hipertensi yang hamil memiliki kecenderungan mengalami pre-eklampsia, eklampsia, sindroma HELLP, detachment plasenta, gagal hati, gagal ginjal dan sesak nafas karena cairan pada paru (Cluver et al., 2017). Hipertensi kronis pada kehamilan umumnya berasal dari hipertensi esensial terlihat dari riwayat keluarganya. Tetapi bisa juga berasal dari kelainan ginjal parenkim, hiperplasia fibromuskular atau hiperaldosteronisme hanya saja kasusnya jarang (Tranquilli et al., 2014).

Tabel 9.5 Penyebab hipertensi kronis pada kehamilan (Sibai and Chames, 2008)

Primary (90%)	Secondary (10%)			
	Renal diseases	Collagen vascular diseases	Endocrine diseases	Vascular disease
Essential hypertension	Renovascular disease	Lupus Erythematosus	Diabetes	Aortic coarctation
	Interstitial nephritis		Hyperthyroidism	
	Nephropathy	Scleroderma	Cushing syndrome	
	Glomerulonephritis		Hyperaldosteronism	
	Renal transplant	Periarthritis Nodosa	Pheochromocytoma	Vasculitis
	Polycystic kidney disease			

Hipertensi kronis berat (SBP $\geq$ 180 mmHg dan atau DBP $\geq$ 110 mmHg akan disertai dengan penyakit ginjal, kardiomiopati, koarktasi aorta, retinopati, diabetes (B sampai F), kolagen vaskular, sindrom antibodi antifosfolipid, pre- eklampsia. Wanita hamil dengan hipertensi kronis berat memiliki risiko tinggi terkena stroke, serbral hemorag, hipertensi ensefalopati, pre-eklampsia, serangan jantung, gagal ginjal akut, abruptio plasenta, koagulopati intravaskular diseminata dan kematian (Sibai and Chames, 2008)

Tabel 9.6 Perbedaan Hipertensi kronis, hipertensi gestasional dan pre-eklampsia/eklampsia pada kehamilan (Karthikeyan, 2015)

Temuan	Hipertensi kronis	Hipertensi gestasional	Pre-eklampsia atau eklampsia
Waktu onset	<20 minggu	Pertengahan kehamilan	$\geq$ 20 minggu
Proteinuria	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Hemokonsentrasi	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Trombositopenia	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Disfungsi hati	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Kreatinin serum >1.2 mg/dL	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Peningkatan asam urat serum	Tidak ada	Tidak ada	Ada
Gejala klinik	Tidak ada	Tidak ada	Ada

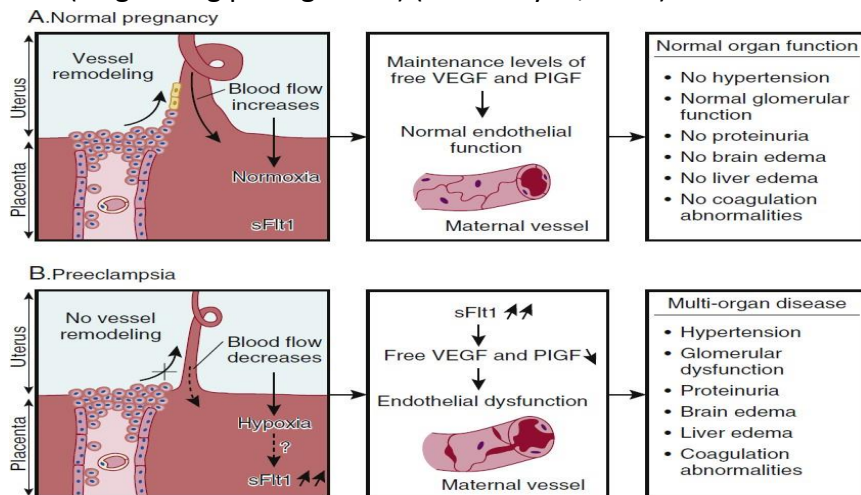
Tabel 9.7 Faktor risiko yang berkaitan dengan pre-eklampsia (Lowe et al., 2014)

Risk Factor	Unadjusted Relative Risk [95% CI]
Nulliparity	2.9 [1.3-6.6]
Multiple pregnancy	2.9 [1.3-6.6]
Previous history of preeclampsia	7.2 [5.9-8.8]
Family history of preeclampsia	2.9 [1.7-4.9]
Overweight BMI 25-29.9*	1.7 [1.2-2.4]
Obese BMI $\geq$ 30*	2.7 [1.7-4.4]
Age $\geq$ 40	2.0 [1.3-2.9]
Systolic BP >130mmHg before 20 weeks	2.4 [1.8-3.2]
Diastolic BP >80mmHg before 20 weeks	1.4 [1.0-1.9]
Antiphospholipid syndrome	9.7 [4.3-21.8]
Pre-existing diabetes	3.6 [2.5-5]
Other risk factors	Underlying renal disease Chronic autoimmune disease Interpregnancy interval >10 years

4. Patofisiologi dan Faktor-Faktor Penyebab HDK

Pre-eklampsia/eklampsia dapat terjadi karena faktor genetik. Bila seseorang memiliki riwayat keluarga pre-eklampsia/eklampsia maka dia mempunyai risiko lebih besar mengalami pre-eklampsia/eklampsia saat kehamilan (Ward and Lindheimer, 2009).

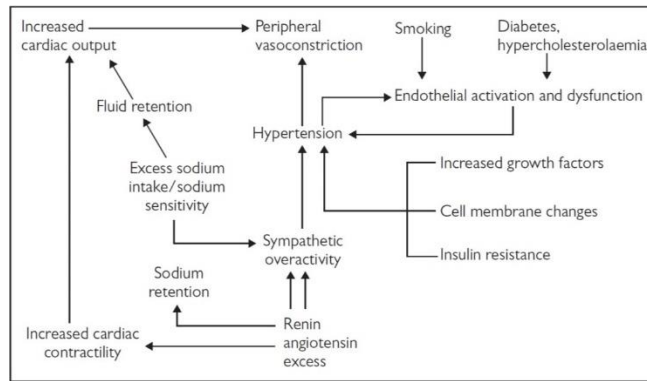
Pre-eklampsia disebabkan oleh adanya plasenta atau respons ibu terhadap plasenta. Plasenta yang buruk adalah faktor predisposisi kuat yang mempengaruhi ibu, terkait dengan sinyal inflamasi (tergantung pada gen janin) dan juga sifat respons ibu (tergantung pada gen ibu) (Karthikeyan, 2015).



Gambar 9.1 Hipotesis Patologi Pre-eklampsia (Malha et al., 2018)

Pada kehamilan normal, arteri spiral uteri invasif ke dalam trofoblas, menyebabkan peningkatan aliran darah dengan lancar untuk kebutuhan oksigen dan nutrisi janin. Pada pre-eklampsia, terjadi gangguan sehingga aliran darah tidak lancar dan terjadi gangguan pada plasenta. Peningkatan sFlt1 (lihat Gambar) menyebabkan plasenta memproduksi free vascular endothelial growth factor (VEGF) dan penurunan placental growth factor (PlGF). Selanjutnya menyebabkan disfungsi endotel pada pembuluh ibu mengakibatkan penyakit multiorgan : hypertension, glomerular dysfunction, proteinuria, brain edema, liver edema, coagulation abnormalities (Malha et al, 2018).

Terdapat dua teori pre-eklampsia, vaskular (iskemia-reperfusion yang menghasilkan stres oksidatif dan penyakit vaskular) dan kekebalan tubuh (maladaptasi kekebalan ibu-ayah, yaitu reaksi alloimun maternal yang dipicu oleh penolakan terhadap allograft janin) yang dicurigai bertanggung jawab terhadap pre-eklampsia. Etio-patofisiologi pre-eklampsia sangat kompleks dan melibatkan beragam faktor seperti predisposisi genetik, gangguan pada renin-angiotensin-aldosteron, disfungsi endotelium ibu, koagulopati maternal, sitokin, faktor pertumbuhan, dan sebagainya (Karthikeyan, 2015).



Gambar 9.2. Patologi Hipertensi Secara Umum (Nadar, 2015)

H. Pembahasan

Analisa Univariat

Tekanan Darah Pre dan Post

Tabel 9.8

NO	KELOMPOK	PRE		POST	
		Normal	Hipertensi	Normal	Hipertensi
1	Kontrol	100 %	0 %	100 %	0 %
2	Perlakuan Nugget ikan kembung 10 gram	0 %	100 %	100 %	0 %
3	Perlakuan Nugget ikan kembung 15 gram	0 %	100 %	100 %	0 %
4	Perlakuan dengan Placebo (Nugget tanpa ikan kembung)	100 %	0 %	0 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas kelompok kontrol di pre test dan post test dalam keadaan normal, bertolak belakang dengan kelompok perlakuan plasebo yang awalnya normal pada saat post test mengalami hipertensi. Sedangkan kelompok perlakuan nugget ikan kembung 10 dan 15 gram mengalami hipertensi di pre tes dan normal di post tes.

Tabel 9.9

NO	KELOMPOK	PRE				POST			
		Min	Max	Mean	SD	Min	Max	Mean	SD
1	Kontrol	87	98	90,14	3,67	98	101	99,43	0,97
2	Perlakuan Nugget ikan kembung 10 gram	179	189	182,29	3,77	110	120	113,71	4,53
3	Perlakuan Nugget ikan kembung 15 gram	177	190	113,71	5,47	100	110	106,43	3,64
4	Perlakuan dengan Placebo (Nugget tanpa ikan kembung)	100	110	106,43	3,64	180	189	186,14	3,24

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata tekanan darah saat pre test normal yaitu kelompok kontrol dan perlakuan placebo, sedangkan kelompok perlakuan nugeet ikan kembung mengalami hipertensi. Rata-rata tekanan darah post test yang masih mengalami hipertensi adalah kelompok perlakuan plasebdangkan kelompok lain mengalami penurunan ke arah normal.

Uji Normalitas

Tabel 9.10

NO	KELOMPOK	p-value
PRE		
1	Kontrol	0,10
2	Perlakuan placebo	0,54
3	Perlakuan 10 gram	0,143
4	Perlakuan 15 gram	0,54
POST		
1	Kontrol	0,609
2	Perlakuan placebo	0,195
3	Perlakuan 10 gram	0,2
4	Perlakuan 15 gram	0,334

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji shapiro wilk menunjukkan bahwa p-value >0,05 sehingga data terdistribusi normal.

Tabel 9.11

NO	KELOMPOK	p-value
1	PRE	0,00
2	POST	0,00

Berdasarkan tabel di atas Uji levene pvalue $0,527 > 0,05$ maka ada perbedaan, maka lanjut one way anova. Hasil one way anova p-value $< 0,05$ maka ada perbedaan signifikan.

Uji Lanjutan

Tabel 9.12

NO	KELOMPOK	p-value
	PRE	
1	Kontrol	90,14
2	Perlakuan palcebo	182,28
3	Perlakuan 10 gram	182,28
4	Perlakuan 15 gram	182,28
	POST	
1	Kontrol	99,42
2	Perlakuan palcebo	106,43
3	Perlakuan 10 gram	113,71
4	Perlakuan 15 gram	186,14

Berdasarkan tabel di atas, Homogenitas p-value tidak sama sehingga post Hoc menggunakan Games Houq.

Analisa Bivariat

Pengaruh Nugget Ikan Kembung terhadap Resiko Pre Eklamsi (Post Hoc Test)

Tabel 9.13

NO	PEMBANDING	KELOMPOK	p-value
1	PRE		
	Kontrol	Perlakuan placebo	0,000
		Perlakuan 10 gram	0,000
		Perlakuan 15 gram	0,000
	Perlakuan placebo	Kontrol	0,000
		Perlakuan 10 gram	0,989
		Perlakuan 15 gram	1,000
	Perlakuan 10 gram	Kontrol	0,000
		Perlakuan placebo	0,989
		Perlakuan 15 gram	0,989
	Perlakuan 15 gram	Kontrol	0,000
		Perlakuan placebo	1,000
		Perlakuan 10 gram	0,989
2	POST		
	Kontrol	Perlakuan placebo	0,000
		Perlakuan 10 gram	0,000
		Perlakuan 15 gram	0,004
	Perlakuan placebo	Kontrol	0,000
		Perlakuan 10 gram	0,000
		Perlakuan 15 gram	0,000
	Perlakuan 10 gram	Kontrol	0,000
		Perlakuan placebo	0,000
		Perlakuan 15 gram	0,002
	Perlakuan 15 gram	Kontrol	0,004
		Perlakuan placebo	0,000
		Perlakuan 10 gram	0,002

Tabel diatas menunjukkan hasil uji perbedaan pengaruh antara kelompok sebelum dan setelah diberikan nugget ikan kembung. Hasil uji beda antar kelompok menunjukkan nilai $p > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penurunan resiko pre eklamsia sebelum dan sesudah pemberian nugget ikan kembung.

Tabel 9.14

Paired T Test		
Resiko Stunting	Nilai p	Perbedaan rerata (IK 95%)
Pre	0,000	0,42
Post		

Tabel diatas menunjukkan hasil uji pengaruh antara kelompok sebelum dan setelah pemberian nugget ikan kembung. Berdasarkan nilai sig. levene's test for equality of variances adalah sebesar $0,232 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa varians data antara kelompok sebelum dan sesudah adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output independent sample t test berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variances assumed. Berdasarkan tabel equal variances assumed diketahui nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji paired t test dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara kelompok sebelum dilakukan dan sesudah diberikan nugget ikan kembung.

I. Pembahasan

Pengaruh Pemberian Nugget Ikan Kembung terhadap Penurunan Resiko Pre Eklamsi

Hasil data distribusi frekuensi menunjukkan data bahwa terdapat penurunan tekanan darah pada kelompok perlakuan pemberian nugget ikan kembung 10 gram dan 15 gram, sedangkan pada kelompok kontrol dan placebo terdapat peningkatan tekanan darah, berdasarkan uji anova didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian nugget ikan kembung. Berdasarkan uji paired T test didapatkan ada pengaruh pemberian nugget ikan kembung terhadap penurunan resiko pre eklamsi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kemse *et al* suplementasi asam lemak omega-3 bermanfaat dalam mengurangi peradangan dan meningkatkan angiogenesis pada tikus hamil model hipertensi. Studi lebih lanjut perlu diterapkan pada manusia agar dapat menguji kemampuan dalam mengurangi resiko perkembangan hipertensi kehamilan. Sementara itu, hasil meta-analisis dari Chen *et al* menunjukan bahwa suplementasi minyak ikan selama kehamilan trimester kedua dan ketiga tidak terkait dengan penurunan resiko gestasional diabetes mellitus

(GDM), pregnancy induced hypertension (PIH), dan PE. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi manfaat potensial lainnya dari suplementasi minyak ikan pada ibu hamil dan bayi.

J. Simpulan

Terdapat perbedaan dan pengaruh pemberian nugget ikan kembung terhadap penurunan resiko pre eklamsi pada tikus putih (*rattus novergicus*)

K. Saran

1. Untuk Institusi Kebidanan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai *Evidence Based Practice*, dalam menurunkan AKI, AKB dan Stunting.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dasar dalam penelitian selanjutnya.

3. Untuk Petugas Kesehatan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk petugas kesehatan dalam hal menurunkan resiko pre eklamsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Almatsier, S, 2006. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Alwasol, et al. 2013. The velocity of fetal growth is associated with the breadth of placental surface, but not with the length. Pub Med Center
- Bartsch, E., Medcalf, K.E., Park, A.L., et al., 2016. Clinical risk factors for pre- eclamsia determined in early pregnancy: systemic review and meta-analysis of large cohort studies. *BMJ*. Vol 353: i1753.
- Belkacemi, L., Nelson, D. M., Desai, M., & Ross, M. G. (2010). Maternal Undernutrition Influences Placental Fetal Development. *Biology of Reproduction*, 331(May), 325–331. <https://doi.org/10.1095/biolreprod.110.084517>
- Bradbury, J. 2011. Docosahexaenoic Acid (DHA): An Ancient Nutrient for The Modern Human Brain. *Nutrients*. 3: 529-54
- Gaccioli, F., & Lager, S. 2016. Placental nutrient transport and intrauterine growth restriction. *Frontiers in Physiology*, 7(FEB), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00040>
- Irmawan, S. 2009. Status Perikanan Ikan Kembung di Kabupaten Barru. Laporan Penelitian. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya Malang.
- aplan, N.M. and Rose, D., 2010. Prehypertension and borderline hypertension. <http://www.uptodate.com/store>.
- Kaplan, N.M., 2015. Primary hypertension: pathogenesis in: Kaplan, N., Rose, B., Bakris, G.L., Sheridan, A.M., Kaplan's Clinical Hypertension, 11th ed Linppincol William & Willkins Phylladelphia. Pp: 50-121.
- Kemenkes RI. 2015. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu Di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Edisi pertama.
- Kuswanti. 2014. *Asuhan Kehamilan*. Yogyakarta: Pusta Pelajar
- Leeman, L., Dresang, L.T., and Fontaine, P., 2016. Hypertensive disorder of pregnancy. *American Family Physicians*. Vol 93 (2): 121-7.
- Malha et al., 2018. Hypertension in Pregnancy in Hypertension: A Companion to Braunwald's Heart Disease (Third Edition) Ch 39. Elsevier.
- Manuba, IBG, Dkk. 2010. Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan Dan KB. Jakarta: EGC
- Murray, 2003. Kadar Hemoglobin. Jakarta : EGC
- Neil, W.R. 2001. Panduan Lengkap Perawatan Kehamilan. Jakarta: Dian Rakyat
- Prawiroharjo, S. 2016. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Bina sPustaka Sarwono.

- Sahena, F., I.S.M. Zaidul, S. Jinap, A.M. Yazid, A. Khatib, N.A.N. Norulaini. 2010. Fatty acid compositions of fish oil extracted from different parts of Indian mackerel (*Rastrelliger kanagurta*) using various techniques of supercritical CO₂ extraction. *Food Chemistry*, 120:879-885.
- Suptijah P. 1999. Studi Aktivitas Asam Lemak Omega-3 Ikan Laut pada Mencit sebagai Hewan Percobaan. Faperikan. IPB. Bogor.
- Sulistyawati, A. 2009. Asuhan Kebidanan Pada Massa Kehamilan. Jakarta: Selemba Medika.
- Wijarnarka, 2007. Asupan Gizi dan Pola Makan. Jakarta : ECG.

BAB 10
STUDI KUALITATIF RESIKO PENULARAN HIV/AIDS
MELALUI PENGGUNAAN TATO
DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA
SEMARANG

Erna Kusumawati, S.ST. M.Kes
Siti Istiana, S.SiT.M.Kes



Nuansa
Fajar
Cemerlang

BAB 10

**STUDI KUALITATIF RESIKO PENULARAN HIV/AIDS
MELALUI PENGGUNAAN TATO
DI KECAMATAN SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG**

Erna Kusumawati, S.ST. M.Kes

Siti Istiana, S.SiT.M.Kes

A. Latar Belakang

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh (limfosit) yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh pada seseorang maka orang tersebut sangat mudah terkena penyakit seperti TBC, kandidiasis, berbagai radang pada kulit, paru, saluran pencernaan, otak dan kanker. (Indonesia, 2008).

Angka kejadian HIV/AIDS dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah HIV/AIDS di Indonesia yang dilaporkan dari 1 Januari sampai dengan 30 September 2013 adalah HIV sejumlah 20.413 kasus, HIV sejumlah 2.763 kasus dan kematian sejumlah 8.553 kasus. Menurut jenis kelamin laki-laki menduduki peringkat pertama yaitu 25.444 orang. Menurut faktor resiko dari heteroseksual sejumlah 27.782.

Menurut laporan dari Kementrian Kesehatan RI, rasio HIV antara laki-laki dan perempuan adalah 1:1. Presentase AIDS pada laki-laki sebanyak 55,4%, dan perempuan 28,8% sementara 15,8% tidak melaporkan

jenis kelamin. (Kementrian RI, 2013).

Kasus di Kota Semarang HIV/AIDS sepanjang 2013 mencapai 396 penderita, sementara temuan AIDS sebanyak 69 penderita, dan lima penderita di antaranya meninggal dunia. (PKBI, 2013). Menurut penuturan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, distribusi penyebaran kasus HIV/AIDS rata-rata tersebar di Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Tengah. (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2012)

Beberapa faktor resiko dari suami, berperan dalam penularan HIV/AIDS. Dengan adanya keadaan suami dengan keadaan bertato, tindik, narkoba terutama pada pengguna narkoba suntik, dan suami dengan keluhan infeksi menular seksual memungkinkan suami tertular HIV/AIDS yang akan berimbas pada penularan kepada pasangannya.

Penggunaan jarum yang tidak steril pada proses pembuatan tato menyebabkan beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan dari proses tato yang tidak steril adalah infeksi HIV AIDS, Hepatitis B atau C, TBC, Mycobacterium, Sifilis, Malaria dan Lepa. Begitu juga pada tindik.

Dari hasil wawancara dengan salah satu istri dari suami bertato di daerah Poncowolo Barat Kelurahan Pendrikan Lor. Bahwa suaminya mendapatkan tato selama di penjara. Menurut penuturan dari ibu tersebut di daerahnya, para laki-laki sebagian besar menggunakan tato. Saat ini suaminya mengeluh gatal-gatal di sekujur tubuhnya dan tidak kunjung sembuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sekunder, keluhan yang dirasakan itu bisa merupakan salah satu tanda gejala HIV/AIDS.

Kecamatan Semarang Tengah membawahi 15 kelurahan yaitu Bangunharjo, Brumbungan, Gabahan, Jagalan, Karangkidul, Kauman, Kembang Sari, Kranggan, Miroto, Pandansari, Pekunden, Pendrikan Kidul, Pendrikan Lor, Purwodinatan, Sekayu.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin meneliti resiko penularan HIV/AIDS melalui tato di Kecamatan Semarang Tengah Semarang. Dimana peneliti ingin mengidentifikasi beberapa factor diantaranya pengetahuan informan tentang HIV/AIDS dan tato, bagaimana persepsi informan tentang resiko kerentanan tertular HIV/AIDS karena tato, persepsi informan tentang keparahan penyakit HIV/AIDS karena tato, persepsi informan tentang kemampuan diri (*self efficacy*) melakukan tato, sumber informasi yang diterima informan mengenai tato hubungannya dengan HIV/AIDS, dukungan sosial (keluarga, teman) untuk melakukan tato, praktek tato yang dilakukan informan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi informan tentang resiko kerentanan tertular HIV/AIDS karena tato, persepsi informan tentang keparahan penyakit HIV/AIDS karena tato, persepsi informan tentang kemampuan diri (*self efficacy*) melakukan tato, sumber informasi yang diterima informan mengenai tato hubungannya dengan HIV/AIDS, dukungan sosial (keluarga, teman) untuk melakukan tato, praktek tato yang dilakukan informan.

C. Tujuan Penelitian

Meneliti resiko penularan HIV/AIDS melalui tato di Kecamatan Semarang Tengah Semarang. Dimana peneliti ingin mengidentifikasi beberapa factor diantaranya pengetahuan informan tentang HIV/AIDS dan tato.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berfokus pada pengalaman, interpretasi serta makna hidup seseorang yang mengalaminya (Moleong, 2007). Penelitian ini menggunakan pengamatan pada latar alamiah atau tak terstruktur. Pada penelitian ini, desain yang digunakan adalah desain grounded theory, dimana peneliti ingin meneliti beberapa individu yang

semuanya telah mengalami aktivitas, interaksi, atau proses dalam satu fenomena sehingga

penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan pandangan berpikir yang menekankan pada fokus kepada pengalaman – pengalaman subyektif dari perilaku orang (Moleong, 2007).

Teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling dimana peneliti menunjuk satu informan yang diyakini mampu memberikan informasi mengenai apa yang diinginkan, setelah itu informan tersebut menunjuk orang lain yang akhirnya dijadikan informan dalam penelitian ini. Sehingga peneliti memperoleh 4 informan utama.

Informan primer adalah mereka yang memergunakan tato minimal lebih dari 2 tahun, terdiri dari jenis kelamin 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sedangkan informan sekunder terdiri dari tenaga kesehatan dan juga seniman tato (tattoo maker/tattoo artist).

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama untuk pengumpulan data kualitatif adalah peneliti sendiri dan instrumen penelitian pendukung meliputi pedoman wawancara mendalam berisi daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Kriteria pertanyaan pedoman wawancara antara lain Persepsi pengetahuan informan tentang HIV/AIDS dan tato, Persepsi informan tentang resiko kerentanan tertular HIV/AIDS karena tato, Persepsi informan tentang keparahan penyakit HIV/AIDS karena tato, Persepsi informan tentang kemampuan diri (self efficacy) melakukan tato, Sumber informasi yang diterima informan mengenai tato dan HIV/AIDS, Dukungan sosial (keluarga, teman) untuk melakukan tato dan Praktek melakukan tato.

Analisa data pada penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan segera setelah data diperoleh dan berlangsung sejak pengambilan data dimulai. Peneliti menggunakan analisa data, menurut model Miles dan Huberman.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Yaitu melakukan wawancara mendalam (*indept interview*) dengan orang yang terdekat dengan informan. Triangulasi akan dilakukan kepada keluarga terdekat, tattoo maker dan tenaga kesehatan terdekat. Pengumpulan data didukung dengan menggunakan alat bantu seperti tape recorder, foto, slide, dan sebagainya. Pada penelitian ini digunakan buku catatan, tape recorder dan camera.

E. HIV/AIDS

1. Pengertian

- a. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus golongan RNA yang spesifik menyerang sistem kekebalan tubuh/imunitas manusia dan menyebabkan AIDS. HIV positif adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV dan tubuh telah membentuk antibodi (zat anti) terhadap virus tersebut
- b. AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome/Sindroma Defisiensi Imun Akut/SIDA*) adalah kumpulan gejala klinis akibat penurunan sistem imun yang timbul akibat infeksi HIV. AIDS sering bermanifestasi dengan munculnya berbagai penyakit infeksi oportunistik, keganasan, gangguan metabolisme dan lainnya (Indonesia, 2008)

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan suatu jenis lentivirus yang termasuk salah satu jenis famili retrovirus. HIV bisa menyebabkan infeksi kronik. Ia juga penyebab penyakit pada hewan tetapi bukan neoplasma. Ia memiliki enzim reverse transkriptase yang unik. Enzim tersebut merupakan turunan dari RNA dan DNA yang mempunyai kemampuan untuk masuk ke dalam kromosom sel host. Virus ini bertahan hidup di dalam sel selama bertahun-tahun dan tidak dapat dimusnahkan dari sel host dengan pemberian obat antivirus.

2. Perjalanan Penyakit

- a. Tahap infeksi primer (*primary infection*) yaitu setelah beberapa minggu dari saat infeksi ditandai dengan gejala umum seperti sakit pada tenggorokan, nyeri otot, sendi, rasa lemah. Terdapat satu masa transisi virus antigenemia yaitu antigen virus tak dapat dideteksi di dalam serum darah pengidap sebelum terbentuknya zat anti terhadap virus HIV. Penyakit muncul dalam kurun waktu 3 bulan setelah infeksi, dengan gejala klinis menyerupai glandular fever like illness dengan ruam, demam, nyeri kepala, malaise, dan limfadenopati luas. Fase ini akan mereda secara spontan dalam 14 hari.
- b. Tahap infeksi dini/infeksi HIV asimtomatis yaitu tahap masa laten virus dan lamanya berlangsung beberapa tahun sampai 5-10 tahun. Biasanya asimtomatik/beberapa dengan pembesaran kelenjar limfe. Komplikasi dermatologis biasa terjadi seperti dermatitis seboroik terutama pada garis rambut/lipatan *nasolabial* dan munculnya atau memburuknya seseorang dengan penyakit *psoriasis*. Pada stadium ini bisa muncul kondisi yang berhubungan dengan aktivasi imunitas seperti *purpura trombositopenia idiopatik*, *polimiositis*, *sindroma Guillain-Barre* dan *Bell's palsy*.
- c. Tahap infeksi menengah yaitu tahap reaktivasi virus HIV dengan munculnya kembali antigen HIV dan turunnya jumlah limfosit T4. Ada juga yang menyebut sebagai fase *AIDS Related Complex* yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan tanda-tanda konstitusional yang menetap sekurang-kurangnya 3 bulan dan hasil laboratorium minimal satu macam tanpa gejala

infeksi oportunistik. Tanda-tanda tersebut meliputi: peningkatan suhu badan 38°C berlangsung terus-menerus, penurunan berat badan sekitar 10% atau lebih, kelelahan sampai hilangnya aktivitas dan keluarnya keringat pada malam hari. Komplikasi dermatologis, oral, dan konstitusional lebih sering terjadi pada fase ini.

- d. Tahap sakit HIV berat (severe HIV atau full blown AIDS) yaitu ditandai oleh infeksi oportunistik dan neoplasma dengan angka kematian yang tinggi dan persisten terhadap terapi. (Nursalam, 2009)
3. Tanda dan Gejala klinis
 - a. Gejala utama/mayor :
 - 1) Demam berkepanjangan lebih dari tiga bulan.
 - 2) Diare kronis lebih dari satu bulan berulang maupun terus-menerus.
 - 3) Penurunan berat badan lebih dari 10% dalam tiga bulan.
 - 4) TBC.
 - b. Gejala minor :
 - 1) Batuk kronis selama lebih dari satu bulan.
 - 2) Infeksi pada mulut dan tenggorokan disebabkan jamur *Candida Albicans*.
 - 3) Pembengkakan kelenjar getah bening yang menetap di seluruh tubuh.
 - 4) Munculnya Herpes toset betulang dan bercak-bercak gatal diseluruh tubuh.
4. Stadium HIV/AIDS
 - a. Stadium pertama : HIV
Infeksi dimulai dengan masuknya HIV dan diikuti terjadinya perubahan serologi ketika antibodi terhadap virus tersebut berubah dari negatif menjadi positif. Rentang waktu sejak HIV masuk ke dalam tubuh sampai tes antibodi terhadap HIV menjadi positif disebut *window period*. Lama *window period* antara satu sampai tiga bulan, bahkan ada yang dapat berlangsung sampai enam bulan.
 - b. Stadium kedua : Asimtomatik (tanpa gejala)
Asimtomatik berarti bahwa di dalam organ tubuh terdapat HIV tetapi tubuh tidak menunjukkan gejala-gejala. Keadaan ini dapat berlangsung merata selama 5-10 tahun. Cairan tubuh pasien HIV/AIDS yang tampak sehat ini sudah dapat menularkan HIV kepada orang lain.
 - c. Stadium ketiga
Pembesaran kelenjar limfe secara menetap dan merata (*Persistent Generalized Lymphadenopathy*), tidak hanya muncul pada satu tempat saja dan berlangsung lebih satu bulan.
 - d. Stadium keempat : AIDS
Keadaan ini disertai adanya bermacam-macam penyakit, antara lain penyakit konstitusional, penyakit syaraf dan penyakit infeksi sekunder

5. Penularan HIV & AIDS

Virus HIV dapat menular melalui enam cara, antara lain:

a. Hubungan seksual dengan pengidap HIV/AIDS

Hubungan seksual secara vagina, anal, dan oral dengan penderita HIV. Selama hubungan seksual berlangsung, air mani cairan vagina dan darah dapat mengenai selaput lendir vagina, enis, dubur, atau mulut sehingga HIV yang terdapat dalam cairan tersebut masuk ke aliran darah. Selama berhubungan juga bisa terjadi lesi mikro pada dinding vagina, dubur dan mulut yang bisa menjadi jalan HIV untuk masuk ke aliran darah pasangan seksual.

b. Ibu pada bayinya

Penularan HIV dari ibu bisa terjadi pada saat kehamilan (*in utero*). Berdasarkan laporan CDC Amerika, prevelensi penularan HIV dari ibu ke bayi adalah 0,01% sampai 0,7%. Menurut PELKESI (1995) bial ibu baru terinfeksi HIV dan belum ada gejala AIDS, kemungkinan bayi terinfeksi sebanyak 20% sampai 35%, sedangkan kalau gejala AIDS sudah jelas pada ibu kemungkinan mencapai 50%. Penularan juga terjadi selama proses persalinan melalui transfusi *feomaternal* atau kontak antara kulit atau membran mukosa bayi dengan darah atau sekresi maternal saat melahirkan. Semakin lama proses melahirkan, semakin besar resiko penularan. Oleh karena itu, lama persalinan bisa dipersingkat dengan operasi *sectio caesaria*. Transmisi lain terjadi selama periode *post partum* melalui ASI. Resiko bayi tertular melalui ASI dari ibu yang positif sekitar 10%.

c. Darah dan produk darah yang tercemar HIV/AIDS

Sangat cepat menularkan HIV karena virus langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh.

d. Pemakaian alat kesehatan yang tidak steril

Alat pemeriksaan kandungan seperti speculum, tenakulum dan alat-alat lain yang menyentuh darah, cairan vagina atau air mani yang terinfeksi HIV dan langsung digunakan untuk orang lain yang tidak terinfeksi bisa menularkan HIV.

e. Alat-alat untuk menoreh kulit

Alat tajam dan runcing seperti jarum, pisau, silet, menyuntat seseorang, membuat tato, memotong rambut dan sebagainya bisa menularkan HIV sebab alat tersebut mungkin dipakai tanpa disterilkan terlebih dahulu.

f. Menggunakan jarum suntik secara bergantian

Jarum suntik yang digunakan di fasilitas kesehatan, maupun yang oleh para pengguna narkoba (*Injecting Drug User—IDL*) sangat berpotensi menularkan HIV. Selain jarum suntik, pada para pemakai IDU secara bersama-sama juga,

menggunakan tempat penyampur, pengaduk dan gelas pengoplos obat, sehingga berpotensi tinggi untuk menularkan HIV

HIV tidak ditularkan melalui cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bersenggolan
- 2) Berjabat tangan
- 3) Bersentuhan (pakaian bekas dengan penderita)
- 4) Hidup serumah dengan ODHA
- 5) Berciuman biasa
- 6) Makanan/minuman
- 7) Berenang bersarna
- 8) Gigitan nyamuk
- 9) Sabun mandi
- 10) Toilet (Indonesia, 2008)(Irwanto, 2002)

6. Pencegahan HIV & AIDS

- a. Melakukan hubungan seksual hanya dengan satu orang pasangan yang setia
- b. Menggunakan kondom ketika melakukan hubungan seksual dengan benar dan konsisten
- c. Setiap darah transfusi dicek terhadap HIV
- d. Menghindari injeksi, pemeriksaan dalam, prosedur pembedahan yang tidak steril dari petugas kesehatan yang tidak bertanggung jawab
- e. Testing dan konseling ibu hamil
- f. Pemberian Obat antiretroviral bagi ibu hamil yang mengidap HIV.

7. Pemeriksaan

Dua teknik yang digunakan dalam pemeriksaan adalah *enzyme-linked immunosorbent assay* (ELISA) dan *Western Blot assay*. ELISA digunakan sebagai uji saring awal karena lebih murah dibandingkan pemeriksaan Western blot dan lebih mudah digunakan untuk menskrining sejumlah besar sampel (Kaplan, 1997, p. 560). Tes ELISA sangat sensitif tapi tidak selalu spesifik, karena penyakit lain juga bisa menunjukkan hasil positif. Beberapa penyakit yang bisa menyebabkan *false positif*, antara lain penyakit autoimun, infeksi virus, atau keganasan hematologi. Kehamilan juga bisa menunjukkan *false positif*. Tes lain yang biasanya digunakan untuk mengonfirmasi hasil ELISA antara lain: *Western Blot* (WB), *Indirect Immunofluoresence Assay* (IFA) ataupun *Radio-Immuno-Precipitation-Assay* (RIPA).

Western Blot mungkin juga tidak dapat menyimpulkan seseorang menderita HIV atau tidak, karena tes ini harus diulang-ulang. Adapula tes PCR (Polymerase Chain Reaction) yang digunakan untuk DNA dan RNA virus HIV yang sangat sensitif dan spesifik untuk infeksi HIV. Tes ini sering digunakan bila hasil tes yang lain tidak jelas. Begitu pasien didiagnosis HIV maka tingkat kerusakan kekebalan tubuh dapat diukur dengan limfosit CD4 untuk mengetahui kuantitas imunologi

pasien dan juga stadium klinis HIV. WHO juga mengembangkan kriteria stadium klinis berdasarkan total limfosit

8. Pengobatan/ penatalaksanaan HIV/AIDS

HIV menyebabkan terjadinya penurunan kekebalan tubuh sehingga pasien rentan terhadap serangan infeksi oportunistik. Antiretroviral (ARV) bisa diberikan pada pasien untuk menghentikan aktifitas virus, memulihkan sistem imun dan mengurangi terjadinya infeksi oportunistik, memperbaiki kualitas hidup dan menurunkan kecacatan. ARV tidak menyembuhkan pasien HIV, namun bisa memperbaiki kualitas hidup dan memperpanjang usia harapan hidup penderita

HIV/AIDS. Tujuan pemberian ARV :

- a. Menghentikan replikasi HIV.
- b. Memulihkan sistem imun dan mengurangi terjadinya infeksi oportunistik.
- c. Memperbaiki kualitas hidup.
- d. Menurunkan morbiditas dan mortalitas karena infeksi HIV (14).

Jenis obat ARV

- a. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI).
Obat ini sebagai analog nukleosida yang menghambat proses perubahan RNA virus menjadi DNA (proses ini dilakukan oleh virus HIV agar bisa bereplikasi).
- b. *Nucleotide reverse transcriptase inhibitor (NtRTI)*. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Tenofovir (TDF).
- c. *Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI)*. Golongan ini juga bekerja dengan menghambat proses perubahan RNA menjadi DNA dengan cara mengikat *reverse transcriptase* sehingga tidak berfungsi.
- d. *Protease inhibitor (PI)* menghalangi kerja enzim protease yang berfungsi memotong DNA yang dibentuk oleh virus dengan ukuran yang besar untuk memproduksi virus baru.
- e. *Fusion inhibitor*. Yang termasuk golongan ini adalah Enfuvirtide (T-20)

Efek samping pemberian ARV:

- a. Pada umumnya pada obat jenis ini memiliki efek samping NRTI terjadinya toksisitas mitokondrial dan asidosis laktat/toksisitas hepar
- b. NNRTI untuk obat jenis ini efek sampingnya adalah adanya ruam kulit hepatitis (Nursalam, 2009)

F. TATO

1. Definisi

Kata "tato" berasal dari kata Tahitian / Tatu, yang memiliki arti : menandakan sesuatu. Rajah atau tato (Bahasa Inggris: tattoo) adalah suatu tanda yang dibuat dengan memasukkan pigmen ke dalam kulit. Tato merupakan lukisan permanen

pada kulit tubuh. Tato merupakan produk dari body decorating dengan menggambarkan kulit tubuh dengan alat tajam berupa jarum, tulang dan sebagainya kemudian bagian tubuh yang digambar tersebut diberi zat pewarna atau pigmen berwarna-warni. Rajah dapat dibuat terhadap kulit manusia atau hewan. Walaupun pada beberapa kalangan rajah dianggap tabu, seni rajah tetap menjadi sesuatu yang populer di dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tato berarti gambar (lukisan) pada bagian (anggota) tubuh.

2. Teknik pembuatan tato

Ada berbagai cara dalam pembuatan tato. Ada yang menggunakan tulang binatang sebagai jarum seperti yang dapat dijumpai pada orang-orang Eskimo, Suku Dayak dengan duri pohon jeruk, dan ada pula yang menggunakan tembaga panas untuk mencetak gambar naga di kulit seperti yang dapat ditemui di Cina. Sebenarnya rasa sakit pasti dialami ketika membuat tato di tubuh, namun karena nilai yang tinggi dari tato, dan harga diri yang didapatkan, maka rasa sakit itu tidak dianggap masalah. Ada berbagai jenis dan ragam bentuk tato, tergantung dengan apa yang dipercaya oleh suku-suku bersangkutan, dan di setiap daerah umumnya memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang tato, meski pada prinsipnya hampir sama.

3. Efek samping

Efek samping yang bisa muncul dari pembuatan tato adalah adanya risiko infeksi seperti penggunaan jarum yang tidak steril atau kandungan zat-zat berbahaya dari tinta yang dipakai. Beberapa korban mulai berjatuh terkena infeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV). Tinta tato umumnya terbuat dari suspensi partikel yang larut dalam air seperti merkuri, kadmium, timah dan besi yang disuntikkan di bawah kulit untuk membentuk suatu gambar dengan menggunakan jarum. Risiko infeksi juga bisa terjadi saat pembuatan tato karena tinta yang dipakai mengandung zat-zat berbahaya. Beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan dari proses tato yang tidak steril adalah infeksi HIV AIDS, Hepatitis B atau C, TBC, Mycobacterium, Sifilis, Malaria dan Lepra. Warna lain dari tinta tato standar juga berasal dari logam berat (termasuk timah, antimon, berilium, kromium nikel, kobalt, dan arsen). Sama seperti logam berat pada tinta merah, tinta-tinta ini juga dapat menyebabkan reaksi kulit pada beberapa orang. Logam-logam yang terdapat dalam tato yang digunakan pada kulit telah diketahui dapat menyebabkan reaksi alergi, eksim, jaringan parut, dan juga dapat menyebabkan sensitivitas terhadap merkuri.

4. Nilai tato

- a. Di Borneo (Kalimantan), penduduk asli wanita disana menganggap bahwa tato merupakan sebuah simbol yang menunjukkan keahlian khusus.

- b. Di Cina, pada masa zaman Dinasti Ming (kurang lebih 350 tahun yang lalu), wanita dari Suku Drung membuat tato di wajah dan pantatnya untuk sebagai tanda bagi keturunan yang baik.
- c. Di Indian, melukis tubuh/ *body painting* dan mengukir kulit, dilakukan untuk mempercantik (sebagai tujuan estetika) dan menunjukkan status sosial.
- d. Suku Mentawai memandang tato sebagai suatu hal yang sakral dan berfungsi sebagai simbol keseimbangan alam.

G. Persepsi

1. Pengertian

- a. Persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian persepsi adalah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Dengan persepsi individu akan menyadari tentang keadaan di sekitarnya dan juga keadaan diri sendiri (Walgito, 2004)
- b. Persepsi adalah the interpretation of experience atau penafsiran terhadap suatu pengalaman (Irwanto, 2002).
- c. Persepsi adalah tanggapan terhadap sesuatu yang diperhatikan atau suatu pengalaman yang telah dilaluinya (Widayatun, 1991)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor- faktor yang berperan dalam persepsi yaitu :

a. Faktor internal (individu).

Mengenai keadaan individu yang dapat mempengaruhi hasil persepsi adalah segi jasmani dan psikologik. Apabila sistem fisiologisnya terganggu maka akan mempengaruhi persepsi seseorang. Sedangkan dari segi psikologik yang mempengaruhi adalah pengalaman, perasaan, kemampuan berfikir, kerangka acuan, dan motivasi. Ini akan berpengaruh pada seseorang untuk mengadakan persepsi.

b. Faktor eksternal (stimulus lingkungan).

Obyek yang sama dengan situasi sosial yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

- a. Persepsi bisa terjadi dengan sendirinya.
- b. Setiap individu mempunyai persepsi yang berbeda-beda.
- c. Belajar.
- d. Kesiapan mental
- e. Kebutuhan dan motivasi
- f. Gaya berfikir.

Dalam psikologi umum menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

a. Perhatian yang selektif.

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsangan dari lingkungan. Tetapi manusia sebagai individu tidak selalu akan memusatkan perhatiannya pada rangsangan tertentu saja.

b. Ciri-ciri rangsangan

Rangsang yang bergerak diantara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsang yang paling besar diantara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya, dan yang intensitas rangsanganya paling kuat.

c. Nilai-nilai dan kebutuhan individu.

Setiap orang mempunyai pola dan cita rasa sendiri dalam pengamatan.

d. Pengalaman terdahulu.

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam memberikan persepsi.

4. Proses terjadinya persepsi.

Pertama terjadinya persepsi adalah karena adanya obyek atau stimulus yang merangsang (obyek tersebut menjadi perhatian panca indra), kemudian stimulus atau obyek perhatian tersebut akan dibawa ke otak Di otak terjadi adanya kesan, jawaban atau respon dan kemudian akan dikembalikan lagi ke panca indra berupa tanggapan atau persepsi. Obyek stimulus => sensoris => diproses indra (input) => indra di otak (pusat syaraf) => berupa persepsi rangsangan pengalaman/respon. Proses terjadinya persepsi ini memerlukan fenomena yaitu perhatian. Perhatian adalah suatu konsep yang diberikan pada proses persepsi yang menyertakan input-input tertentu untuk diikuti sertakan dalam suatu pengamatan yang disadari dalam suatu waktu tertentu. Perhatian mempunyai ciri-ciri khusus yaitu fokus, margin dan berubah-ubah.

5. Bentuk-bentuk persepsi.

Bentuk-bentuk persepsi yaitu:

a. Persepsi bentuk.

Merupakan persepsi dalam bentuk obyek.

b. Persepsi kedalaman.

Merupakan persepsi yang didalamnya terdapat monocular cues dan binocular cues.

c. Persepsi gerak.

Persepsi ini terdiri dari gerak nyata dan gerak maya.

d. Persepsi terhadap diri sendiri (introspeksi) dan persepsi terhadap orang lain (ekstrospeksi).

- e. Persepsi dengan berbagai jenis yang berhubungan dengan sensoris dan motoris.
 - 1) Persepsi audit (suara).
 - 2) Persepsi vision (penglihatan).
 - 3) Persepsi bau (Penciuman).
 - 4) Persepsi motoris (gerak).
 - 5) Persepsi pengecap (lidah atau rasa).
 - 6) Persepsi peraba (kulit).
- f. Persepsi yang dilihat konstansinya.
 - 1) Persepsi warna.
 - 2) persepsi bentuk.
 - 3) Persepsi besar atau kecil (persepsi ukuran).
 - 4) Persepsi tempat.
 - 5) Persepsi jauh atau dekat obyek.
- 6. Macam-macam persepsi
 - a. Klosur

Merupakan prinsip-prinsip pengelompokan dimana orang kadang-kadang mempersepsikan sesuatu sebagai keseluruhan meskipun ada satu atau beberapa orang yang tidak mendukung atau menyetujui. Contoh : Pandangan seseorang muncul karena adanya satu pendapat.
 - b. Kontinuitas

Kontinuitas ini erat hubungannya dengan klosur, meskipun ada sedikit perbedaan. Klosur mengisi stimuli yang hilang sedangkan prinsip kontinuitas menyatakan bahwa orang itu akan cenderung mempersiapkan garis-garis atau pola-pola yang kontinyu. Contoh : Hampir sama seperti klosur tapi masih memperhatikan pendapat orang lain.
 - c. Proksimitas

Prinsip proksimius ini uu kedekatan menyatakan bahwa sekelompok stimulus yang secara bersama saling berdekatan akan dipandang sebagai satu pola yang menyeluruh.
 - d. Kesamaan

Prinsip kesamaan ini menyatakan bahwa makin besar kesamaan dari stimuli makin besar kecenderungan untuk mempersiapkan stimuli tersebut sebagai sebuah kelompok umum. Contoh : Persepsi yang berasal dari pendapat yang paling banyak.

H. Teori Proteksi Motivasi (Protection Motivation Theory/PMT)

Gaya menghadapi tindakan atau tindakan pencegahan : tindakan perseorangan (*single acts*), pengulangan tindakan (*repeated act*), melipatgandakan tindakan (*multiple acts*), mengulangi melipatgandakan tindakan (*repeated multiple acts*). Teori Proteksi Motivasi adalah salah satu model yang menjelaskan tentang mengapa orang melakukan perilaku tidak sehat dan disarankan untuk merubahnya melalui proses edukasi dan motivasi. Komponen dari PMT yang asli mengklaim bahwa perilaku yang berhubungan dengan kesehatan adalah hasil dari empat komponen. Berikut ini empat komponen dasar dari

Teori Proteksi Motivasi :

1. Keparahan yang dirasakan (*severity*), merupakan persepsi seseorang terhadap tingkat keparahan penyakit yang diderita. Tindakan seseorang untuk mencari pengobatan dan pencegahan penyakit di dorong oleh ancaman penyakit tersebut. Hal ini bervariasi setiap individu , misalnya : jika menyebabkan penyakit, mengurangi fungsi fisik dalam waktu lama, menyebabkan kecacatan permanen dan mempunyai dampak terhadap individu dan keluarga.
2. Kerentanan yang dirasakan (*vulnerability*), merupakan persepsi subyektif seseorang tentang resiko terkena penyakit. Seseorang akan bertindak untuk mengobati atau mencegah penyakit bila ia merasa bahwa ia rentan terhadap serangan penyakit tersebut. Kerentanan setiap individu berbeda, tergantung pada resiko individu yang dirasakan dari suatu keadaan tertentu.
3. *Response Effectiveness*, efektivitas yang menyangkut perilaku yang direkomendasikan dalam memindahkan atau mencegah gangguan / bahaya yang ditimbulkan.
4. Kemampuan diri (*Self Efficacy*), kemampuan diri dalam membangun representasi kepercayaan diri pada situasi tertentu yang dimiliki seseorang sehingga mereka dapat melakukan coping pada situasi beresiko tinggi tanpa kambuh ke kebiasaan mereka yang tidak sehat atau beresiko tinggi. *Self efficacy* merupakan kepercayaan diri seseorang tentang kemampuan dirinya untuk melakukan sebuah tindakan. Pengulangan aktivitas dapat meningkatkan *self efficacy*. Persepsi tentang *self efficacy* yang rendah menghambat orang bertindak dengan cara-cara sebagaimana mereka ketahui bahwa itu seharusnya dilakukan. Menurut Bandura, *self efficacy* adalah suatu kepercayaan individu terhadap kemampuannya dalam suatu tugas spesifik dalam situasi spesifik. Rogers menyebutkan , bahwa *self efficacy* dalam Teori Proteksi Motivasi menentukan untuk terjadinya suatu perilaku , perilaku mana yang akan dipilih, berapa banyak usaha akan dilakukan dan berapa lama hal tersebut akan tetap berlaku. Seseorang yang mempunyai *self efficacy* maka akan lebih besar mencapai ke arah tujuan dan lebih besar untuk mengadopsi atau merekomendasi perilaku. Orang yang memiliki perasaan yang tinggi yakin bahwa dia akan berhasil,

sehingga dia akan melaksanakan tugasnya dengan cepat dan percaya diri. Sedangkan orang dengan *self efficacy* yang rendah yakin bahwa ia akan gagal.

I. Persepsi Pengetahuan Informan Tentang HIV/AIDS dan Tato

Dari hasil wawancara pada informan primer didapatkan bahwa sebagian besar menganggap bahwa tato adalah seni, hiasan di badan, keisengan, gaya hidup, seni yang sekarang masih dianggap kriminal. Hasil ini didukung oleh pendapat dari informan sekunder yang menyatakan bahwa tato merupakan karya seni, kesukaan dari pengguna dan trend gaya hidup.

Para ahli memiliki beberapa definisi untuk tato. Tato adalah simbol untuk menandai hukuman pada kriminal, rekonstruksi untuk pengobatan kulit atau kosmetik dan tato dilihat dari sosial dan tergantung pada konteks penggunaannya. (Bidari, 2014).

Gaya hidup merupakan gambaran bagi setiap orang yang memakainya dan menggambarkan seberapa besar nilai moral orang tersebut dalam masyarakat disekitarnya. Atau juga, gaya hidup merupakan suatu seni yang dibudayakan oleh setiap orang. Gaya hidup juga sangat berkaitan erat dengan perkembangan zaman dan teknologi. Semakin bertambahnya zaman dan semakin canggihnya teknologi, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti lain, gaya hidup dapat memberikan pengaruh positif atau negatif bagi yang menjalankannya, tergantung pada bagaimana orang tersebut menyikapi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahayu yaitu tentang Pemaknaan Tato pada Pengguna Tato hasilnya pengguna tato menato tubuhnya adalah karena coba-coba atau iseng, mengabadikan momen khusus dalam kehidupannya, mencari perhatian dan sebagai aksesoris.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tato berarti gambar (lukisan) pada bagian (anggota) tubuh. Tato merupakan lukisan permanen pada kulit tubuh. Tato merupakan produk dari body decorating dengan menggambarkan kulit tubuh dengan alat tajam berupa jarum, tulang dan sebagainya kemudian bagian tubuh yang digambar tersebut diberi zat pewarna atau pigmen berwarna- warni. Rajah dapat dibuat terhadap kulit manusia atau hewan. Walaupun pada beberapa kalangan rajah dianggap tabu, seni rajah tetap menjadi sesuatu yang populer di dunia.

Menurut Gumilar (2005), makna penggunaan tato digunakan sebagai komunikasi simbolik, perilaku yang menyimpang karena tato dianggap sebagai sesuatu yang modis, trendi, dan fashionable, gaya tersebut memang dekat dengan budaya pemberontakan.

Pengetahuan informan mengenai HIV/AIDS antara lain HIV/AIDS merupakan jenis penyakit kelamin, penyakit yang menyerang badan, penyakit yang membutuhkan waktu lama untuk merasakannya, penyakit yang bisa menyebabkan

kematian, penularan lewat berganti pasangan, jarum suntik yang digunakan bergantian (jarum terinfeksi), dan penyakit yang masih bisa disembuhkan jika ada obatnya.

Dari hasil wawancara kepada informan sekunder (nakes) tentang HIV/AIDS, terdapat kecocokan antara jawaban informan utama dengan informan sekunder dimana HIV/AIDS merupakan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak aman, jarum suntik yang digunakan bergantian, namun ada jawaban yang kurang cocok dimana HIV dan AIDS tidak sama (HIV virus penyebabnya, AIDS kumpulan gejala), penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada informasi yang harus diberikan mengenai HIV/AIDS kepada informan utama untuk menambah pengetahuan tentang HIV/AIDS.

Pengetahuan mengenai penyakit akan membuat seseorang memperhatikan perilakunya, seperti dalam penelitian yang dilakukan Tuti (2009), Berdasar analisis Chi square diketahui ada pengaruh tingkat pengetahuan terhadap kejadian HIV dan AIDS (OR 2,442, 95% CI 1,268<OR<4,704 p value 0,001). menunjukkan bermakna, jadi secara epidemiologi tingkat pengetahuan kurang mempunyai risiko 2,442 kali lebih besar terhadap kejadian HIV dan AIDS.

J. Persepsi Informan Tentang Resiko Kerentanan dan Keparahan Tertular HIV/AIDS karena Tato

Sebagian besar informan tidak merasa rentan terhadap HIV/AIDS karena mereka merasa jarum yang digunakan steril. Tapi ada satu informan yang merasa malah semakin sehat padahal jarum yang digunakan pada saat dia di tato tidak tahu asal-usulnya.

Pendapat informan utama mengenai kerentanan terkena HIV/AIDS akibat penggunaan tato tidak didukung oleh pernyataan informan sekunder, diantaranya resiko jika menggunakan jarum sembarangan misalnya tidak steril, jarum bergantian digunakan bisa terinfeksi virus HIV/AIDS.

Namun ada responden yang sudah mengetahui bahwa penggunaan jarum suntik bergantian bisa menularkan penyakit HIV/AIDS. Alat tajam dan runcing seperti jarum, pisau, silet, menyuntat seseorang, membuat tato, memotong rambut dan sebagainya bisa menularkan HIV sebab alat tersebut mungkin dipakai tanpa disterilkan terlebih dahulu.

HIV merupakan jenis virus yang menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga orang yang terkena virus ini menjadi rentan terhadap beragam infeksi atau juga mudah terkena tumor (WHO, 2007 dan Depkes RI, 2008).

Efek samping yang bisa muncul dari pembuatan tato adalah adanya risiko infeksi seperti penggunaan jarum yang tidak steril atau kandungan zat-zat berbahaya dari tinta yang dipakai. Beberapa korban mulai berjatuh terkena infeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Kerentanan yang dirasakan (*vulnerability*), merupakan persepsi subyektif seseorang tentang resiko terkena penyakit. Seseorang akan bertindak untuk mengobati atau mencegah penyakit bila ia merasa bahwa ia rentan terhadap serangan penyakit tersebut. Kerentanan setiap individu berbeda, tergantung pada resiko individu yang dirasakan dari suatu keadaan tertentu.

Sesuai dengan hasil penelitian didapatkan kerentanan yang dirasa kurang karena mereka yakin akan keamanan peralatan atau proses tato yang dilakukan padahal mereka belum mengetahui secara pasti bagaimana cara pembuat tato mempersiapkan peralatan dan pada saat proses tato berlangsung.

Keparahan yang dirasakan (*severity*), merupakan persepsi seseorang terhadap tingkat keparahan penyakit yang diderita. Tindakan seseorang untuk mencari pengobatan dan pencegahan penyakit di dorong oleh ancaman penyakit tersebut. Hal ini bervariasi setiap individu, misalnya: jika menyebabkan penyakit, mengurangi fungsi fisik dalam waktu lama, menyebabkan kecacatan permanen dan mempunyai dampak terhadap individu dan keluarga.

K. Persepsi Informan Tentang Kemampuan Diri (*Self Efficacy*) Melakukan Tato

Informan yang diwawancara sebagian besar sudah melakukan tato hampir 80%, sehingga tidak ada niat lagi untuk menambah tato, ada juga informan yang melakukan tato karena dijebak minum sehingga tidak sadarkan diri,. begitu bangun badannya di tato seluruh tubuh. Informan menggunakan tato hanya mengikuti seni, pergaulan dan pengaruh teman. Pada awalnya informan merasa malu menggunakan tato, cenderung untuk menyembunyikan dengan lingkungan sekitar, tapi lama kelamaan informan sudah terbiasa bila orang lain mengetahui bahwa dirinya menggunakan tato.

Hasil wawancara dengan informan primer tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan informan sekunder, dimana didapat hasil bahwa beberapa respon dari keluarga terdekat informan akhirnya menerima jika anggota keluarganya mempunyai tato, karena tidak bisa melawan keinginan penggunaan tato anggota keluarganya tersebut.

Kemampuan diri (*self efficacy*) memang mempunyai pengaruh terhadap pembentukan perilaku seseorang seseorang yang mempunyai *self efficacy* maka akan lebih besar mencapai ke arah tujuan dan lebih besar untuk mengadopsi atau merekomendasi perilaku.

Orang yang memiliki perasaan yang tinggi yakin bahwa dia akan berhasil, sehingga dia akan melaksanakan tugasnya dengan cepat dan percaya diri. Sedangkan orang dengan *self efficacy* yang rendah yakin bahwa ia akan gagal. Dalam hal ini seseorang yang sudah menyakini akan penggunaan tato yang hanya sebagai seni, dia percaya bahwa penggunaannya aman akan mempunyai kepercayaan diri yang kuat

kalau dirinya benar-benar nyaman dan merasa aman akan perilaku yang diperbuatnya.

L. Sumber Informasi Yang Diterima Informan Mengenai Tato dan HIV/AIDS

Sumber informasi yang didapatkan informan mengenai tato rata-rata dari teman sepergaulan. Sedangkan informasi mengenai HIV/AIDS hampir sebagian besar informan hanya sekilas tahu mengenai informasi tentang HIV/AIDS yang didapatnya melalui media elektronik (TV) penyuluhan yang diberikan di sekolah.

Hasil wawancara tersebut didukung oleh pernyataan informan sekunder, diantaranya bahwa tato yang digunakan oleh anggota keluarganya awalnya karena ajakan teman sepermainan.

Sumber informasi berperan penting bagi seseorang dalam menentukan sikap atau keputusan bertindak. Banyak media seperti media massa, baik media cetak seperti surat kabar dan majalah, ataupun elektronika seperti televisi, radio dan internet ; dan pemuka pendapat untuk wilayah pedesaan dianggap cukup efektif untuk menciptakan konsensus sosial. Secara umum media berfungsi sebagai sumber informasi, sumber pendidikan dan sumber hiburan.

Menurut Rogers (1983) Sumber informasi ini yang mempengaruhi kelima komponen PMT (Self efficacy, response effectiveness, severity, vulnerability, dan fear), yang kemudian akan mendapatkan salah satu dari adaptive coping response (contoh: sikap atau niat dalam berperilaku) atau maladaptive coping response (contoh: menghindar, menolak). Penelitian ini sesuai dengan teori tersebut dikatakan bahwa semakin seseorang mendapatkan informasi dari berbagai sumber (bidan, dokter, perawat, suami, teman, keluarga, media masa, media elektronik) maka kecenderungan seseorang akan mengambil perilaku yang baik pula mengenai suatu hal.

M. Dukungan Sosial (Keluarga, Teman) Untuk Melakukan Tato

Menurut informan yang melakukan tato, hampir sebagian tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, bahkan sampai disembunyikan penggunaannya. Namun sebagian besar dapat dukungan dari teman bermain. Kebanyakan mereka diantar oleh temannya pada saat melakukan tato, ada juga yang dipaksa dan ada juga yang ditawarkan gratis karena temannya mempunyai alat tato baru.

Rata-rata informan yang menggunakan tato pada awal tahun 1990, mereka masih single dan belum mempunyai keluarga, jadi pada saat tersebut mereka tidak mendapatkan tantangan. Penggunaannya pun tidak langsung mereka ungkapkan pada keluarga, melainkan ditutup-tutupi pada awalnya.

Walaupun demikian setelah keluarga mengetahui bahwa informan ternyata menggunakan tato, keluarga akhirnya bisa menerima karena tato tersebut tidak mungkin dihapus. Keluarga juga menyatakan hal yang sama bahwa mereka tidak

mendukung apabila informan menambah tato lagi. Hal ini dibuktikan dengan pendapat informan sekunder yang menyatakan tindakan penggunaan tato sudah terlanjur dilakukan, dan tidak bisa dihapus begitu saja. Keluarga juga tidak menyarankan penambahan tato lagi pada keluarga mereka dan keluarga menganjurkan bahwa tato yang dipasang di anggota mereka seharusnya dihapus.

Beberapa pernyataan diatas menunjukkan adanya pro dan kontra tentang penggunaan tato di masyarakat. Seperti pada penelitian Bidari, (2014), tato sudah menjadi bagian dari karya seni yang cukup populer di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Penggunaan tato merupakan representatif dari kehidupan penggunanya atau mengungkapkan sebuah perasaan yang emosional.

Dukungan sosial merupakan suatu bentuk hubungan interpersonal yang memberikan bantuan kepada individu berupa perhatian emosi bantuan instrumental, pemberian informasi dan penghargaan atau penilaian kepada individu oleh lingkungan sosialnya. Dukungan sosial merupakan sumber daya sosial dalam menghadapi suatu peristiwa yang menekan dan perilaku menolong yang diberikan pada individu yang membutuhkan dukungan dan dukungan yang dirasakan oleh individu dalam kehidupannya membuat ia merasakan arti dicintai, dihargai, dan diakui serta membuat dirinya menjadi lebih berarti dan dapat mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya.

Pengguna tato saat mengambil keputusan untuk menato dirinya, pada skala tertentu pelaku mendapatkan dukungan dari luar dirinya. Faktor lain diluar individu memiliki pengaruh besar dalam pembentukan konsep diri seseorang, hal ini dibuktikan dalam kasus tato. Dukungan yang diterima pengguna tato saat ingin membuat tato dari orang-orang terdekatnya membuat pengguna tato semakin percaya diri dengan apa yang dia lakukan. Bukan hanya dari orang terdekat, tetapi dari kelompok atau komunitas, dapat menjadi alasan mengapa seorang individu dapat bersikap demikian.

Penggunaan tato selain mendapat dukungan dari orang terdekat, ada kemungkinannya diantara orang-orang tersebut yang memiliki tato dan menarik perhatian pengguna tato untuk memilikinya juga. Komunitas atau kelompok yang semakin banyak dan semakin spesifik bisa membentuk individu tersebut. Individu tersebut dapat memilih akan mengikuti norma komunitas yang mana, yang cocok dengan dirinya dan dirinya merasa nyaman.

N. Praktik Melakukan Tato

Informan mengatakan melakukan tato dengan berbagai macam tinta yaitu ada tinta mahal, tinta printer dan tinta pulpen. Jarum yang digunakan ada yang beli sendiri sehingga memastikan bahwa jarum itu steril, ada yang beli di warung dan ada juga yang bergantian dengan temannya, ada pula informan yang mempergunakan

jarum jahit untuk menato badannya. Pelaksanaannya menusukkan jarum-jarum tersebut di tubuh orang yang mau ditato.

Praktek penggunaan tato dilakukan oleh orang-orang yang biasa menato atau seniman tato baik yang sudah berpengalaman atau yang belum berpengalaman. Ada salah satu informan yang ditato oleh temannya sendiri untu ajang uji coba.

Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tato beraneka ragam. Rata-rata responden mengeluarkan minimal 50ribu sampai 100ribu untuk mendapatkan sebuah tato. Pada responden yang mempunyai tato leih dari 10 tahun, tidak ada biaya yang dikeluarkan, karena mereka ditato secara bersama-sama.

Penggunaan tato dengan biaya yang seperti itu, memungkinkan terjadinya praktik tato yang illegal, dengan penggunaan jarum yang tidak steril, tinta yang tidak direkomendasikan dan tidak memperhatikan prinsip penggunaan tato dengan benar.

Reaksi setelah di tato adalah demam, kemerahan dan gatal. Ada yang menggunakan super tetra 1 tablet untuk mengatasinya, ada juga dengan menggunakan handbody dengan diusapkan ke tato kemudian 3 hari berikutnya mengelupas dan tidak kemerahan dan tidak sakit lagi. Jenis tato untuk pria adalah batik dan yang cocok untuk wanita adalah triball. Ratarata informan ditato oleh teman yang sudah di kenal.

Penggunaan tato pada kurun waktu tahun 90-an informan tidak mengetahui bahwa dirinya akan di tato, penggunaan jarumnya juga tidak menyakinkan, bahkan ada yang digunakan bergantian untuk membuat tato bersama-sama.

Hasil pendapat informan tersebut didukung oleh pendapat dari informan sekunder yang merupakan seniman tato di jalan. Dia menjelaskan bahwa praktek tato yang digunakan dirinya menggunakan jarum yang steril, tidak digunakan secara bergantian, tinta tato yang digunakan juga khusus untuk tinta body painting. Namun saat onservasi yang dilakukan oleh peneliti, dimana ada klien yang ingin melakukan tindik telinga, seniman tato hanya meyemprotkan cairan alkohol dan langsung memasukkan jarum tindik kepada dua klien secara lansung. Hasil observasi peneliti tidak sesuai dengan penjelasan seniman tato mengenai bagaimana praktek tato yang dia gunakan di jalanan.

Kata “tato” berasal dari kata Tahitian / Tatu, yang memilki arti : menandakan sesuatu. Rajah atau tato (Bahasa Inggris: tattoo) adalah suatu tanda yang dibuat dengan memasukkan pigmen ke dalam kulit.

Sebenarnya rasa sakit pasti dialami ketika membuat tato di tubuh, namun karena nilai yang tinggi dari tato, da harga diri yang didapatkan, maka rasa sakit itu tidak dianggap masalah. Ada berbagai jenis dan ragam bentuk tato, tergantung dengan apa yang dipercaya oleh suku-suku bersangkutan, dan di setiap daerah umumnya memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang tato, meski pada prinsipnya hampir sama.

Efek samping yang bisa muncul dari pembuatan tato adalah adanya risiko infeksi seperti penggunaan jarum yang tidak steril atau kandungan zat-zat berbahaya dari tinta yang dipakai. Beberapa korban mulai berjatuhannya terkena infeksi virus Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Tinta tato umumnya terbuat dari suspensi partikel yang larut dalam air seperti merkuri, kadmium, timah dan besi yang disuntikkan di bawah kulit untuk membentuk suatu gambar dengan menggunakan jarum. Risiko infeksi juga bisa terjadi saat pembuatan tato karena tinta yang dipakai mengandung zat-zat berbahaya.

Beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan dari proses tato yang tidak steril adalah infeksi HIV AIDS, Hepatitis B atau C, TBC, Mycobacterium, Sifilis, Malaria dan Lepra. Warna lain dari tinta tato standar juga berasal dari logam berat (termasuk timah, antimon, berilium, kromium nikel, kobalt, dan arsen). Sama seperti logam berat pada tinta merah, tinta-tinta ini juga dapat menyebabkan reaksi kulit pada beberapa orang. Logam-logam yang terdapat dalam tato yang digunakan pada kulit telah diketahui dapat menyebabkan reaksi alergi, eksim, jaringan parut, dan juga dapat menyebabkan sensitivitas terhadap merkuri.

O. Simpulan

1. Persepsi pengetahuan informan tentang HIV/AIDS dan tato Pengetahuan informan mengenai HIV/AIDS masih kurang baik, pengetahuan mengenai tato sekedar seni, gaya hidup/trend.
2. Persepsi informan tentang resiko kerentanan tertular HIV/AIDS karena tato Persepsi informan mengenai resiko kerentanan, mereka kurang tahu bahwa tato bisa menularkan HIV/AIDS, karena mereka menganggap tato yang digunakan aman.
3. Persepsi informan tentang keparahan penyakit HIV/AIDS karena tato Persepsi informan akan keparahan, mereka tahu bahwa HIV/AIDS bias ditularkan melalui penggunaan jarum yang tidak steril
4. Persepsi informan tentang kemampuan diri (self efficacy) melakukan tato Sebagian besar informan merasa kurang yakin akan penggunaan tato mereka, karena rasa malu akan anggapan orang lain, juga keluarga. Sebagian informan juga menyesal atas penggunaan tato mereka.
5. Sumber informasi yang diterima informan mengenai tato dan HIV/AIDS Hanya sebagian kecil saja yang memperoleh informasi mengenai HIV/AIDS. Informasi yang didapat pada saat informan sekolah.
6. Dukungan sosial (keluarga, teman) untuk melakukan tato Pada awalnya keluarga responden tidak mendukung penggunaan tato oleh informan, namun karena sudah terlanjur dan tidak bisa dihapus akhirnya keluarga menerima.
7. Praktek melakukan tato

Hampir sebagian informan melakukan tato secara kurang benar, antara lain penggunaan jarum yang tidak steril, bergantian, tinta yang tidak direkomendasikan. Petugas yang melakukan praktik tato pun belum memiliki keahlian yang khusus dan benar.

P. Saran

1. Praktik penggunaan tato harus jelas bahan yang digunakan dalam tato, pelaksanaannya pun harus sesuai yaitu satu peralatan tato untuk satu pengguna.
2. Maraknya praktik tato di jalanan sebaiknya diatur izin dalam kegiatannya, sehingga meminimalisir adanya praktik tato yang berbahaya
3. Informan atau pembaca hendaknya lebih memperkaya informasi mengenai penyakit HIV/AIDS khususnya mekanisme penularan yang bisa disebabkan karena penggunaan tato yang berbahaya dan tidak semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidari, M. (2014). *Penggunaan Tato Sebagai Bentuk Komunikasi NonVerbal*. FISIP UI.
- Dinas Kesehatan Kota Semarang. (2012). *Laporan Penyakit Tidak Menular*. DKK Kota Semarang.
- Indonesia. (2008). *Modul Pelatihan Pencegahan Penularan HIV/AIDS dari Ibu ke Bayi (PMTCT)* (Editor, Ed.). <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Irwanto. (2002). *Psikologi Umum*. PT. Prenhallindo.
- Kementrian, R. (2013). *Laporan perkembangan HIV/AIDS triwulan II tahun 2013*.
- Moleong. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moh, Isyam. 2004. *Ancaman Virus HIV/AIDS dan Upaya Pencegahannya (dalam perspektif sosiologis dan agama)*. *Aplikasia, Jurnal Ilmu Agama*, ol V, No.1 Juni 2004:60-77.
- Tuti, S. (2009). *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian HIV/AIDS di Semarang dan sekitarnya*.
- Widayatun, R. (1991). *Ilmu Perilaku*. CV Sagung Seto.

GLOSARIUM

A

AIDS: kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh bukan disebabkan oleh penyakit bawaan namun disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus

G

Grounded theory: desain penelitian dimana peneliti ingin meneliti beberapa individu yang semuanya telah mengalami aktivitas, interaksi, atau proses dalam satu fenomena sehingga penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi.

H

HIV: virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh (limfosit) yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia.

K

Kualitatif: penelitian yang berfokus pada pengalaman, interpretasi serta makna hidup seseorang yang mengalaminya

T

Tato: pewarnaan permanen pada tubuh dengan cara diresapkan dengan benda tajam kedalam kulit(dermis).

INDEKS

AIDS

HIV

Tato

PROFIL PENULIS



Dr. Festy Mahanani Mulyaningrum, SST.MPH

Penulis Lahir di Kendal, 20 Mei 1990, lulus DIV Bidan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Surakarta 2012, lulus S2 Universitas Sebelas Maret 2015 dan Lulus Program Doktor Promosi Kesehatan Universitas Sebelas Maret 2021. Aktif di beberapa organisasi baik sebagai anggota atau pengurus organisasi seperti IBI dan DWP KPP Jakarta, bekerja sebagai Dosen An Nuur Purwodadi mulai tahun 2016-sekarang. Hasil penelitian rutin dipublikasikan penulis tiap semester di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Prosiding baik nasional maupun internasional. Beberapa modul dan buku sudah dipublikasikan, ber-ISBN dan mendapat Hki antara lain Buku Ajar Komunikasi Kebidanan, Modul Komik IMS HIV AIDS, Buku Self efficacy, dan Monograf Model Promosi Kesehatan Deteksi Dini Kanker Servix. Penulis juga sudah lolos hibah RISTEKDIKTI tiga kali, dua kali hibah PDP dan satu kali hibah Talenta Inovasi dosen.



Rosyati Pastuty, S.SiT, M.Kes

Penulis lahir di Kota Palembang pada tanggal 14 Oktober 1972. Penulis merupakan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Poltekkes Kemenkes Palembang sejak tahun 2015. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan Kesdam II/Sriwijaya Palembang pada tahun 1988 dan melanjutkan Program Pendidikan Bidan di Kesdam II/Sriwijaya Palembang, lulus tahun 1992. Kemudian penulis menjalankan tugas sebagai Bidan di Desa Kota Raya Kabupaten Lahat sampai tahun 1997. Tahun 1997–2000 penulis melanjutkan pendidikan di Akademi Kebidanan Depkes Palembang. Tahun 2001 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi D-IV Bidan Pendidik Universitas Gajah Mada Yogyakarta lulus pada tahun 2002. Tahun 2006 penulis menyelesaikan studi S2 di Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat KIA–Kesehatan Reproduksi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Mulai tahun 2000 penulis bekerja sebagai staf Guru di Akbid Depkes Palembang. Tahun 2006 sampai sekarang penulis merupakan dosen di Poltekkes Kemenkes Palembang Jurusan Kebidanan. Beberapa penelitian telah dilakukan dan didanai oleh internal Poltekkes Kemenkes Palembang. Selain sebagai peneliti, penulis juga sebagai penulis buku kesehatan.

Email Penulis: rosyatipastuty@poltekkespalembang.ac.id

PROFIL PENULIS



Jusni, S.ST., M.Kes adalah nama lengkap penulis. Penulis lahir di Bulukumba pada tanggal 24 April 1990, Putri dari pasangan hebat bernama Tajuddin dan Basse. Penulis saat ini aktif sebagai dosen tatap disalah satu kampus di Kabupaten

Bulukumba Sulawesi Selatan. Penulis menempuh pendidikan dari SD sampai D3 di Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan yaitu di SDN 53 Pabbambaeng (lulus tahun 2003, MTS Darul Istiqamah (lulus tahun 2006) dan MA Darul Istiqamah (lulus tahun 2009). Pendidikan DIII Kebidanan di Akademi Kebidanan Tahirah Al Baeti Bulukumba, lulus tahun 2012. Pendidikan S1 diselesaikan di Jakarta pada Universitas Respati Indonesia, jurusan DIV Bidan Pendidik, lulus tahun 2014 dan menyelesaikan Pendidikan Master (S2) di Jakarta pada Universitas Respati Indonesia lulus tahun 2016. Saat ini penulis sudah menerbitkan bukunya sebanyak tujuh buku yaitu Kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, Gizi dan Kesehatan Balita, Anatomi Fisiologi Kebidanan, Modul Praktikum Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan, Modul Praktikum Usuhan Pascasalin dan menyusui, Modul Praktikum Kegawatdaruratan serta Chapter Book Pengantar Asuhan Kebidanan. Penulis sudah tiga kali lolos hibah penelitian Ristekdikti, satu sebagai anggota dan dua kali sebagai ketua peneliti.



Bd. Fauziah Winda Gurnita, M.Tr.Keb

Penulis Lahir di Bangil, 13 Maret 1992 lulus DIV Bidan Pendidik di STIKes Karya Husada Semarang 2014, lulus S2 Poltekkes Kemenkes Semarang 2018 dan Lulus Program Profesi Bidan 2022. Bekerja sebagai Dosen Universitas Karya Husada Semarang mulai tahun 2018-sekarang. Hasil penelitian rutin dipublikasikan penulis tiap semester di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Prosiding baik nasional maupun internasional.

Beberapa karya sudah dipublikasikan, ber-ISBN dan mendapat Hki antara lain Karya Arsitektur Inovasi Desain Kamar Bersalin dengan Konsep Sayyidah Maryam, Karya Arsitektur Inovasi Desain Ruang Tindakan Pada Persalinan dengan Konsep Sayyidah Maryam, Booklet Kamar Bersalin Penerapan Konsep Sayyidah Maryam.

PROFIL PENULIS



Maratusholikhah Nurtyas, SST., M.Kes. Lulus D III Kebidanan dan D IV Bidan Pendidik di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta pada tahun 2010 dan 2012. Lulus S2 di Program Magister Kedokteran Keluarga, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017. Saat ini adalah dosen tetap di Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Respati Yogyakarta. Aktif melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendapatkan beberapa Hibah baik eksternal maupun internal. Hasil penelitian rutin dipublikasikan penulis tiap semester di Jurnal Nasional Terakreditasi dan Prosiding baik nasional maupun internasional. Beberapa modul dan buku sudah dipublikasikan, ber-ISBN dan mendapat Hki.



Erna Kusumawati, S.ST.M.Kes lahir di Semarang, 25 Maret 1980. Lulus DIII Kebidanan dari Akademi Kebidanan Depkes Semarang. Lulus DIV Bidan Pendidik dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Lulus S2 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Kajian Kesehatan Reproduksi HIV/ AIDS Universitas Diponegoro Semarang. Aktif sebagai anggota IBI, dan menjadi Praktek Mandiri Bidan sejak 2004 sampai sekarang. Aktif menulis artikel di jurnal nasional. Mengajar matakuliah Asuhan Kebidanan Persalinan, Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Asuhan Kebidanan Bayi, Balita dan Anak Pra sekolah. Karya buku yang dihasilkan Pijat Perinum Menuju Persalinan Yang Nyaman.



Siti Istiana, S.SiT.M.Kes lahir di Demak, 18 Februari 1985. Lulus DIII Kebidanan dari Akademi Kebidanan Pemkab Kudus. Lulus DIV Bidan Pendidik dari STIKES Ngudi Waluyo Ungaran Semarang. Lulus S2 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Kajian Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak Universitas Diponegoro Semarang. Aktif sebagai anggota IBI. Aktif menulis artikel di jurnal nasional. Mengajar matakuliah asuhan kebidanan perempuan dan anak dalam kondisi rentan, kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, asuhan kebidanan pra nikah dan pra konsepsi. Karya buku yang dihasilkan deteksi dini kanker serviks dan payudara dan Pijat Perinum Menuju Persalinan Yang Nyaman.

SINOPSIS

Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan Sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, yaitu bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Dalam pengertian tersebut. Upaya peningkatan kualitas tidak saja kualitas remaja, akan tetapi juga kualitas keluarga dan keluarga pada masa mendatang karena remaja akan membentuk keluarga baru.

Kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu prioritas program kesehatan reproduksi di Indonesia, hal ini berdasar kejadian yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi remaja yang semakin meningkat dalam uraian dalam buku ini yaitu perilaku menyimpang pada remaja Masalah utama remaja Indonesia salah satunya yaitu masalah kesehatan yang berhubungan dengan gizi. Jika zat gizi seseorang kurang atau berlebih, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh sehingga menimbulkan masalah gizi. masalah gizi yang dialami remaja antara lain seperti gizi kurang, gizi lebih, anemia, obesitas, dan masalah yang berhubungan dengan gangguan perilaku makan berupa *anorexia nervosa* dan *bulimia nervosa*, selain itu permasalahan yang lain yaitu adanya perilaku penggunaan smartphone terhadap perilaku sexting remaja, sexting mengacu pada pengiriman dan penerimaan gambar secara seksual melalui beberapa bentuk pesan virtual yang dimana seseorang mengirimkan pesan atau materi berupa gambar dan video secara elektronik terutama melalui smartphone, internet dan media elektronik lainnya.

Berdasarkan survei kesehatan reproduksi remaja Indonesia ada empat perilaku bersiko yang terbesar dikalangan remaja Indonesia, salah satunya perilaku seks pranikah, perilaku merokok, minum alkohol, dan pemakaian narkoba. Buku ini memberikan gambaran hasil riset terkait permasalahan kesehatan reproduksi tersebut.

Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan Sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, yaitu bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Dalam pengertian tersebut. Upaya peningkatan kualitas tidak saja kualitas remaja, akan tetapi juga kualitas keluarga dan keluarga pada masa mendatang karena remaja akan membentuk keluarga baru.

Kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu prioritas program kesehatan reproduksi di Indonesia, hal ini berdasar kejadian yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi remaja yang semakin meningkat dalam uraian dalam buku ini yaitu perilaku menyimpang pada remaja Masalah utama remaja Indonesia salah satunya yaitu masalah kesehatan yang berhubungan dengan gizi. Jika zat gizi seseorang kurang atau berlebih, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh sehingga menimbulkan masalah gizi. masalah gizi yang dialami remaja antara lain seperti gizi kurang, gizi lebih, anemia, obesitas, dan masalah yang berhubungan dengan gangguan perilaku makan berupa anorexia nervosa dan bulimia nervosa, selain itu permasalahan yang lain yaitu adanya perilaku penggunaan smartphone terhadap perilaku sexting remaja, sexting mengacu pada pengiriman dan penerimaan gambar secara seksual melalui beberapa bentuk pesan virtual yang dimana seseorang mengirimkan pesan atau materi berupa gambar dan video secara elektronik terutama melalui smartphone, internet dan media elektronik lainnya.

Berdasarkan survei kesehatan reproduksi remaja Indonesia ada empat perilaku bersiko yang terbesar dikalangan remaja Indonesia, salah satunya perilaku seks pranikah, perilaku merokok, minum alkohol, dan pemakaian narkoba. Buku ini memberikan gambaran hasil riset terkait permasalahan kesehatan reproduksi tersebut.

ISBN 978-623-88659-5-6



**Anggota IKAPI
No. 624/DKI/2022**

Penerbit :

**PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919**